

SRH Hochschule Heidelberg
Fakultät für Angewandte Psychologie
Staatlich anerkannte Hochschule

Master-Thesis
zur Erlangung des akademischen Grades
Master of Science Psychologie

Thema:
**Einfluss der Religiosität auf das psychische Wohlbefinden unter
Berücksichtigung des kulturellen Hintergrundes**

Eingereicht von: Teresa Seidl Fernández
Matrikelnummer: 11013160
Gruppennummer: 63742201

Studiengangsleiter: Prof. Dr. Andrés Steffanowski
Betreuende Dozentin: M.Sc. Claudia Farrenkopf

Heidelberg, den 9. August 2024

Zusammenfassung

Die vorliegende Studie untersucht den Zusammenhang zwischen Religiosität und Wohlbefinden sowie die moderierende Rolle der kulturellen Orientierung und des Geschlechts. Die Hypothesen besagen, dass (1) Religiosität positiv mit Wohlbefinden korreliert, (2) kulturelle Orientierung diese Beziehung moderiert und (3) das Geschlecht einen moderierenden Einfluss auf diese Beziehung hat. Die Befragung erfolgte mittels eines anonymen Online-Fragebogens unter Verwendung der deutschen Version der Religious Commitment Scale, dem Duke University Religion Index (DUREL), dem WHO-5 Fragebogen zum Wohlbefinden und der Cultural Orientation Scale (COS). Diese Fragebögen waren auf Deutsch, Englisch und Spanisch verfügbar. Die Stichprobe ($N = 429$) bestand zu über 70% aus Frauen, fast 90% der Teilnehmenden stammten aus Europa und mehr als 70% waren Katholiken. Das Durchschnittsalter der Teilnehmenden betrug knapp 48 Jahre. Die Ergebnisse der einfachen Regression zeigen, dass Religiosität einen signifikanten positiven Einfluss auf das psychische Wohlbefinden hat ($R^2 = .05$, $F(1, 427) = 23.1$, $p < .001$). Eine Moderationsanalyse ergab keinen signifikanten Einfluss der kulturellen Orientierung auf die Beziehung zwischen Religiosität und Wohlbefinden ($\Delta R^2 = 0.61\%$, $F(1, 414) = 2.44$, $p = .119$). Eine weitere Moderationsanalyse zeigt jedoch einen signifikanten Einfluss des Geschlechts auf die Beziehung zwischen Religiosität und Wohlbefinden ($\Delta R^2 = 1.02\%$, $F(1, 423) = 4.64$, $p = .036$), dass aufzeigt, dass Geschlechterunterschiede in ihrer Wirkung der Religiosität auf das Wohlbefinden berücksichtigt werden sollten. Ein explorativer t-Test zeigt, dass Personen mit Migrationshintergrund einen höheren Wert an Religiosität aufwiesen, $t(427) = 2.23$, $p = .026$, 95% CI [0.03, 0.47] und eine explorative ANOVA zeigt, dass sich die kulturelle Orientierung signifikant zwischen den Religionen unterscheidet, $F(9, 407) = 9.22$, $p < .001$, $\eta^2 = .17$.

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	5
Tabellenverzeichnis	6
1 Einleitung	7
2 Theorie	9
2.1 Konstrukte	9
2.1.1 Religion und Religiosität	9
2.1.1.1 Auswirkung der Religiosität auf die Gesundheit	12
2.1.2 Kultur	14
2.1.2.1 Operationalisierung von Kultur	15
2.1.2.2 Auswirkung der Kultur auf die Gesundheit	17
2.1.3 Wohlbefinden	18
2.1.3.1 Biopsychosoziales Modell	21
2.2 Aktueller Forschungsstand	22
2.2.1 Hypothese 1	22
2.2.2 Hypothese 2	24
2.2.3 Hypothese 3	25
3 Methoden	27
3.1 Stichprobenbeschreibung	27
3.2 Untersuchungsdesign	28
3.3 Operationalisierung der Konstrukte	29
3.4 Untersuchungsdurchführung	31
3.5 Auswertungsmethode	32
4 Ergebnisse	34
4.1 Deskriptive Ergebnisse	34
4.2 Inferenzstatistische Ergebnisse	35

4.2.1	Hypothese 1	35
4.2.2	Hypothese 2	36
4.2.3	Hypothese 3	37
4.3	Explorative Ergebnisse	39
4.3.1	Einfluss von Migration auf die Religiosität	39
4.3.2	Unterschied kultureller Orientierung bei den Religionen	40
5	Diskussion	42
5.1	Zusammenfassung der zentralen Ergebnisse	42
5.2	Einordnung und Diskussion der Befunde	44
5.3	Bewertung der Methode	46
5.4	Ausblick	48
	Literaturverzeichnis	52
	Anhang A	60
	Anhang B	61
	Anhang C	62
	Anhang D	64
	Anhang E	65
	Anhang F	66
	Anhang G	67
	Anhang H	68
	Anhang I	69
	Anhang J	70

Abbildungsverzeichnis

<i>Abbildung 1.</i>	Histogramm Altersverteilung	27
<i>Abbildung 2.</i>	Moderationseffekt des Geschelchts auf die Beziehung von Religiosität und Wohlbefinden	38

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1.	<i>Einfache lineare Regression von Religiosität auf psychisches Wohlbefinden</i>	35
Tabelle 2.	<i>Moderationsanalyse Religiosität und kulturelle Orientierung auf das psychische Wohlbefinden</i>	36
Tabelle 3.	<i>Modell mit Haupteffekten</i>	37
Tabelle 4.	<i>Moderationsanalyse Religiosität und biologisches Geschlecht auf das psychische Wohlbefinden</i>	37
Tabelle 5.	<i>Tukey HSD Post-hoc Tests für kulturelle Orientierung nach Religion . .</i>	40

1 Einleitung

In den letzten 120 Jahren hat sich in Europa die Verteilung der Religiosität verändert. Während im Jahr 1900 noch 99,6% der europäischen Bevölkerung religiös war, hat sich diese Zahl bis 2020 auf 84,4% reduziert (Zurlo, 2021). Gleichzeitig ist in den letzten Jahrzehnten die Prävalenz psychischer Erkrankungen, wie beispielsweise chronischer Depression, gestiegen (European Union, 2021). Dieser Anstieg psychischer Problematiken ist teilweise darauf zurückzuführen, dass psychische Erkrankungen heute weniger tabuisiert sind und offener darüber gesprochen wird, was somit die Diagnosehäufigkeit ansteigen lässt. Zudem werfen diese gegenläufigen Trends die Frage auf, ob und wie Religiosität das psychische Wohlbefinden beeinflusst.

Religion spielt seit jeher eine zentrale Rolle im menschlichen Leben und bietet vielen Menschen nicht nur moralische Orientierung, sondern auch emotionale Unterstützung und sozialen Halt (Hemel, 2023; Jakobs, 2018). Dennoch bildet die Auseinandersetzung mit Religion in der Psychologie bisweilen eine große Lücke (Cohen, 2015). Insbesondere fehlt es an einer umfassenden Betrachtung, die sowohl die positiven als auch die potenziell negativen Auswirkungen von Religiosität auf die psychische Gesundheit in den Blick nimmt.

Ein weiterer wesentlicher Aspekt, der oft vernachlässigt wird, ist der kulturelle Hintergrund der Individuen. Kultur beeinflusst nicht nur die Art und Weise, wie Religion praktiziert wird, sondern auch, wie Menschen psychisches Wohlbefinden erleben und definieren. Es ist daher notwendig, diese beiden Faktoren – Religiosität und Kultur – in ihrer Wechselwirkung zu betrachten, um ein umfassenderes Verständnis ihrer Auswirkungen auf die psychische Gesundheit zu gewinnen. Hardy, Nelson, Moore und King (2019) beispielsweise betonen, dass die Rolle der Kultur in zukünftigen Forschungen zur Wechselwirkung zwischen Religiosität und psychischem Wohlbefinden mehr Beachtung finden sollte.

Die vorliegende Studie zielt darauf ab, die Religiosität der Befragten, deren Maß an psychischem Wohlbefinden zum Zeitpunkt der Bearbeitung des Fragebogens sowie ihren kulturellen Hintergrund zu untersuchen. Zu Beginn werden die einzelnen Konstrukte Religion und Religiosität, Kultur und Wohlbefinden erläutert und der theoretische Hintergrund sowie die daraus abgeleiteten Hypothesen vorgestellt. In den darauffolgenden Kapiteln wird auf die Methoden der Studiendurchführung sowie auf die Ergebnisse eingegangen. In der abschließenden Diskussion erfolgt eine umfassende Bewertung der

Ergebnisse sowie ein Ausblick auf den weiteren Forschungsbedarf in diesen Themengebieten.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in dieser Arbeit die Sprachform des generischen Maskulinums verwendet. An dieser Stelle wird darauf hingewiesen, dass die ausschließliche Verwendung der männlichen Form geschlechtsunabhängig verstanden werden soll.

2 Theorie

In diesem Kapitel werden zunächst die verwendeten Konstrukte Religion und Religiosität, psychisches Wohlbefinden und anschließend die Kultur erläutert. Abschließend folgt eine theoretische Herleitung der einzelnen Hypothesen.

2.1 Konstrukte

Beginnend wird in Kapitel 2.1.1 Religion und Religiosität präsentiert und welche Auswirkung Religiosität auf die Gesundheit hat. In Kapitel 2.1.2 wird Kultur, wie sie im Rahmen dieser Studie zu verstehen ist, erklärt, ihre Interaktion mit den anderen beiden Konstrukten aufgezeigt und ihre Auswirkung auf die Gesundheit näher gebracht. Im abschließenden Kapitel 2.1.3 wird erläutert was psychisches Wohlbefinden ist und welche untergeordneten Konstrukten dazu gehören. Des Weiteren stellt es ein Modell, das die Entstehung und Aufrechterhaltung von Wohlbefinden erklärt, vor.

2.1.1 Religion und Religiosität

Im Rahmen dieser Arbeit wird bei der Darstellung von Religion, ihren Inhalten und Auslegungen, sowie der Religiosität ein Schwerpunkt auf Europa und das Christentum gelegt. Dennoch werden auch Aspekte anderer Religionen und Regionen der Welt berücksichtigt.

Die Definition von Religion ist in der Wissenschaft umstritten. Einige stellen die Frage, ob der Begriff überhaupt eine stabile Kategorie menschlicher Erfahrung beschreibt (Griffiths, 2000; Monroe et al., 2023). Es gibt jedoch viele Definitionen, die sich auf unterschiedliche Aspekte fokussieren. The Britannica Dictionary (2024) bietet zwei mögliche Definitionen: (a) Religion als Glaube an einen Gott oder eine Gruppe von Göttern; und (b) Religion als ein organisiertes System von Glaubensvorstellungen, Zeremonien und Regeln zur Verehrung eines Gottes oder einer Gruppe von Göttern. Selbst die Etymologie des Wortes Religion hat mehrere Ursprünge, die laut dem Bowker (2003) jedoch auf ein gemeinsames Merkmal hinweisen: Religion hilft Menschen, die Welt zu verstehen und sich im Leben zu orientieren (Schneider & Toyka-Seid, 2024a).

Historische Entwicklungen belegen die tiefe Verwurzelung spiritueller Rituale und Überzeugungen in der menschlichen Geschichte. Bereits vor 12.000 Jahren errichteten frühe Jäger und Sammler beeindruckende Monumente wie Göbekli Tepe, die ältesten

bekannten Großbauten der Menschheit und mögliche Bergheiligtümer, was auf eine weit zurückreichende Glaubenskultur hinweist (Joseph., 2011). Über Jahrtausende hinweg haben Menschen in verschiedensten Regionen diverse Religionssysteme entwickelt und mit diesen erfolgreich gelebt (Bowker, 2003). Im Jahr 2024 zählen sich etwa 84% der Weltbevölkerung einer Religion zugehörig, unabhängig davon, wie viel oder wenig sie aktiv daran teilnehmen (World Population Review, 2024). Dies verdeutlicht die anhaltende Bedeutung von Religion und Spiritualität für das individuelle und soziale Leben.

Aus soziologischer Sicht haben Religionen schon immer einen erheblichen Wert besessen, da sie als hoch organisiertes Schutzsystem das Überleben und die Selektion einer Gruppe fördern. Die Evolutionspsychologie unterstützt diese Sichtweise und zeigt, dass Religion und Spiritualität möglicherweise evolutionäre Vorteile bieten, indem sie durch soziale Bindungen und Vertrauen das Überleben der Personen begünstigen. Rituale und religiöse Praktiken können als aufrichtige Signale betrachtet werden, die die Kooperation und den Zusammenhalt innerhalb von Gemeinschaften stärken (Norenzayan & Shariff, 2008). Dies trägt zur Erhöhung des individuellen Wohlbefindens und der sozialen Stabilität bei.

Organisierte Religion umfasst Religionsgemeinschaften mit einem einheitlichen und förmlich festgelegten Glaubenssystem und Ritualen. Das Hauptziel organisierter Religion ist oft die Vereinigung von Gläubigen. Diese Systeme und Rituale sind durch offizielle Doktrin, hierarchische Führung und Kodifizierung von Verhaltensweisen (Dogmen) festgelegt. Im Gegensatz dazu glauben Anhänger nichtorganisierter Religionen an Gott oder eine höhere Macht, ohne einer organisierten Religion zuzugehören. Sie umfassen moderne Spiritualitätsformen (Köhrsen, 2024).

Religion bezieht sich auf die äußere Beschreibungsebene, während Religiosität das innere Erleben beschreibt (Allolio-Näcke & Demmrich, 2022). Organisierte Religiosität umfasst Praktiken, die in einem sozialen Umfeld gelebt werden, wie die Teilnahme an religiösen Gruppenritualen, beispielsweise Gottesdiensten. Nichtorganisierte Religiosität beinhaltet private Praktiken wie Gebet zu Hause, Meditation und das Hören religiöser Musik (Koenig & Büssing, 2010; Koenig, VanderWeele & Peteet, 2024). Außerdem wird zwischen der intrinsischen und extrinsischen Religiosität unterschieden. Die intrinsische Religiosität wird aus innerer Überzeugung heraus gelebt, mit dem Ziel der spirituellen Verbundenheit und persönlichem Wachstum. Extrinsische Religiosität dient als Mittel zum Erreichen weltlicher Ziele wie finanzieller Erfolg oder sozialer Status (Koenig & Büssing, 2010).

Spiritualität ist ein komplexes Konzept, das durch eine wahrgenommene Verbundenheit zum Heiligen oder Transzendenten charakterisiert ist. Sie geht über das hinaus, was Menschen sehen oder verstehen können und beinhaltet existenzielle Fragen wie den Sinn des Lebens (Koenig, 2010). Religion hingegen ist ein System spezifischer Anschauungen und Praktiken, die sich auf heilige Dinge beziehen und oft institutionell organisiert sind (Durkheim, 1981). Die Verbindung von Spiritualität und Religion zeigt sich darin, dass Spiritualität sowohl innerhalb als auch außerhalb von Religion existieren kann (Büssing, 2008).

Wie unterscheiden sich Religion und Spiritualität nun genau? Verschiedene Modelle versuchen zu erklären, wie diese beiden Konzepte miteinander interagieren. Ein Ansatz sieht Spiritualität eng verbunden mit dem Übernatürlichen und Religiösen (Koenig, 2010). Nach dieser Definition ist die Suche nach dem Transzendenten ein Teil der Spiritualität. Ein Nichtgläubiger kann durch Spiritualität zum Hinterfragen, dann zum Glauben und schließlich zur Hingabe gelangen.

Dieses Verständnis von Spiritualität findet sich im traditionellen Modell von Koenig et al. (2024). In diesem Modell ist Spiritualität ein Teil von Religion und Religiosität. Hier dient das Wort *spirituell* zur Beschreibung einer tief religiösen Person. Im moderneren Verständnis hat sich die Bedeutung von Spiritualität jedoch erweitert. Sie umfasst nun sowohl Personen, die sich als religiös bezeichnen, als auch jene, die sich nicht als religiös empfinden, aber trotzdem als spirituell sehen. Dieser Wandel hat zu Herausforderungen bei der Definition und Abgrenzung von Spiritualität geführt. Es ist wichtig, Spiritualität so zu definieren, dass Personen, die sich als spirituell, aber nicht religiös identifizieren, nicht vernachlässigt werden. Letztlich bleibt es eine Aufgabe, Spiritualität so zu operationalisieren, dass beide Gruppen angemessen repräsentiert werden.

Die Religion gibt vielen Menschen Sinn und Zweck im Leben. Selbst in stark säkularisierten Regionen wie Westeuropa, wie vom Pew Research Center (2022) berichtet, gaben im Median 39% der Befragten an, dass Religion ihnen dieses Gefühl vermittele. Zudem biete sie Trost in Zeiten der Trauer und moralische Orientierung bei schwierigen Entscheidungen. Eine weitere Studie des Pew Research Center (2019) untersuchte, ob Religion eine positive, negative oder gemischte Assoziation mit verschiedenen Indikatoren des individuellen und gesellschaftlichen Wohlbefindens aufweist. Regelmäßige Teilnahme an Aktivitäten einer Religionsgemeinschaft ist in den USA und anderen Ländern mit höherer Zufriedenheit verbunden. Ein Rückgang des religiösen Engagements könnte zu einem

Rückgang des individuellen und gesellschaftlichen Wohlbefindens führen (Pew Research Center, 2019).

Schutzsysteme sind essenziell für die Sicherheit und Gewissheit der Menschen, wodurch sie ihre Interessen und Bedürfnisse verfolgen können. Religionen bieten verschiedene Herangehensweisen, um diese Sicherheit zu gewährleisten, wobei der Fokus je nach Religion und Kultur unterschiedlich ist.

Im Buddhismus liegt der Schwerpunkt auf dem Inneren des Menschen, wobei Achtsamkeit und Meditation zentrale Praktiken sind, um Erleuchtung und inneren Frieden zu erreichen. Ziel ist es, das Potenzial von Körper und Geist zu erkennen und zu entfalten. Andere Religionen betonen das Äußere und die Bedeutung zwischenmenschlicher Beziehungen sowie die Gemeinschaft mit Gott. Judentum, Christentum und Islam sind Beispiele für Religionen, die göttliche Unterstützung betonen und *das Böse* definieren. Sie untersuchen die Qualität der Beziehung zu sich selbst, zu Mitmenschen und zu Gott.

Religionen vermitteln wichtige Lehren und dienen als moralischer Kompass, indem sie sowohl nach innen als auch nach außen gerichtete Ansätze berücksichtigen, mit unterschiedlichem primären Fokus. Somit fungieren sie als Schutzsysteme, die wesentliche Aspekte des menschlichen Lebens und Wohlbefindens bewahren. Insgesamt bieten Religionen nicht nur spirituelle Orientierung, sondern unterstützen auch das menschliche Leben in seiner gesamten Komplexität (Bowker, 2003).

2.1.1.1 Auswirkung der Religiosität auf die Gesundheit

Religionen basieren auf einer eigenen, spezifischen religiösen Logik und beschäftigen sich mit grundlegenden, aber nicht abschließend beantworteten Fragen. Diese umfassen Themen wie die Stellung des Menschen in der Welt, was nach dem Tod geschieht und die Definition eines „guten Lebens“ sowie moralische Pflichten gemäß den Werten der spezifischen Religionsgemeinschaft. Aufgrund dessen haben Religionen einen erheblichen Einfluss auf Erziehung, Bildung, Handeln und auch auf die Gesundheit und gesundheitsrelevantes Verhalten. Sie bieten ihren Anhängern eine umfassende Weltanschauung, die durch ein komplexes System von Symbolen, Geschichten und Lehren geprägt ist. Diese Symbole und Geschichten dienen als Mittel, um tiefgehende Fragen des Lebens, die Natur des Göttlichen und die moralischen Prinzipien zu verstehen. Durch diese symbolische Deutung der Welt gewinnen die Gläubigen eine klare Perspektive und ein tieferes Verständnis ihrer Existenz. Zusätzlich umfassen sie eine Vielzahl spezifischer

religiöser Praktiken, die darauf abzielen, den Menschen Orientierung, Sinn und Halt im Leben zu geben. Diese Symbole und Geschichten, die oft als eine lebensprägende Narration dienen, haben häufig eine direkte Bedeutung für den Alltag der Gläubigen und beeinflussen ihr Verhalten sowie ihre Entscheidungen. Dazu gehören Vorstellungen von der „richtigen“ sozialen Ordnung, Anstand und Moral, Machtverhältnissen sowie Selbst- und Weltbilder. Zudem prägen Religionen auch körper- und geschlechtsbezogene Rollenbilder sowie Ansichten zu Ernährung und Sexualität (Hemel, 2023).

Die Beziehung zwischen Religiosität und Gesundheit ist jedoch komplex und ambivalent. Es gibt sowohl positive als auch negative Auswirkungen, die in der wissenschaftlichen Literatur diskutiert werden. Unumstritten ist, dass schon bevor der Mensch Psychosomatik als solche definierte, in religiösen Weltansichten die körperliche und seelische Gesundheit als verbunden betrachtet wurde und wird. Sowohl Hemel (2023) als auch Jakobs (2018) betonen, dass Religiosität positive Effekte wie die Förderung sozialer Unterstützung, Gemeinschaft und Sinnstiftung hat. Diese soziale Unterstützung wiederum hat positive Effekte auf die Gesundheit. Außerdem verstärkt Religiosität die emotionale und behaviorale Selbstregulation, was zu einem besseren Gesundheitsverhalten und günstigeren physiologischen Prozessen führt. Diese Effekte tragen dazu bei, die Häufigkeit von Erkrankungen zu reduzieren und die Mortalität zu senken. Religiöse Überzeugungen können Menschen helfen, Krisen zu bewältigen und dem Leben einen tieferen Sinn zu geben. Andererseits können strikte religiöse Normen zu Schuldgefühlen und Angst führen, und extreme religiöse Praktiken können soziale Isolation und psychische Belastungen verursachen (Krause, 2015).

Hemel (2023) hebt hervor, dass soziokulturelle Praktiken, die durch Religion vermittelt werden, insbesondere bei Frauen Schutz und Unterstützung bieten können, aber auch restriktive Normen und Rollenbilder die Autonomie und das Wohlbefinden beeinträchtigen können.

Jakobs (2018) konzentriert sich auf die individuelle religiöse Erfahrung und deren Bedeutung für die allgemeine psychische Gesundheit. Er unterstreicht, dass eine positive Religionspädagogik die positiven Effekte der Religiosität verstärken kann. Zusätzliche spezifische negative Effekte gegenüber den allgemeinen Aussagen führt Jakobs nicht an.

Krause (2015) beschreibt, dass das Gebet als häufige Form der spirituellen Praxis sowohl positive als auch negative Auswirkungen auf die psychische Gesundheit haben kann. Positive Auswirkungen umfassen die Förderung von Wohlbefinden und die Reduktion von Stress. Negative Auswirkungen können auftreten, wenn Gebete von Angst und Hader

geprägt sind oder wenn sie als einzige Bewältigungsstrategie verwendet werden, ohne andere unterstützende Maßnahmen zu ergreifen. Seybold und Hill (2001) zeigen, dass religiöse Praktiken das Auftreten von Herzerkrankungen, Bluthochdruck, Infarkten und Schmerzen verringern und das Langzeitüberleben fördern können. Hoffnung ist ein wichtiger Faktor für das psychische Wohlbefinden und wirkt als Puffer gegen psychische Erkrankungen. Sie hängt mit einem höheren Selbstwertgefühl, mehr positiven Gefühlen und einem besseren subjektiven Wohlbefinden zusammen. In Zeiten von Krankheit und Krisen stellt Hoffnung eine wertvolle Ressource dar (Krause, 2015).

2.1.2 Kultur

Was ist Kultur? Bowker (2003) beschreibt Kultur als zweite Schutzhaut des Replikationsprozesses. Wir Menschen sind als Lebewesen darauf ausgerichtet, unsere Spezies am Leben zu erhalten. Jene mit guten Genen überleben besser und pflanzen sich vermehrt fort als solche mit nachteiligen Genen. In seiner Erklärung, was Kultur ist, beschreibt Bowker (2003) unsere Haut als den ersten Schutzmechanismus für den Genreplikationsprozess. Da wir jedoch soziale und intelligente Wesen sind, haben wir ein weiteres Verteidigungssystem implementiert, das sich außerhalb der Grenzen unseres Körpers befindet; die gemeinsamen kulturellen Errungenschaften. Die Kultur schützt uns demzufolge vor dem Aussterben. Religionen haben sich in den vielen, damals stark voneinander getrennte Kulturen sehr früh als System entwickelt, um die Gruppe zu erhalten. Wie lassen sich Religion und Kultur voneinander trennen? Es ist wichtig festzuhalten, dass sie sich gegenseitig beeinflussen können und dies auch tun. Stark säkulare¹ Länder und Kulturen lassen durch ihre säkularen Institutionen und Angebote Religion weniger notwendig erscheinen (Cohen, 2015). Wie Durkheim (1915) Religion definiert, ist sie von der Kultur nicht zu trennen, da ihre Überzeugungen und Praktiken kulturell geprägt sind. Vor vielen Jahrhunderten diktierten die Religionsoberhäupter in Europa die Politik, wie beispielsweise die Päpste die Politik der Könige im Mittelalter, was zeigt, wie eng religiöse Institutionen und politische Macht verflochten waren. Kultur prägt politische Werte und Normen, während Politik kulturelle Identitäten nutzt, um Herrschaft zu legitimieren und soziale Ordnung zu schaffen. Noch heute ist dies in anderen Staaten der Welt noch der Fall, wie beispielsweise in Indien oder dem Iran. Basierend auf dieser Beobachtung ist es nachvollziehbar, dass Kultur und Religion sehr

¹Trennung von Kirche und Staat

eng miteinander verwoben sind. Die enge Verknüpfung zwischen Kultur und Religion ist nicht spezifisch auf eine Religion beschränkt. Im Christentum sowie im Buddhismus und den anderen Weltreligionen prägen die religiöse Philosophie die Kultur und umgekehrt (Croucher, Zeng, Rahmani & Sommier, 2017). Doch gilt dieser Grundsatz noch immer? In Europa beispielsweise begann Ende des 17. Jahrhunderts mit der geistigen Bewegung der Aufklärung und der späteren Französischen Revolution die Säkularisierung. Die radikale Enteignung von Klöstern, Ordensgemeinschaften und weiteren Kirchengütern durch den Staat sind einige Beispiele der Maßnahmen zur Verweltlichung des Landes (Schneider & Toyka-Seid, 2024b). Da die Kirche jedoch in vielen Ländern Europas, aber auch darüber hinaus, noch einen großen Einfluss besitzt, scheint der Prozess noch nicht abgeschlossen zu sein, der jedoch weiter voranstreitet, wie die abnehmende Mitgliederentwicklung in den Religionen und die Zunahme der Konfessionsfreien zeigt (Forschungsgruppe Weltanschauungen in Deutschland, 2021). Im 20. Jahrhundert stieg die Individualisierung der Gesellschaft stark an. Spätestens mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten im Deutschen Reich 1933 verloren jüdische Institutionen ihre Autorität; christliche Institutionen folgten diesem Trend spätestens seit den 1950er Jahren. Dies hat jedoch der Religion nicht die wichtige Rolle entzogen, in schwierigen und schmerzhaften Zeiten eine Quelle der Kraft und des Haltes zu sein (Croucher et al., 2017). Obwohl Religion und Kultur interagieren, heißt es nicht, dass sie das Gleiche abbilden, oder das Gleiche aussagen. In multikulturellen und multireligiösen Staaten oder Regionen umfasst keine Religion die gesamte Gesellschaft während diese sich nicht ausschließlich nach religiösen Vorschriften und Praktiken richtet. Dennoch ist es sinnvoll, die beiden Sphären als miteinander verbunden zu betrachten und ihre Wechselwirkungen zu analysieren (McGlichey, Waters & Scheinpflug, 2023).

2.1.2.1 Operationalisierung von Kultur

Wenn Kultur und Religion nicht eindeutig voneinander trennbar sind, wie lässt sich dann Kultur beobachten? Hofstede (2001) entwickelte sechs Kulturdimensionen, mit denen sich unterschiedliche Kulturen vergleichen und beschreiben lassen. Dafür definierte er Kultur vereinfacht als „Software des Geistes“ (Hofstede, 2001, S. 209). Laut ihm setzt sich eine Kultur aus diesen nachfolgenden sechs Dimensionen zusammen und ermöglicht es, Kulturen zu vergleichen.

Die *Machtdistanz* beschreibt die Akzeptanz der Machtverteilung. In Kulturen

mit hoher Machtdistanz werden starke Hierarchien akzeptiert, in denen beispielsweise Führungskräfte Entscheidungen treffen, die nicht in Frage gestellt werden. Im Gegensatz dazu zeichnen sich Kulturen mit einer niedrigen Machtdistanz durch flache Hierarchien aus, in denen Menschen eher auf gleicher Augenhöhe miteinander interagieren (Knecht, 2020).

Die zweite Dimension, der *Individualismus* beschreibt die Stärke der zwischenmenschlichen Beziehungen innerhalb einer Kultur. In individualistisch geprägten Gesellschaften sind diese Bindungen eher locker, wobei das Individuum im Mittelpunkt steht. Im Gegensatz dazu steht in kollektivistischen Kulturen das Kollektiv im Vordergrund, wobei Loyalität, Fürsorge und Harmonie wichtige Merkmale sind (Knecht, 2020).

Maskulinität stellt die dritte Dimension dar und beschreibt das Ausmaß, in dem eine Kultur die traditionelle Aufteilung der Geschlechterrollen akzeptiert. In maskulinen Gesellschaften sind diese Rollen klar definiert, während in femininen Kulturen die Rollen flexibler sein können. Darüber hinaus zeichnen sich maskuline Kulturen durch Betonung von Status, Macht und Prestige aus, während feminine Kulturen eher von Fürsorge und Empathie geprägt sind (Knecht, 2020).

Die *Unsicherheitsvermeidung* beschreibt das Ausmaß, in dem eine Gesellschaft Risiken scheut und sich gegenüber Veränderungen und Innovationen zurückhaltend verhält. Kulturen mit hoher Unsicherheitsvermeidung bevorzugen bewährte Muster und versuchen, Unsicherheiten durch Regeln und Vorschriften zu minimieren (Knecht, 2020).

Die fünfte Dimension *Langzeitorientierung* beschreibt, ob eine Kultur dazu neigt, langfristige Ziele zu planen und zu verfolgen oder eher spontan und kurzfristig handelt und denkt (Knecht, 2020).

Die sechste und letzte Dimension, der *Genuss*, zeigt an, inwieweit eine Kultur die Selbstverwirklichung jedes Einzelnen akzeptiert. In Kulturen mit hoher Ausprägung werden auch Randgruppen oder Menschen, die nicht dem Mainstream entsprechen, akzeptiert und die Freiheit wird als wichtiger Wert angesehen. In Kulturen mit niedriger Ausprägung sind die Regeln und Normen hingegen strikter (Knecht, 2020).

Wilczewski et al. (2023) und weitere nutzen die Individualismus-Kollektivismus Dimension, um Kulturen in wissenschaftlichen Studien zu vergleichen. Wie bereits in der kurzen Beschreibung der Dimension geschildert, bildet sie die Beziehung des Individuums zur Gesellschaft ab. Steht das Individuum in einer engen Beziehung zu anderen, entspricht dies dem Kollektivismus. Ist die Beziehung zwischen Individuum und anderen

Gesellschaftsmitgliedern loser, dann entspricht dies dem Individualismus (Hofstede, 2001). Individualismus bedeutet aber nicht Egoismus, sondern vielmehr, dass das Individuum eigene Entscheidungen trifft (Hofstede, 2024). Ein Beispiel dafür sind die USA, in denen die Unabhängigkeit und Autonomie des Individuums besonders wertgeschätzt werden (Utler, 2020). Auf der anderen Seite bedeutet Kollektivismus nicht Verbundenheit. Es ist viel mehr, dass jede Personen ihren Platz im Leben kennt, der durch die Gesellschaft bestimmt wird (Hofstede, 2024). China oder Pakistan sind Beispiele dafür, da hier das Individuum seine eigenen Ziele wie Karriere und Privateigentum hinter die Ziele der sozialen Gruppe stellt. Da dies für alle Mitglieder der Gesellschaft gilt, erhalten sie von ihr bedingungslose Unterstützung und Schutz. Auf familiärer Ebene steht die Kernfamilie aus Mutter, Vater, Kind für individualistische und die Großfamilie für kollektivistische Gesellschaften (Utler, 2020).

2.1.2.2 Auswirkung der Kultur auf die Gesundheit

Die Bedeutung und das Verständnis von Gesundheit, Krankheit und Wohlbefinden sind kulturell geprägt. Dies umfasst, wie Menschen ihre Gesundheit einschätzen, wie sie Symptome interpretieren und wie sie mit gesundheitlichen Herausforderungen umgehen. Diese Verhaltensweisen werden durch kulturelle Normen und Überzeugungen geprägt (Hernandez & Gibb, 2019; Weltgesundheitsorganisation Regionalbüro für Europa [WHO Europa], 2024). Die Kultur beeinflusst die Einstellungen, die Personen zu den verfügbaren Gesundheitsmaßnahmen wie Impfprogrammen oder Psychotherapie haben und wie sie auf solche Maßnahmen reagieren, wodurch die Kultur den Erfolg oder das Scheitern dieser Interventionen bestimmen kann (WHO Europa, 2024).

In vielen Kulturen werden psychische Leiden häufig stigmatisiert oder als körperliche Beschwerden interpretiert, was zu Verzögerungen bei der Suche nach professioneller Hilfe führen kann. Beispielsweise neigen kollektivistische Kulturen wie in China dazu, psychische Probleme zu verschweigen, was zu einer Unterbehandlung führen kann (Hernandez & Gibb, 2019). Da dem Individuum weniger Bedeutung beigemessen wird als beispielsweise der Familie, werden psychische Erkrankungen als Scheitern der Gruppe gesehen. Um das Ansehen der Familie nicht zu beschädigen, werden die Erkrankungen und Beschwerden oft verheimlicht (Karasz et al., 2019).

Auch für die Einrichtung von Gesundheitsdiensten und den Zugang zu diesen spielen kulturelle Prägungen eine große Rolle. Sie beeinflussen, welche Gesundheitsdienste

in Anspruch genommen werden und wie diese genutzt werden (WHO Europa, 2024). So wird im südostasiatischen Raum der Fokus eher auf das Wohl der Gemeinschaft gelegt als auf das Individuum, was sich auf die Gesundheitspraktiken und die Interaktion mit dem Gesundheitssystem auswirkt. In muslimischen Gesellschaften kann die Tabuisierung bestimmter Gesundheitsthemen die Gesundheitskompetenz und die Inanspruchnahme von Gesundheitsdiensten negativ beeinflussen (Wielga & Knospe, 2023).

Allerdings kann die Kultur einer Gemeinschaft deren Widerstandsfähigkeit stärken und zu einem besseren Wohlbefinden beitragen (WHO Europa, 2024). Des Weiteren können durch kulturelle Praktiken die Bindung zur Gemeinschaft gefördert werden. Gemeinschaften, die durch gemeinsame kulturelle Traditionen verbunden sind, bieten ihren Mitgliedern ein Gefühl der Zugehörigkeit und emotionaler Unterstützung. Die Gemeinschaft kann in Zeiten von Stress oder Krankheit soziale Unterstützung bieten, was die psychische Gesundheit schützt und stärkt. So konnte beispielsweise beobachtet werden, dass aufgrund der Begräbnisrituale des Stammes der Acholi in Uganda die Verbreitung von Ebola begrenzt werden konnte, während diese Krankheiten sich in angrenzenden Gebieten ohne diesen Ritualen stärker verbreiteten. (Hewlett & Hewlett, 2008).

2.1.3 Wohlbefinden

Die World Health Organization (WHO 1948) definiert „Gesundheit als einen Zustand vollkommenem körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens“ (S. 01). In Anlehnung an diese Definition hat der Begriff des Wohlbefindens zahlreiche Präzisierungsversuche durch verschiedene Disziplinen erfahren. Gesundheit und Wohlbefinden werden oft undifferenziert in einem Atemzug genannt. Trojan und Legewie (2001) argumentieren jedoch, dass Wohlbefinden im Unterschied zur Gesundheit einen äußerst komplexen subjektiven Bewusstseinszustand darstellt, der sich grundsätzlich einer direkten äußeren Beobachtung entzieht. Diese subjektive Dimension wird auch in der Beschreibung von Mayring (1991) deutlich, demzufolge Wohlbefinden durch vier Faktoren charakterisiert wird. Diese sind (a) die *Freiheit von Belastungen* im Sinne einer Abwesenheit subjektiver Belastungen, Krankheitssymptomen und negativer Gefühle; (b) das *Erleben von Freude im Alltag*, ausgedrückt durch kurzfristige positive Gefühle; (c) die *Zufriedenheit*, die aus dem Abwägen positiver und negativer Lebensaspekte resultiert; und (d) das *Empfinden von Glück*, das über den konkreten Moment hinausgeht und mit einem insgesamt positiven Lebensgefühl verbunden ist. Der subjektive Gesundheitszustand dient

auch als verlässliches Indiz für die objektive gesundheitliche Lage (Hornberg, 2016).

Die Definition des mehrdimensionalen Wohlbefindens ist komplex und interdisziplinär. Wissenschaftler im Bereich der Psychologie, Philosophie und Sozialwissenschaften haben verschiedene Definitionen aufgestellt, die im Kern jedoch auf einen gemeinsamen Nenner treffen. Wohlbefinden umfasst subjektive und objektive Dimensionen und beinhaltet sowohl individuelle Erfahrungen als auch den Vergleich der Lebensumstände mit sozialen Normen und Werten (Dhanabhakya & Sarath, 2023; Röhrle, 2023). Das vielschichtige Konstrukt umfasst emotionale, psychologische und soziale Dimensionen. Es beinhaltet positive Emotionen (wie Glück und Zufriedenheit), das Fehlen negativer Emotionen (wie Depression und Angst), eine hohe Lebenszufriedenheit und einen Zweck im Leben, Erfüllung und positives Funktionieren und Autonomie sowie positive Beziehungen und persönliches Wachstum (Dhanabhakya & Sarath, 2023; Sischka, Costa, Steffgen & Schmidt, 2020). Es schließt sowohl affektive Komponenten (positive und negative Gefühle) als auch kognitive Bewertungen (Lebenszufriedenheit) ein (Diener, Suh, Lucas & Smith, 1999; Nelson, Kushlev & Lyubomirsky, 2014). In der Psychologie wird Wohlbefinden allgemein als ein positiver und wünschenswerter Zustand betrachtet, im Gegensatz zu Unwohlsein, das als negativ und unerwünscht gilt (Lucas, 2016).

Positives emotionales Befinden gilt als Überbegriff für das subjektiv empfundene Wohlbefinden. Freude und Glück, die oft in Verbindung mit Wohlbefinden gebracht werden, sind verschiedene Erscheinungsformen dessen. Dabei wird zwischen aktuellen, situationsspezifischen emotionalen Zuständen, sogenannter *States*, und langandauernden, übergreifenden emotionalen Zuständen als Persönlichkeitseigenschaften, sogenannter *Traits*, differenziert. Freude wird als State verstanden (Mayring, 1991). Es ist ein emotionaler Zustand, der früh in der menschlichen Entwicklung auftritt. Durch soziale Interaktionen wird diese vertieft. Dieser Zustand ist gekennzeichnet durch Selbstvertrauen, Anerkennung, Zufriedenheit, Sicherheit und das Gefühl, geliebt zu werden (Izard, 1994). Glück hingegen besitzt sowohl eine State- als auch als Trait-Komponente. Auch Glück wird durch mehrere Faktoren beeinflusst. Hoffmann (1984) identifiziert unter anderem die Qualität menschlicher Beziehungen, schöpferische Kraft, Öffnung der Sinne, Erotik, Ruhe und Entspannung sowie die Bejahung von Leben und Sinnhaftigkeit des Lebens als wichtige Komponenten. Glück wird vielmehr als Trait verstanden, das über den Lebenslauf aufgebaut wird (Mayring, 1991).

In dieser Arbeit wird die subjektive Dimension des Wohlbefindens betrachtet. Das

subjektive Wohlbefinden (SWB) ist ein umfassender Begriff, der sowohl emotionale Reaktionen, Zufriedenheit in verschiedenen Lebensbereichen als auch allumfassende Lebenszufriedenheit umfasst. Dabei handelt es sich um eine weit gefasste Kategorie von Phänomenen, die die emotionalen Reaktionen der Menschen, die Zufriedenheit mit verschiedenen Lebensbereichen und die globalen Urteile über die Lebenszufriedenheit einschließt (Diener et al., 1999). Es wird stark mit der Selbstbestimmungstheorie von Deci und Ryan (2000) verknüpft, die drei zentrale menschliche Grundbedürfnisse betont: Autonomie, Kompetenz und soziale Eingebundenheit. Diese Bedürfnisse sind entscheidend für das Wohlbefinden, da ihre Befriedigung zu einem tiefen Gefühl von Vitalität, psychischer Gesundheit und Lebenszufriedenheit führt (Deci & Ryan, 2000; Ng et al., 2012). Davon wird von manchen Autoren das psychische Wohlbefinden (PWB) unterschieden. Es beinhaltet die allgemeine psychische Gesundheit und emotionale Stabilität, einschließlich der Abwesenheit von psychischen Störungen wie Depression und Angst. Aber auch positive psychologische Funktionen wie Selbstakzeptanz, Sinnhaftigkeit, persönliches Wachstum und Autonomie gehören dazu. Das PWB wird auch im Kontext von SWB als Teilmenge betrachtet, das es die allgemeine psychische Gesundheit und emotionale Stabilität umfasst. PWB kann als eine Dimension des SWB gesehen werden, da es stark auf den emotionalen und kognitiven Bewertungen des Individuums basiert (Maly-Motta, 2023). In der psychologischen Literatur werden SWB und PWB oft synonym verwendet, insbesondere wenn es darum geht, das allgemeine Wohlbefinden und die Lebenszufriedenheit zu bewerten. Beide Begriffe beziehen sich auf die persönliche Bewertung des eigenen Lebens und die Emotionen, die mit diesen Bewertungen verbunden sind (Diener et al., 1999). Die Autoren Das et al. (2020) diskutieren verschiedene Theorien des SWB, die von psychologischen Mechanismen beeinflusst werden. Diese Theorien betonen, wie sowohl interne als auch externe Faktoren das individuelle SWB beeinflussen, und integrieren Konzepte wie persönliches Wachstum, Zielerreichung und emotionale Zustände als wesentliche Bestandteile des PWB. Diener, Oishi und Lucas (2009) behandeln SWB umfassend und beschreiben es als kognitive und affektive Bewertungen des Lebens einer Person. Es wird oft in Verbindung mit Konzepten wie Lebenszufriedenheit und emotionalen Reaktionen auf Lebensereignisse untersucht, was zeigt, dass SWB und PWB häufig gleichsetzend verwendet werden.

2.1.3.1 Biopsychosoziales Modell

Das von Engel (1977) entwickelte biopsychosoziale Modell bietet einen umfassenden Rahmen zur Erklärung der Entstehung und Aufrechterhaltung von Gesundheit und Krankheit. Es integriert biologische, psychologische und soziale Faktoren und betont deren wechselseitige Beeinflussung. Während biologische Einflüsse die genetischen, neurobiologischen und physiologischen Grundlagen umfassen, beinhalten psychologische Einflüsse Kognition, Emotion und Verhalten. Soziale Einflüsse beziehen sich auf soziale Netzwerke, kulturelle Werte und gesellschaftliche Strukturen. Diese ganzheitliche Perspektive ermöglicht es, komplexe Gesundheitsprobleme besser zu verstehen (Borrell-Carrió, Suchman & Epstein, 2004).

Biologische Einflüsse: Wohlbefinden hat einen inneren und instrumentellen Wert und ist integraler Bestandteil der Gesundheit. Biologische Faktoren spielen eine entscheidende Rolle für das psychische Wohlbefinden. Genetische Veranlagungen, neurobiologische Mechanismen, Hormonspiegel und körperliche Gesundheit beeinflussen, wie Menschen auf Stress und Lebensereignisse reagieren. Beispielsweise können chronische Krankheiten, hormonelle Ungleichgewichte oder neurochemische Dysfunktionen das Wohlbefinden beeinträchtigen und zu psychischen Gesundheitsproblemen führen (Kiecolt-Glaser, McGuire, Robles & Glaser, 2002; Sapolsky, 2004).

Psychologische Einflüsse: Psychologische Faktoren wie individuelle Bewältigungsstrategien, Selbstwirksamkeit und emotionale Intelligenz beeinflussen ebenfalls das Wohlbefinden. Resilienz spielt eine wichtige Rolle, obwohl Menschen, die widrigen Umständen ausgesetzt sind, einem höheren Risiko für psychische Gesundheitsprobleme ausgesetzt sind. Die Fähigkeit, mit Stress umzugehen und sich von Rückschlägen zu erholen, hängt stark von den kognitiven und emotionalen Ressourcen ab, die eine Person mobilisieren kann (Bandura, 1997; Carver, 2010).

Soziale Einflüsse: Äußere Anforderungen und kritische Lebensereignisse können das Wohlbefinden beeinträchtigen. Die subjektive Wahrnehmung und Bewertung dieser Ereignisse spielen eine entscheidende Rolle für das individuelle Wohlbefinden. Stressoren, die als bedrohlich oder belastend wahrgenommen werden, können zu einer Verschlechterung des subjektiven Wohlbefindens führen, was sich in physischen und psychischen Gesundheitsproblemen manifestieren kann. Darüber hinaus sind soziale Unterstützung und stabile Beziehungen wichtige Ressourcen, die das Wohlbefinden stärken und die Resilienz gegenüber Stress erhöhen können (Lazarus & Folkman, 1987;

Pearlin, 2010; Uchino, 2006). Kultur und Religiosität sind wesentliche soziale Faktoren, die das Wohlbefinden beeinflussen können. Diese Elemente spielen eine Rolle in der Art und Weise, wie Menschen Stress wahrnehmen und bewältigen, welche Bewältigungsstrategien sie entwickeln und wie sie soziale Unterstützung suchen und erhalten (Matsumoto & Juang, 2016).

Kulturelle Werte und Normen prägen das Verständnis von Wohlbefinden und Gesundheit. Unterschiedliche Kulturen haben unterschiedliche Auffassungen darüber, was es bedeutet, psychisch gesund zu sein und welche Verhaltensweisen als gesundheitsfördernd gelten. Kulturelle Hintergründe beeinflussen auch die soziale Unterstützung, die Menschen erhalten, sowie die Stigmatisierung von psychischen Gesundheitsproblemen (Triandis, 1994). Wie bereits in Kapitel 2.1.1.1 aufgeführt, kann Religiosität als Ressource für das Wohlbefinden dienen, indem sie den Menschen einen Sinn im Leben gibt, soziale Unterstützung bieten und Bewältigungsstrategien fördert. Religionsgemeinschaften können soziale Netzwerke bereitstellen, die emotionale Unterstützung bieten und das Gefühl der Zugehörigkeit stärken. Darüber hinaus können religiöse Praktiken wie Gebet oder Meditation stressmindernd wirken und das psychische Wohlbefinden fördern (Koenig, 2012; Pargament, 1997).

2.2 Aktueller Forschungsstand

In dieser Studie wird folgende Frage untersucht: Hat der Einfluss der Religiosität auf das psychische Wohlbefinden einen kulturellen Unterschied?

In den folgenden drei Unterkapiteln 2.2.1 Hypothese 1, 2.2.2 Hypothese 2 und 2.2.3 Hypothese 3 erfolgt die Herleitung der zu untersuchenden Hypothesen auf Basis bereits bestehender Befunde.

2.2.1 Hypothese 1

Religiosität und Wohlbefinden sind zwei Konzepte, die in der psychologischen Forschung häufig untersucht wurden. Es gibt zahlreiche Studien, die einen positiven Zusammenhang zwischen unterschiedlichen Dimensionen von Religiosität und verschiedenen Aspekten des Wohlbefindens belegen. Diese Beziehung wird oft auf Faktoren wie soziale Unterstützung, Sinnfindung im Leben und Bewältigungsmechanismen zurückgeführt, die mit religiösen Praktiken und Überzeugungen einhergehen.

Die erste Hypothese überprüft, ob das religiöse Engagement und religiöse

Aktivitäten positiv mit Wohlbefinden korrelieren. Diese Aussage wird durch bereits bestehende Ergebnisse unterstützt. Eine Studie von Dar und Iqbal (2019) zeigte eine positive Assoziation zwischen religiösem Engagement und verschiedenen Aspekten des Wohlbefindens, einschließlich Lebenszufriedenheit, Glück und Optimismus (vgl. Kapitel 2.1.3). Der totale Effekt von Religiosität auf das Wohlbefinden betrug $B = .39$ ($p < .001$) und der direkte Effekt einen Wert von $B = .28$ ($p < .050$). Dies zeigt, dass ein Teil des Einflusses von Religiosität auf das Wohlbefinden ohne andere Faktoren besteht. Auch bivariate Analysen von Koenig und Al Shohaib (2024) zeigen eine positive Assoziation zwischen Gesamt-Religiosität und Lebenszufriedenheit ($r = .12$), Glück ($r = .13$) und Optimismus ($r = .19$), was als kleiner bis mittlerer Effekt bewertet wird. Multivariate Analysen bestätigten diese Ergebnisse und zeigen signifikante Beziehungen zwischen Gesamt-Religiosität und Lebenszufriedenheit ($B = .046$, $SE = 0.005$), Glück ($OR = 1.03$, 95% CI [1.02, 1.04]) und Optimismus ($B = .054$, $SE = 0.005$), wobei ebenfalls kleine bis mittlere Effekte nachgewiesen wurden.

Van Cappellen, Toth-Gauthier, Saroglou und Fredrickson (2016) wiesen auf, dass allgemeine Religiosität in einer positiven Beziehung zum Wohlbefinden ($B = .11$, $SE = .03$, $p < .010$) steht. Auch die häufige Teilnahme an religiösen Aktivitäten scheint mit höheren Werten des Wohlbefindens zusammenzuhängen. Jokela (2022) wies eine moderate positive Korrelation zwischen psychischen Wohlbefinden und religiöser Teilnahme ($B = 0.29$; 95% CI [0.14, 0.45]) sowie allgemeiner Religiosität ($B = 0.37$; CI [0.21, 0.53]) auf. Des Weiteren zeigen seine Ergebnisse eine moderate negative Korrelation mit psychischem Stress auf ($B = -0.11$; CI [-0.16, -0.06] für Religiosität und $B = -0.14$; CI [-0.19, -0.09] für religiöse Teilnahme), die sich wiederum auf die psychische Gesundheit und damit auf das Wohlbefinden auswirken. In dieser Studie wurden zudem monotone Assoziationen zwischen religiöser Teilnahme und psychischem Stress sowie Wohlbefinden festgestellt. Dies bedeutet, dass mit zunehmender religiöser Aktivität sowohl der psychische Stress abnimmt als auch das psychische Wohlbefinden steigt. Ebenso gab es monotone Assoziationen zwischen Religiosität und psychischem Wohlbefinden (Jokela, 2022). So wie psychischer Stress haben depressive und ängstliche Symptomatik einen negativen Einfluss auf das psychische Wohlbefinden. Fernández und Rosell (2022) untersuchten dessen Zusammenhang mit Religiosität im Sinne von organisierter Religiosität und intrinsischer Religiosität. Die Ergebnisse zeigen eine negative Assoziation von organisierter Religiosität mit depressiver Symptomatik ($\beta = -.08$; $p = .001$). Die intrinsische Religiosität korreliert ebenfalls negativ mit ängstlicher Symptomatik ($\beta = -.07$; $p = .002$). Diese Effekte sind zwar klein, aber

signifikant.

Basierend auf dem theoretischen Hintergrund und der aufgeführten Ergebnissen bildet sich folgende Hypothese: Religiosität hat einen positiven Einfluss auf das psychische Wohlbefinden.

2.2.2 Hypothese 2

Die Forschung zeigt, dass Wohlbefinden positiv mit Religiosität zusammenhängt. Solche Beziehungen treten zudem in verschiedenen Kulturen auf, in denen Menschen unterschiedlichen Glaubensrichtungen folgen (Graham & Crown, 2014; Tay, Li, Myers & Diener, 2014). Der Einfluss der Kultur auf die Beziehung zwischen der Religiosität und dem Wohlbefinden sind Bestandteil der zweiten Hypothese.

In kollektivistischen Kulturen, die stärker auf Familiennetzwerke und gemeinschaftliche Bindungen fokussiert sind, könnte der Einfluss von intrinsischer Religiosität auf das Wohlbefinden durch das Familiennetzwerk besonders stark ausgeprägt sein. Die signifikanten indirekten Effekte durch das Familiennetzwerk ($\beta = -0.012$ für depressive Symptomatik und $\beta = -0.005$ für ängstliche Symptomatik) unterstützen diese Annahme. In individualistischen Kulturen, in denen persönliche Freundschaften und individuelle Netzwerke eine größere Rolle spielen, könnte der Einfluss von organisierter Religiosität auf das Wohlbefinden durch Freundesnetzwerke stärker ausgeprägt sein. Die signifikanten indirekten Effekte durch das Freundesnetzwerk ($\beta = -0.007$ für depressive Symptomatik und $\beta = -0.002$ für ängstliche Symptomatik) deuten darauf hin, dass Freundschaften in diesen Kulturen eine wichtige Rolle spielen. Diese Mediationseffekte legen nahe, dass Kultur einen moderierenden Effekt auf die Beziehung zwischen Religiosität und Wohlbefinden haben könnte. In kollektivistischen Kulturen könnte intrinsische Religiosität über starke Familiennetzwerke einen größeren positiven Einfluss auf das Wohlbefinden haben, während in individualistischen Kulturen organisierte Religiosität über Freundesnetzwerke eine wichtigere Rolle spielen könnte. Diese Spekulationen könnten in zukünftigen Studien weiter untersucht werden, um den Einfluss der Kultur auf die Beziehung zwischen Religiosität und Wohlbefinden genauer zu verstehen. (Fernández & Rosell, 2022)

In der Studie von Hoogeveen et al. (2022) wurde der Einfluss kultureller Normen auf die Beziehung zwischen Religiosität und selbstberichteter Lebenszufriedenheit untersucht. Von 101 Teams berichteten 97 positive Beta-Koeffizienten, wobei 65% der

Konfidenzintervalle den Wert Null ausschlossen. Der Median der Effektgröße betrug .039, was einem kleinen, aber positiven Effekt entspricht. Die mittlere absolute Abweichung vom Median von 0.022 weist darauf hin, dass die Streuung der Effektgrößen relativ gering ist, was die Zuverlässigkeit der Ergebnisse weiter unterstützt. Zudem kamen 54% der Teams zu dem Schluss, dass kulturelle Normen einen signifikanten Einfluss haben. Insbesondere die Tatsache, dass der Median der berichteten Effektgrößen positiv ist und dass ein signifikanter Anteil der Konfidenzintervalle den Wert Null ausschließt, unterstützt die Annahme, dass kulturelle Normen einen moderierenden Effekt haben. Diese Erkenntnisse können genutzt werden, um zu argumentieren, dass kulturelle Unterschiede, wie sie in der Dimension Individualismus-Kollektivismus definiert sind, ebenfalls einen solchen moderierenden Effekt haben könnten.

Basierend auf dem theoretischen Hintergrund und der aufgeführten Ergebnissen bildet sich folgende Hypothese: Die Kultur hat einen Einfluss auf die Beziehung zwischen Religiosität und psychischem Wohlbefinden.

2.2.3 Hypothese 3

In der Forschung gibt es Hinweise darauf, dass die Beziehung zwischen Religiosität und Wohlbefinden geschlechtsabhängig ist. Studien haben gezeigt, dass diese Zusammenhänge unterschiedlich stark ausgeprägt sein können. Nachfolgende Ergebnisse des aktuellen Forschungsstandes zeigen, dass der Einfluss der Religiosität auf das Wohlbefinden durch das Geschlecht moderiert wird. Frauen scheinen besonders von der Unterstützung durch religiöse Gemeinschaften und religiöse Führer zu profitieren, was mit höherer Lebenszufriedenheit verbunden ist. Bei Männern hingegen zeigt sich ein stärkerer Zusammenhang zwischen intrinsischer Religiosität und positiven Gesundheitsaspekten wie Glück und Optimismus.

Koenig und Al Shohaib (2024) fanden in ihrer Untersuchung eine signifikante Interaktion zwischen Geschlecht und Religiosität in Bezug auf die Lebenszufriedenheit ($B = -.025$, $SE = 0.009$, $p = .007$). Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass der Zusammenhang zwischen Religiosität und Lebenszufriedenheit bei Männern stärker ausgeprägt ist als bei Frauen. Ähnliche Trends wurden auch für Glück und Optimismus beobachtet, wobei die Beziehung zwischen allgemeiner Religiosität und Lebenszufriedenheit ($B = .046$, $SE = 0.005$), Glück ($OR = 1.03$, 95% CI [1.02, 1.04]) und Optimismus ($B = .054$, $SE = 0.005$) ebenfalls stärker bei Männern ausgeprägt war

(Interaktionseffekt $B = -.025$, $SE = 0.009$, $p = .007$).

Dar und Iqbal (2019) erweiterten diese Erkenntnisse, indem sie die Rolle des Gefühls von Bedeutung als vermittelnden Faktor zwischen religiöser Verpflichtung und Wohlbefinden untersuchten. Ihre Ergebnisse zeigten, dass das Gefühl von Bedeutung eine signifikante vermittelnde Rolle spielt, insbesondere bei Mädchen. Der indirekte Effekt der religiösen Verpflichtung auf das Wohlbefinden über das Gefühl von Bedeutung hatte einen Punktwert von 0,0768 und ein 95%-Konfidenzintervall von 0,0074 bis 0,1675, was auf eine kleine bis mittlere Effektstärke hinweist ($k^2 = 0,068$, 95%-BCa-CI [0.014, 0.160]). Bei der geschlechtsspezifischen Analyse zeigte sich, dass der indirekte Effekt der religiösen Verpflichtung auf das Wohlbefinden bei Mädchen stark und signifikant war (Punktwert = 0,1568, 95%-CI = 0,0527 bis 0,3188), während er bei Jungen schwach und nicht signifikant war (Punktwert = 0,0103, 95%-CI = -0,0848 bis 0,1061).

Die Studie von Lazar und Bjorck (2016) untersuchte die Auswirkungen verschiedener Formen religiöser Unterstützung auf das Wohlbefinden und zeigte, dass Geschlecht eine moderierende Rolle spielt. Die Ergebnisse zeigten, dass die Unterstützung durch die religiöse Gemeinschaft stärker mit Lebenszufriedenheit bei Frauen ($\beta = .28$, $p < .01$) als bei Männern ($\beta = .13$, $p < .01$) assoziiert war und dass Unterstützung durch die Religionsgemeinschaft bei Männern stärker negativ mit Angst korreliert war ($\beta = .25$, $p < .01$) als bei Frauen ($\beta = -.07$, ns). Die Unterstützung durch die religiöse Gemeinschaft lässt sich mit der Dimension der organisierten Religiosität vergleichen, da beide die Teilnahme an gemeinschaftlichen religiösen Praktiken umfasst. Auch ein Geschlechterunterschied bei der intrinsischen Religiosität kann durch die Ergebnisse der Autoren vermutet werden. Intrinsische Religiosität bezieht sich auf die persönliche Motivation und den inneren Glauben einer Person, was der in der Studie von Lazar und Bjorck (2016) gemessenen Unterstützung durch religiöse Führer nahekommt. Die Studie fand heraus, dass Unterstützung durch religiöse Führer insbesondere bei Frauen eine stärkere positive Wirkung auf die Lebenszufriedenheit hatte ($\beta = .20$, $p < .01$) als bei Männern ($\beta = .09$, $p < .05$), und dass Unterstützung durch geistige Führer bei Männern stärker negativ mit Angst korreliert war ($\beta = -.17$, $p < .01$) als bei Frauen ($\beta = -.04$, ns).

Auf Basis dieser Erkenntnisse lässt sich vermuten, dass Geschlecht den Einfluss der Religiosität auf das Wohlbefinden moderiert.

3 Methoden

In diesem Kapitel wird die empirische Bearbeitung der Hypothesen dargestellt. Zunächst wird die erhobene Stichprobe beschrieben, gefolgt von der Erläuterung der Erhebungsmethode, der Stichprobenauswahl und dem Erhebungsdesign. Darauf folgend wird auf die Operationalisierung der Konstrukte eingegangen. In folgendem Zuge wird die Untersuchungsdurchführung konkretisiert und abschließend wird auf die Auswertungsmethode eingegangen.

3.1 Stichprobenbeschreibung

Von den 506 Probanden, die an der Onlinebefragung teilgenommen haben, mussten 77 entfernt werden, da sie den Fragebogen nicht vollständig oder gewissenhaft beantworteten. Somit nahmen am Onlinefragbogen eine Stichprobe von $N = 429$ Probanden teil.

Weibliche Teilnehmer bilden mit $n = 312$ 72.7% den größten Teil der Gesamtstichprobe ab. Männliche Teilnehmer betrugen mit $n = 115$ (26.8%) den kleineren Teil der Befragten. Des Weiteren gaben $n = 2$ (0.5%) der Probanden an, ein diverses Geschlecht zu haben.

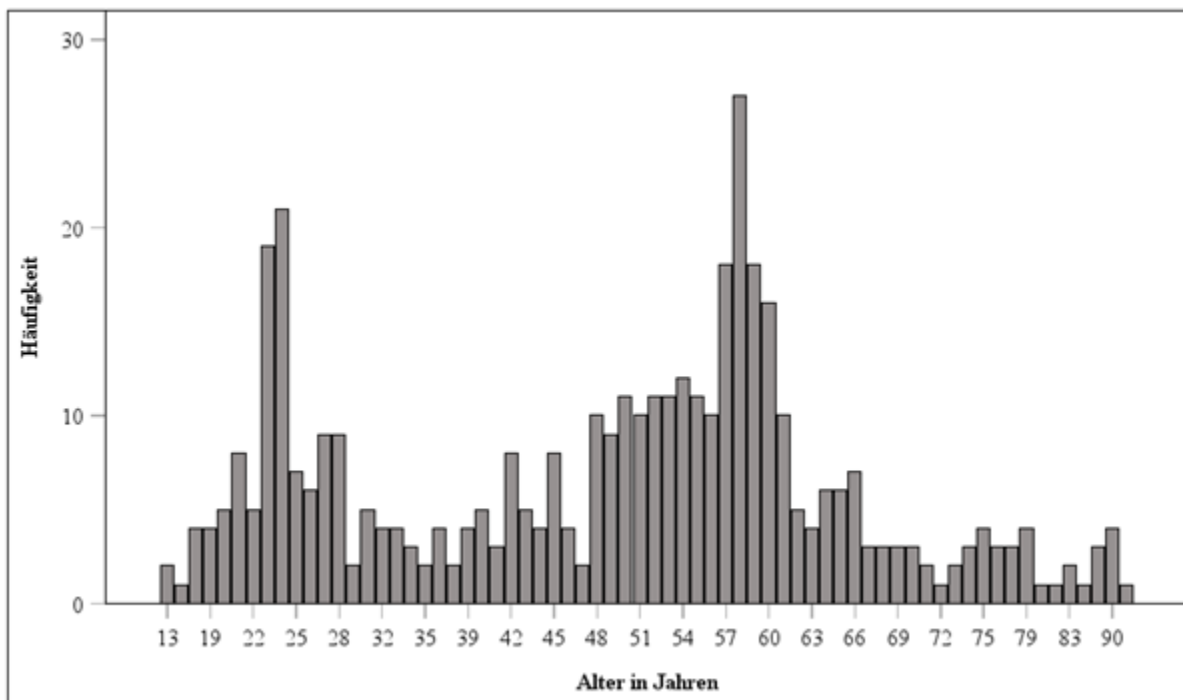


Abbildung 1. Verteilung des Alters.

Das Durchschnittsalter der Teilnehmer lag bei $M = 48.16$ Jahren ($SD = 0.84$). Eine grafische Darstellung der Altersverteilung ist in Abbildung 1 zu sehen. An ihr lässt sich ablesen, dass der jüngste Teilnehmer 13 Jahre alt war und der älteste Teilnehmer 96 Jahre. Die Verteilung ist bimodal mit einem ersten Gipfel bei 24 und einem zweiten Gipfel bei 58 Jahren. Sie ist nahezu symmetrisch (Schiefe = -0.07), jedoch flacher als eine Normalverteilung (Kurtosis = -0.68).

An der Umfrage nahmen primär Katholiken teil, die mit $n = 306$ (71.30%) die starke Mehrheit bilden. Nicht religiöse Personen waren mit 10.7% ($n = 46$) die zweitgrößte Gruppe, gefolgt von Protestanten ($n = 25$, 5.8%) und Atheisten ($n = 12$, 2.8%). Freikirchler und jene, die sich keiner dieser Gruppen zugehörig fühlten, bestanden jeweils aus $n = 8$ (1.9%) Probanden. Dem Islam, dem Hinduismus und dem Orthodoxen Christentum waren jeweils $n = 7$ (1.6%) Personen zugehörig. Mit $n = 2$ (0.5%) und $n = 1$ (0.2%) waren Personen einer Naturreligion und Buddhisten vertreten. Insgesamt waren 84.6% der $N = 429$ einer Religion zugehörig.

Von der Gesamtstichprobe gaben $n = 102$ (23.8%) an einen Migrationshintergrund zu besitzen. Fast ein Drittel ($n = 134$, 31.24%) gab an in Deutschland zu leben und fast die Hälfte ($n = 202$, 47.09%) gaben an in Spanien zu leben. Generell stammte die Stichprobe primär aus Europa, mit $n = 45$ (10.49%) aus einem nichteuropäischen Land stammend.

3.2 Untersuchungsdesign

Bei dieser Studie handelt sich um ein quantitatives Querschnittstudie mit einer anfallenden Stichprobe, um eine Momentaufnahme des Zusammenhangs zwischen den unterschiedlichen Variablen zu liefern. Die Datengeneration wurde mithilfe eines Onlinefragbogens (siehe Anhang J) erstellt, da dadurch eine weitreichendere und ökonomischere Erhebung gewährleistet werden konnte. Auf diese Weise konnten der Interview- und der Versuchsleitereffekt vermieden werden. Der Zugangslink wurde primär über die sozialen Netzwerke verschickt, in denen er sich nach dem Prinzip des Schneeballeffekts verbreitete.

Der Fragebogen war auf Deutsch, Englisch und Spanisch verfügbar, um Probanden mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen zu erreichen. Um eine reibungslose Durchführung für die Teilnehmer gewährleisten zu können, wurde vor Veröffentlichung des Fragebogens ein Pretest in den drei Sprachen durchgeführt.

Vorraussetzung für die Teilhabe an der Umfrage waren ein internetfähiges Endgerät,

ein Mindestalter von 12 Jahren und eine ausreichende Beherrschung mindestens einer der drei Sprachen. Die gewünschte Sprache konnte zu Beginn der Befragung ausgewählt werden.

3.3 Operationalisierung der Konstrukte

Die untersuchten Variablen wurden mithilfe standardisierter Fragebögen erhoben. Die Befragung begann mit zwei Fragebögen zur Religiosität. Die Deutsche Version der Religious Commitment Scale von Klumpparendt und Drenckhan (2014) misst das Engagement einer Person mit ihrer Religion. Neben einer deutschen Version wurde auch eine englische Übersetzung des Fragebogens von den Autoren veröffentlicht. Um ihn für diese Studie nutzen zu können, wurde er zusätzlich auch noch ins Spanische übersetzt. Für diese Übersetzung liegt bislang keine Validierung vor. Da es sich hierbei um eine sinnngemäße Übersetzung durch Muttersprachler handelt, wird die Reliabilität und Validität des originalen Fragebogens herangezogen. Die Faktorladungen der fünf Items auf einen gemeinsamen Faktor liegen bei .81 bis .92. Dies spricht für eine gute Konstruktvalidität und eine gute Reliabilität (Klumpparendt & Drenckhan, 2014). Auf einer siebenstufigen Antwortskala von 0 = *gar nicht* bis 6 = *sehr* konnten die Fragen beantwortet werden. Ein Beispielitem des Fragebogens lautet wie folgt: „Wie ausgeprägt leben Sie nach den Erfordernissen Ihrer Religion oder Ihres Glaubens?“.

Der zweite Fragebogen bezüglich der Religiosität war der Duke University Religion Index (DUREL) von Koenig, Parkerson und Meador (1997). Dieser erhebt drei Subskalen von Religiosität: Organisierte religiöse Aktivitäten (ORA), Nichtorganisierte religiöse Aktivitäten und (NORA) und Intrinsische Religiosität (IR). Das erste Item „Wie oft besuchen Sie die Kirche/Synagoge/Moschee oder andere religiöse Treffen?“ misst auf einer sechsstufigen Skala mit 1 = *Nie*, 2 = *Einmal im Jahr oder weniger*, 3 = *Einige Male im Jahr*, 4 = *Einige Male im Monat*, 5 = *Einmal pro Woche* und 6 = *Mehr als einmal pro Woche* die Subskala ORA. Auf der gleichen Skala misst das zweite Item „Wie oft widmen Sie sich privaten religiösen Aktivitäten wie Gebet, Meditation oder wie oft setzten Sie sich mit den Schriften Ihrer Religion auseinander?“ NORA. Die anderen drei Items bilden die dritte Subskala, die die IR misst. Hierfür wird eine fünfstufige Antwortskala genutzt, die von 1 = *Stimme überhaupt nicht zu*, 2 = *Stimme wenig zu*, 3 = *Neutral*, 4 = *Stimme etwas zu* bis hin zu 5 = *Stimme vollkommen zu* reicht. Ein Beispiel für solch ein Item ist folgendes: „Meine religiösen Überzeugungen sind das, was wirklich hinter

meinem gesamten Lebensansatz steht.“. Die Autoren veröffentlichten eine englische und spanische Version. Für diese Studie wurden die Fragen ins Deutsche übersetzt und die spanische Version wurde überarbeitet. Für die deutsche Übersetzung liegt bislang keine Validierung vor. Da es sich hierbei um eine sinngemäße Übersetzung durch Muttersprachler handelt, wird die Reliabilität und Validität des originalen Fragebogens herangezogen. In einer Validierungsstudie von Koenig und Büssing (2010) wurde eine hohe Retestreliabilität (Intra-Klassen-Korrelation = .91) und eine hohe Konsistenz (Cronbachs- α = .78-.91) ermittelt. Der DUREL hat zudem eine hohe konvergente Validität mit anderen Messungen der Religiosität (r = .71-.86).

Im Anschluss erfolgte der WHO-5 Fragebogen zum Wohlbefinden (WHO, 1998), der die Befragten betreffend ihres Wohlbefindens der letzten zwei Wochen befragte. Das Präfix „In den letzten zwei Wochen...“ leitet die fünf Items, wie beispielsweise „... war ich froh und guter Laune“ ein. Für die Bearbeitung der Items steht eine sechsstufige Skala zur Verfügung, die von 1 = *Die ganze Zeit*, 2 = *Meistens*, 3 = *Etwas mehr als die Hälfte der Zeit*, 4 = *Etwas weniger als die Hälfte der Zeit*, 5 = *Ab und zu* bis 6 = *Zu keinem Zeitpunkt* reicht. Die Reliabilität des WHO-5 wurde in verschiedenen Ländern und kulturellen Kontexten untersucht. Die Ergebnisse einer Validierungsstudie (Sischka et al., 2020) zeigen eine hohe interne Konsistenz (ρ = .83-.93). Die Konstruktvalidität ist durch mittlere bis hohe Korrelationen mit anderen Fragebögen gegeben. Die Korrelation des WHO-5 mit dem einer Skala zur Erfassung des chronischen Stress lag bei r = -.30 und eine Korrelation mit einem Fragebogen zur Erfassung körperlichen Wohlbefindens lag bei r = .68 (Brähler, Mühlen, Albani & Schmidt, 2007).

Abschließend wurden einige soziodemografischen Daten erhoben. Diese waren das Alter, das Geschlecht, der kulturelle Hintergrund, die potenzielle Religionszugehörigkeit, der aktuelle Beziehungsstatus, der höchste erreichte Bildungsstand, die aktuelle Tätigkeit und in welchem Siedlungstyp die befragte Person wohnt (ländlich oder in der Stadt). Um den kulturellen Hintergrund zu ermitteln, wurden die Probanden gebeten, Angaben zu ihrem aktuellen Wohnland sowie etwaigem Migrationshintergrund bei sich, ihren Eltern oder ihren Großeltern zu machen, einschließlich des Landes, aus dem sie stammen, falls zutreffend. Des Weiteren wurde die Cultural Orientation Scale (COS) von Bierbrauer, Meyer und Wolfradt (2002) genutzt. Der Fragebogen untersucht, ob eine Person aus einer individualistischen oder kollektivistischen Kultur stammt und erfragt die persönliche Meinung bezüglich sozialer Verhaltensweisen in dem Land, zu dem sich die Person zugehörig fühlt. Beide Subskalen bestehen aus jeweils 13 Items, die mithilfe einer siebenstufigen

Antwortskala beantwortet werden. Der ersten Subskala bezüglich der Verbreitung gewisser Sitten und Bräuche steht folgende Antwortoptionen bereit: 1 = *überhaupt nicht*, 2 = *Sehr selten*, 3 = *Selten*, 4 = *Manschmal*, 5 = *Häufig*, 6 = *Sehr häufig* und 7 = *Immer*. Ein Item lautet beispielsweise wie folgt: „Wie häufig richten sich Jugendliche in Deutschland bei der Wahl ihres Freundes oder ihrer Freundin nach den Ratschlägen ihrer Eltern?“. Für die englische und spanische Version wurde die Nationalität entfernt und es wurde nach dem eigenen Land gefragt, da in diesen Fällen keine spezifische Nationalität zugewiesen werden konnte. Im Anweisungstext wurde des Weiteren darauf hingewiesen, dass mit dem „eigenen Land“, jenes gemeint ist, mit dem sich die Person am meisten identifiziert. Aus einer Studie mit unterschiedlichen kulturellen Kontexten ermittelten Bierbrauer et al. (2002) eine gute interne Konsistenz (Cronbachs- $\alpha = .59-.82$) für den Fragebogen. In kulturvergleichenden Studien konnte durch den Fragebogen signifikant zwischen Teilnehmern bezüglich ihrer individualistischen bzw. kollektivistischen Kulturzugehörigkeit differenzieren werden.

3.4 Untersuchungsdurchführung

Die Datenerhebung erfolgte in dem Zeitraum vom 01.05.2024 bis 02.06.2024. Der mit SoSci-Survey erstellte Fragebogen wurde primär über Messenger-Dienste, wie WhatsApp oder Signal, aber auch über das soziale Netzwerk Instagram und über das Portal SurveyCircle mit der Bitte um Weitergabe verbreitet, um eine möglichst große Stichprobe zu erreichen. Die Mindeststichprobengröße - von 311 Teilnehmern für einen kleinen Effekt bzw. 395 Teilnehmern für einen großen Effekt - wurde mithilfe des kostenlosen Tools G*Power ermittelt.

Im Einführungstext zu Beginn der Befragung wurde auf die 10 bis 15 minütige Bearbeitungszeit und die garantierte Anonymität der Befragten hingewiesen. Die Teilnehmer wurden zudem darauf hingewiesen, dass die Teilnahme an der Befragung freiwillig sei. Auf der anschließenden Seite begann die Befragung. Eine inhaltliche Demonstration der genutzten Fragebögen und deren Reihenfolge wurde bereits in Kapitel 3.3 dargeboten. Zu Beginn wurde die eigene Einstellung und das eigene Verhalten im Kontext zu Religiosität befragt, gefolgt von einem kurzen Fragebogen zum psychischen Wohlbefinden. Im Anschluss wurden die Probanden gebeten, einige kurze Angaben zu ihrer Person zu machen. Der inhaltliche Teil endete mit dem Fragebogen bezüglich der kulturellen Orientierung. Auf der letzten Seite wurde den Befragten für ihre Teilnahme gedankt und darauf hingewiesen, dass ihre Daten gespeichert wurden und sie nun das

Browserfenster schließen können.

Potenzielle Störvariablen konnten während der Untersuchungsdurchführung nicht kontrolliert werden. Aufgrund der Onlinebefragung lag die Entscheidung, zu welchem Zeitpunkt, an welchem Ort und unter welchen Bedingungen die Befragung bearbeitet wurde, bei den Teilnehmern selbst.

3.5 Auswertungsmethode

Die Statistik- und Analysesoftware SPSS wurde für die Berechnungen und statistischen Analysen genutzt. Bevor die Hypothesen jedoch bewiesen oder widerlegt werden konnten, musste der Datensatz bereinigt werden. Anschließend konnten die Daten ausgewertet werden, beginnend mit den deskriptiven Kennzahlen der drei Konstrukte. Anhand der Lageparameter, der Maße der Streuung und der Verteilung konnten die demographischen Daten der Stichprobe ausgewertet werden. Bei der Cultural Orientation Scale wurden bereits auf SoSci-Survey vier Items umgepolt, damit ein hoher Skalenwert einem hohen Grad der kollektivistischen Orientierung entspricht.

Bei der Prüfung auf Multikollinearität zeigte sich eine starke Korrelation zwischen den vier Religiositätsskalen, was auf Multikollinearität deutet. Damit es nicht zu einer Verzerrung bei der Schätzung der Regressionskoeffizienten kommen konnte und damit ihre Interpretierbarkeit beeinträchtigt wäre, wurde eine explorative Faktornalyse durchgeführt, um die zugrundeliegende Struktur der Daten zu ermitteln und die Anzahl der Faktoren zu bestimmen, die die Varianz in den Subskalen erklären. Die Faktoranalyse identifizierte einen einzigen Faktor (siehe Anhang A), der 89.01% der Gesamtvarianz erklärt. Dieser extrahierte Faktor wurde für die weiteren Untersuchungen verwendet.

Die erste Hypothese wurde mit einer einfachen linearen Regression berechnet. Sie untersuchte, inwiefern Religiosität das psychische Wohlbefinden vorhersagen kann. Die Voraussetzungen für eine einfache lineare Regression sind das metrisch-skalierte Kriterium und der mindestens kategorial-skalierte Prädiktor. Des Weiteren wird Linearität zwischen den Variablen und Homoskedastizität vorausgesetzt. Es dürfen keine Autokorrelation und keine Multikollinearität bestehen, um dieses Verfahren durchführen zu können.

Bei der zweiten Hypothese handelte es sich um eine Moderationsanalyse, die mithilfe des Plug-in PROCESS berechnet wurde. Bei der Untersuchung der Hypothese wurde getestet, ob die kulturelle Orientierung den Zusammenhang zwischen Religiosität und psychischem Wohlbefinden moderiert. Die allgemeine Voraussetzung für diesen

Test sind die Linearität und der Stichprobenumfang. Des Weiteren gibt es spezifische Voraussetzungen. Eine gegebene Homoskedastizität, keine Autokorrelation und keine Multikolinearität müssen gegeben sein.

Für die Überprüfung der dritten Hypothese wurde eine weitere Moderationsanalyse gerechnet. Die Rechnung der H3 diente der Überprüfung des angenommenen Geschlechterunterschieds bei der Korrelation der metrischen Religiosität mit dem metrischen Wohlbefinden.

4 Ergebnisse

Im folgenden Kapitel werden die durchgeführten statistischen Berechnungen dargestellt. Zu Beginn werden die deskriptiven Ergebnisse beschrieben und mit den Normwerten verglichen. Im inferenzstatistischen Unterkapitel werden die Ergebnisse der Vorraussetzungsprüfung der einzelnen Tests dokumentiert und abschließend werden die Ergebnisse der Berechnungen zur Überprüfung der drei Hypothesen präsentiert. Die ausführliche Interpretation der Ergebnisse geschieht in Kapitel 5.

4.1 Deskriptive Ergebnisse

Die Deutsche Version der Religious Commitment Scale wies bei einem $Min = 0$ und einem $Max = 6$ einen Mittelwert von $M = 3.57$ ($SD = 0.10$) und einen Median von $Mdn = 4.00$ auf. Mit den Modi an den Extremen 0 und 6 gemeinsam mit einer Schiefe von -0.39 und Kurtosis von -1.25 ist die Verteilung bimodale, leicht linksschiefe und flacher als eine Normalverteilung. Eine bildliche Darstellung der Daten befindet sich in Anhang B.

Die Statistiken der drei Subskalen des DUREL waren wie folgt. ORA wies bei einem $Min = 1$ und einem $Max = 6$ einen Mittelwert von $M = 3.81$ ($SD = 0.09$) und einen Median von $Mdn = 4.00$ auf. Der am häufigsten vorkommende Werte lagen bei 6 und bildeten zusammen mit einer Schiefe von -0.16 und einer Kurtosis von -1.46 eine unimodale, leicht linksschiefe und breitgipflige Verteilung. Die Verteilung der NORA Subskalawerte zeigte Mittelwerte von $M = 4.05$ ($SD = 0.10$), einen Median von 5.00 und Modi bei 1 und 6. Die Werte reichten von $Min = 1$ bis $Max = 6$, mit einer Schiefe $= -0.41$ und Kurtosis $= -1.52$, das einer bimodalen, leicht linksschiefen und breitgipfligen Verteilung entspricht. Die Werte der IR reichten von $Min = 1$ bis $Max = 5$ und wiesen einen Mittelwert von $M = 3.42$ ($SD = 0.07$) und einen Median von $Mdn = 4.00$ auf. Die am häufigsten verteilten Werte lagen bei 1 und 5 und bildeten zusammen mit einer Schiefe von -0.39 und einer Kurtosis von -1.30 eine bimodale, leicht linksschiefe und breitgipflige Verteilung. Eine bildliche Darstellung der einzelnen Subskalendaten befinden sich in Anhang C.

Beim WHO-5 wurde bei einer Range von $Min = 0$ bis $Max = 5$ ein Mittelwert von $M = 3.23$ ($SD = 0.04$) und ein Median von $Mdn = 3.40$ berechnet, bei einer unimodalen (Modus $= 4$), linksschiefen (Schiefe $= -0.88$) und leicht spitzköpfigen (Kurtosis $= 0.59$) Verteilung. Die Werte beinhalteten sechs leichte Ausreißer, die als Boxplot zusammen mit einer bildlichen Darstellung der Verteilung in Anhang D zu finden sind.

Die COS zeigte einen Mittelwert von $M = 4.59$ ($SD = 0.02$) und einen Median von $Mdn = 4.56$. Der geringste Wert war bei $Min = 2.72$ und der höchste bei $Max = 6.24$. Eine Schiefe von -0.08 bildet mit einer Kurtosis von 0.57 und einem Modus bei 4.48 eine leicht spitzgipflige unimodale Normalverteilung. Dabei wurden vier leichte Ausreißer gefunden. Eine bildliche Darstellung der Verteilung, wie auch ein Boxplot zur Visualisierung der Ausreißer befinden sich in Anhang E.

4.2 Inferenzstatistische Ergebnisse

Anschließend erfolgt eine inferenzstatistische Analyse der erhobenen Daten zur Feststellung der Korrelationen zwischen den in Kapitel 2 näher gebrachten Konstrukten Religiosität, Wohlbefinden und Kultur.

4.2.1 Hypothese 1

Die Voraussetzungen für eine Regression, einschließlich Linearität, Normalverteilung der Residuen und Homoskedastizität, wurden erfüllt. Die Linie zur Prüfung auf Linearität, die durch die Punkte verläuft, zeigte eine gewisse Krümmung, was auf eine mögliche leichte Nichtlinearität hinweisen könnte (siehe Anhang F). Auch die Durbin-Watson-Statistik lag mit 2.01 im gewünschten Bereich und zeigte keine Autokorrelation der Residuen an.

Tabelle 1. *Einfache lineare Regression von Religiosität auf psychisches Wohlbefinden*

	B	$SE(B)$	β	t	95% Konfidenzintervall	
					Untere Grenze	Obere Grenze
Konstante	3.23	0.04		75.03	3.14	3.31
Religiosität	0.21	0.04	.23*	4.81	0.12	0.29

Anmerkungen. $N = 429$; Wertebereich der Variable Religiosität -1.69 (*gar nicht religiös*) bis 1.16 (*sehr religiös*).

* $p < .001$

Tabelle 1 demonstriert den signifikanten positiven Einfluss des extrahierten Faktors für Religiosität auf das Wohlbefinden ($R^2 = .05$, $F(1, 427) = 23.1$, $p < .001$). Der Regressionskoeffizient betrug $B = .21$ ($SE = .04$), $t = 4.81$, $p < .001$, mit einem 95% CI $[0.12, 0.29]$. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass höhere Werte in der Religiosität mit einem höheren psychischen Wohlbefinden assoziiert sind, wobei es sich um einen kleinen

bis mittleren Effekt handelt.

4.2.2 Hypothese 2

Um die vermutete Moderation der kulturellen Orientierung auf den Zusammenhang zwischen der Religiosität und dem psychischen Wohlbefinden zu testen, wurde eine Moderationsanalyse durchgeführt. Die Voraussetzungen für diese, einschließlich Linearität, Homoskedastizität und mit $N = 418$ eine Normalverteilung der Residuen, wurden erfüllt. Die Linie zur Prüfung auf Linearität, die durch die Punkte verläuft, zeigte eine gewisse Krümmung, was auf eine mögliche leichte Nichtlinearität hinweisen könnte (siehe Anhang G). Die Durbin-Watson-Statistik lag mit 2.00 im gewünschten Bereich und zeigte keine Autokorrelation der Residuen an. Zwischen den Variablen herrschte keine Multikollinearität, wie die Toleranzwerten von 0.80 verdeutlichen.

Tabelle 2. *Moderationsanalyse Religiosität und kulturelle Orientierung auf das psychische Wohlbefinden*

	B	$SE(B)$	t	p	ΔR^2
Konstante	2.24	0.45	4.95	< .001	
Religiosität	-0.47	0.41	-1.15	.250	
Kultur	0.21	0.10	2.16	.032	
Interaktionsterm	0.14	0.09	1.56	.119	.006
R^2					.063*

Anmerkungen. $N = 418$; Wertebereich der Variable Religiosität -1.69 (*gar nicht religiös*) bis 1.16 (*sehr religiös*); kulturelle Orientierung 1 (*überhaupt nicht*) bis 7 (*immer*).

* $p < .001$

Eine Moderationsanalyse wurde durchgeführt, um zu bestimmen, ob die Interaktion zwischen der kulturellen Orientierung und der Religiosität das psychische Wohlbefinden signifikant vorhersagt. Das Gesamtmodell war, wie in Tabelle 2 demonstriert, signifikant, $F(3, 414) = 10.44$, $p < .001$, mit einer Varianzaufklärung von 6.31%. Die Ergebnisse konnten jedoch keinen Moderationseffekt von Kultur auf die Beziehung zwischen Religiosität und Wohlbefinden finden, $\Delta R^2 = 0.61\%$, $F(1, 414) = 2.44$, $p = .119$, 95% CI[-0.04, 0.31]. Gemäß den Empfehlungen von Hayes (2018) wurde der Interaktionsterm aus dem Modell entfernt, was zu einem neuen Modell mit Haupteffekten führte (siehe Tabelle 3). Dieses neue Modell

zeigte, dass sowohl Religiosität ($B = 0.15$, $p = .002$) als auch Kultur ($B = 0.20$, $p = .038$) signifikant mit dem Wohlbefinden zusammenhängen. Dabei handelte es sich jedoch nur um kleine, aber signifikante Einflüsse der Variablen auf das Wohlbefinden (Religiosität $\beta = .17$; Kultur $\beta = .11$).

Tabelle 3. *Modell mit Haupteffekten*

	B	$SE(B)$	β	t	p
Religiosität	0.15	0.05	.17	3.15	.002
Kultur	0.20	0.10	.11	2.09	.038

Anmerkungen. $N = 418$; Wertebereich der Variable Religiosität -1.69 (*gar nicht religiös*) bis 1.16 (*sehr religiös*); kulturelle Orientierung 1 (*überhaupt nicht*) bis 7 (*immer*).

4.2.3 Hypothese 3

Um die vermutete Moderation des biologischen Geschlechts auf den Zusammenhang zwischen Religiosität und dem psychischen Wohlbefinden zu testen, wurde eine Moderationsanalyse durchgeführt. Dafür wurden die zwei diversen Fälle ausgeschlossen.

Tabelle 4. *Moderationsanalyse Religiosität und biologisches Geschlecht auf das psychische Wohlbefinden*

	B	$SE(B)$	t	p	ΔR^2
Konstante	3.39	0.17	19.54	< .001	
Religiosität	-0.15	0.18	-0.83	.406	
Geschlecht	-0.11	0.10	-1.15	.251	
Interaktionsterm	0.22	0.10	2.15	.032	.010*
R^2					.069**

Anmerkungen. $N = 427$; Wertebereich der Variable Religiosität -1.69 (*gar nicht religiös*) bis 1.16 (*sehr religiös*); biologisches Geschlecht 1 (*männlich*) bis 2 (*weiblich*).

* $p < .05$, ** $p < .001$

Die Voraussetzungen für die Moderationsanalyse, einschließlich Linearität,

Homoskedastizität und mit $N = 427$ eine Normalverteilung der Residuen, wurden erfüllt. Die Linie zur Prüfung auf Linearität, die durch die Punkte verläuft, zeigte eine gewisse Krümmung, was auf eine mögliche leichte Nichtlinearität hinweisen könnte. Dennoch ist das Muster nicht extrem, sodass das Verhältnis der Variablen bei visueller Inspektion des Streudiagramms mit LOESS-Glättung etwa linear ist (siehe Anhang H). Die Durbin-Watson-Statistik lag mit 1.98 im gewünschten Bereich und zeigte keine Autokorrelation der Residuen an. Zwischen den Variablen herrschte keine Multikollinearität, wie die Toleranzwerten von 0.93 verdeutlichen.

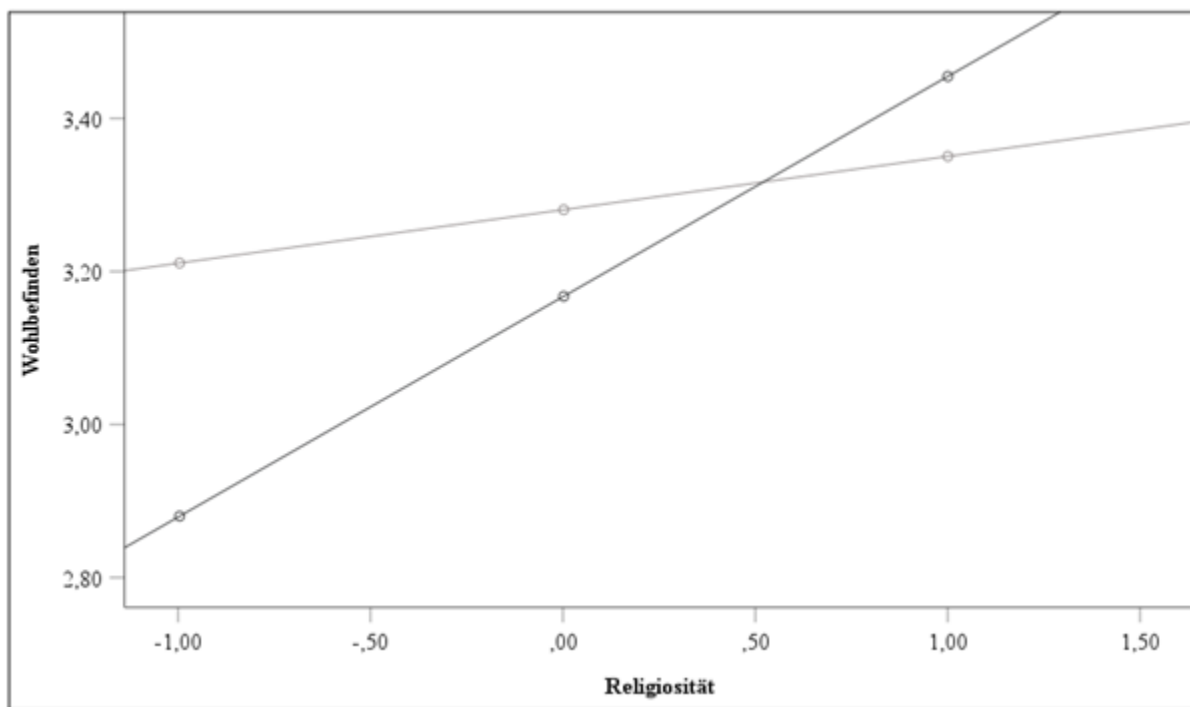


Abbildung 2. Moderationseffekt des Geschlechts auf die Beziehung von Religiosität und Wohlbefinden. Männer = dunkle Linie; Frauen = helle Linie

Eine Moderationsanalyse wurde durchgeführt, um zu bestimmen, ob die Interaktion zwischen dem biologischen Geschlecht und Religiosität das psychische Wohlbefinden signifikant vorhersagt. Das Gesamtmodell war, wie in Tabelle 4 demonstriert, signifikant, $F(3, 423) = 9.20$, $p < .01$, mit einer Varianzaufklärung von 6.93%. Die Ergebnisse zeigten zudem einen Moderationseffekt des Geschlechts auf die Beziehung zwischen Religiosität und Wohlbefinden, $\Delta R^2 = 1.02\%$, $F(1, 423) = 4.64$, $p = .036$, 95% CI[0.02, 0.42]. Dieser Effekt kann als klein eingestuft werden, was darauf hindeutet, dass das Geschlecht einen geringen, aber signifikanten Einfluss auf die Beziehung zwischen Religiosität und Wohlbefinden hat. In Abbildung 2 ist der unterschiedliche Effekt der Religiosität auf das Wohlbefinden bei Männern und Frauen

erkennbar. Religiosität scheint bei Frauen einen größeren Einfluss auf ihr Wohlbefinden zu haben als bei Männern. Bei niedrigen Werten an Religiosität ist das Wohlbefinden der Frauen geringer als das der Männer. Mit zunehmender Religiosität überholt das Wohlbefinden der Frauen das der Männer und liegt bei höheren Religiositätswerten über dem Wohlbefinden der Männer.

4.3 Explorative Ergebnisse

Zusätzlich zu den untersuchten Hypothesen wurden noch weitere explorative Untersuchungen getätigt. Es wurde entdeckt, dass sich die Religiosität unter den Befragten abhängig davon, ob sie einen Migrationshintergrund besitzen oder nicht unterscheidet. Des Weiteren zeigen die Ergebnisse, dass gewisse Religionen kollektivistischer eingestellt waren, als es die stark individualistischen Kulturen der europäischen Herkunftsländer annehmen lassen.

4.3.1 Einfluss von Migration auf die Religiosität

Zur Berechnung der Gruppenunterschiede wurde ein ungepaarter t-Test berechnet. Neben der Unabhängigkeit der Messungen besitzen die abhängige Variablen das mindestens erforderliche intervallskalierte Skalenniveaus und die unabhängige Variable die notwendige Nominalskalierung mit zwei Ausprägungen. Auch befanden sich im Datensatz keine Ausreißer (siehe Anhang I) und die Varianzen in den Gruppen waren gleich. Gemäß dem Shapiro-Wilk Test waren beide Gruppen nicht normalverteilt ($p < .001$), aufgrund der Stichprobengröße kann jedoch von einer Normalverteilung der Daten ausgegangen werden.

Die Ergebnisse zeigten einen statistisch signifikanten Unterschied gemäß der Religiosität der Probanden zwischen jenen, die seit mindestens drei Generationen im gleichen Land leben und jenen, die einen Migrationshintergrund besitzen. Personen, die aus einem anderen Land stammen ($n = 102$, $M = 0.19$, $SD = 0.96$) wiesen einen höheren Wert an Religiosität auf, als die Einheimischen ($n = 327$, $M = -0.06$, $SD = 1.00$), $t(427) = 2.23$, $p = .026$, 95% CI [0.03, 0.47]. Die Effektgröße, gemessen durch Cohen's d , beträgt 0.25, was auf einen kleinen bis mittleren Effekt hinweist.

4.3.2 Unterschied kultureller Orientierung bei den Religionen

Es wurde zudem untersucht, wie sich die Religionen hinsichtlich ihrer kulturellen Orientierung unterscheiden. Dafür wurde eine ANOVA gerechnet, die die Voraussetzungen der unabhängigen Messung, das mindestens intervallskalierte Kriterium und die Nominalskalierung des Prädiktors erfüllte. Mit dem Shapiro-Wilk Test wurde auf die Normalverteilung des Prädiktors und dessen Gruppen geprüft. Die kulturelle Orientierung war normalverteilt für fast alle Religionen, nicht aber für das katholische Christentum, wie eine Überprüfung mit dem Shapiro-Wilk Test ergab ($\alpha > .05$). Da die einfaktorielle ANOVA relativ robust gegenüber Verletzungen ist, wurden keine Gegenmaßnahmen durchgeführt (Schmider, Ziegler, Dana & Beyer, 2010). Unter den Befragten befanden sich sechs leichte Ausreißer (siehe Anhang I). Die Überprüfung der Varianzhomogenität erfolgte mit dem Levene-Test, gemäß dem Homoskedastizität angenommen werden konnte ($p > .05$). Um post-hoc Analysen durchführen zu können, wurde der einzige buddhistische Datensatz ausgeschlossen.

Die Ergebnisse der einfaktoriellen ANOVA zeigen, dass sich die kulturelle Orientierung statistisch signifikant zwischen den Religionen unterschied, $F(9, 407) = 9.22$, $p < .001$, $\eta^2 = .17$. Dies entspricht einem großen Effekt.

Tabelle 5. *Tukey HSD Post-hoc Tests für kulturelle Orientierung nach Religion*

Vergleich	Mittelwertsdifferenz	Std. Fehler	p	95% Konfidenzintervall	
				Untere Grenze	Obere Grenze
Katholizismus vs. Protestantismus	0.50	0.10	<.001	0.18	0.81
Katholizismus vs. Nicht religiös	0.46	0.07	<.001	0.22	0.70
Hinduismus vs. Protestantismus	0.95	0.20	<.001	0.31	1.59
Hinduismus vs. Freikirchlich	0.90	0.24	0.009	0.13	1.68
Hinduismus vs. Atheismus	0.85	0.22	0.007	0.14	1.56
Hinduismus vs. Nicht religiös	0.92	0.19	<.001	0.31	1.52

Anmerkungen. Die Tabelle zeigt die Mittelwertsdifferenzen, Standardfehler, p -Werte und 95% Konfidenzintervalle der signifikanten Tukey HSD-Tests für die kulturelle Orientierung nach Religion.

Die Tukey HSD-Tests zeigten, wie in Tabelle 5 ersichtlich, signifikante Unterschiede in den Kulturwerten zwischen den Religionen. Die Katholiken ($n = 296$) wiesen signifikant höhere kollektivistische Werte auf als die Protestanten ($n = 24$) und nicht religiöse Personen ($n = 46$). Hindus ($n = 7$) zeigten die höchsten kollektivistischen Werte, die

signifikant höher waren als die Werte von Orthodoxen ($n = 7$), Protestanten, Freikirchlern ($n = 8$), Atheisten ($n = 12$) und nicht religiöse Personen. Der Islam, das Orthodoxe Christentum, das Judentum, die Naturreligionen und die Religionen, die in der Befragung nicht aufgeführt wurden, wiesen keine signifikanten Unterschiede bezüglich ihrer Religiosität mit den anderen Religionen auf.

5 Diskussion

Das abschließende Diskussionskapitel beginnt mit einer Zusammenfassung der zentralen Ergebnisse. Daraufhin folgt ihre Interpretation und die Einordnung in den aktuellen wissenschaftlichen Forschungsstand. Nachfolgend werden die verwendeten Methoden bewertet. Die Arbeit endet mit theoretischen und oder praktischen Implikationen für die zukünftige Forschung oder Praxis.

5.1 Zusammenfassung der zentralen Ergebnisse

Diese Masterarbeit befasst sich maßgeblich mit den Themen Religiosität, Wohlbefinden und deren Zusammenhang mit der kulturellen Orientierung der Probanden. Im Laufe dieses Kapitels werden die Ergebnisse von den zuvor aufgestellten Hypothesen zusammengefasst sowie die Ergebnisse der Posthoc Analysen.

Am online erhobenen Fragebogen waren mehr als zwei Drittel der $N = 429$ großen Stichprobe Frauen. Die Altersverteilung war weit gestreut mit zwei Häufungen bei jungen Erwachsenen und bei Personen zwischen 50 und 60 Jahren. Katholiken waren mit mehr als 70% die größte vertretene Gruppe unter den Befragten. Personen mit Migrationshintergrund bildeten fast ein Viertel der Gesamtstichprobe, die primär aus Europäern bestand, von denen die Hälfte in Spanien und fast ein Drittel in Deutschland lebt.

Die H1 diente der Überprüfung des Einflusses von Religiosität auf das psychische Wohlbefinden. Bei der Testung auf Multikollinearität für eine multiple lineare Regression zeigte sich eine starke Korrelation zwischen den vier Religiositätsskalen. Aus diesem Grund wurde durch eine Faktoranalyse die erhobenen Inhalte untersucht. Diese Analyse ergab einen Faktor und eine einfache lineare Regression, die alle Voraussetzungen erfüllte, wurde durchgeführt. Es wurde ein kleiner bis mittelgroßer, signifikanter und positiver Einfluss der Religiosität auf das Wohlbefinden gefunden. Demzufolge musste die Nullhypothese verworfen werden und die Alternativhypothese angenommen werden: Religiosität hat einen Einfluss auf das psychische Wohlbefinden.

Bei der H2 wurde ein Moderationseffekt der kulturellen Orientierung auf den Zusammenhang zwischen der Religiosität und dem psychischen Wohlbefinden untersucht. Die dafür notwendigen Voraussetzungen waren alle gegeben. Das Gesamtmodell der Moderation war signifikant, jedoch zeigte die Interaktion der beiden Prädiktoren ein nicht signifikantes Ergebnis. Die Nullhypothese musste demzufolge angenommen werden und

die kulturelle Orientierung hat keinen Einfluss auf die Beziehung zwischen Religiosität und Wohlbefinden. Des Weiteren wurde untersucht, ob beide Prädiktoren unabhängig von einander Einfluss auf das Kriterium haben. Die Regressionsanalyse für die Haupteffekte zeigte für beide Variablen signifikante, wenn auch kleine Effekte. Die Nullhypothese musste angenommen werden, wonach die Kultur keinen Einfluss auf die Beziehung zwischen Religiosität und psychischem Wohlbefinden hat.

Von einer moderierenden Rolle des biologischen Geschlechts des Probanden auf den Zusammenhang zwischen Religiosität und dem psychischen Wohlbefinden wurde bei der H3 ausgegangen und für dessen Berechnung wurden alle Voraussetzungen erfüllt. Das Gesamtmodell wie auch der Moderationseffekt waren signifikant. Das Geschlecht hat einen geringen Einfluss auf die Beziehung zwischen Religiosität und Wohlbefinden. Dies bedeutet, dass die Nullhypothese verworfen werden musste und die Alternativhypothese angenommen wurde: Das Geschlecht hat einen Effekt auf die Beziehung zwischen Reliabilität und psychischem Wohlbefinden.

Die erste explorative Analyse untersuchte den Einfluss eines Migrationshintergrundes auf die Religiosität der Person. Obwohl die beiden Gruppen laut Shapiro-Wilk Test nicht normalverteilt waren, wurde aufgrund der Stichprobengröße dennoch ein unabhängiger t-Test durchgeführt. Dieser Test zeigte einen signifikanten kleinen bis mittleren Unterschied zwischen den Gruppen, das bedeutet, dass Personen, die aus einem anderen Land stammen, einen höheren Wert an Religiosität aufwiesen, als Einheimische.

Die weitere explorative Analyse untersuchte, inwiefern sich die Religionen bezüglich ihrer kulturellen Orientierung unterscheiden. Die Voraussetzungen waren bis auf den Verstoß der Normalverteilung der jeweiligen Gruppen gegeben und da die einfaktorielle ANOVA robust gegenüber Voraussetzungsverletzungen ist, wurden keine Gegenmaßnahmen unternommen. Die Ergebnisse zeigten große statistisch signifikante Unterschiede bezüglich der kulturellen Orientierung der Religionen. Die Katholiken wiesen signifikant höhere kollektivistische Werte auf als die Protestanten und die Nichtreligiösen, unterschieden sich jedoch nicht signifikant mit dem Rest. Die Hindus hatten signifikant höhere Werte als die Protestanten, die Atheisten, die Freikirchler und die Nichtreligiösen, unterschieden sich jedoch nicht signifikant von den Übrigen. Die Anhänger des Islam, des orthodoxen Christentums, des Judentums, der Naturreligionen und der Religionen, die in der Befragung nicht aufgeführt wurden, wiesen keine signifikanten Unterschiede bezüglich ihrer Religiosität mit den Gläubigen anderer Religionen auf.

5.2 Einordnung und Diskussion der Befunde

Im diesem Unterkapitel werden die Ergebnisse der Untersuchungen und der Post-hoc Analysen interpretiert, diskutiert und in den aktuellen Forschungsstand eingeordnet.

Die Ergebnisse der Regressionsanalyse bestätigen, dass Religiosität einen positiven Einfluss auf das Wohlbefinden hat. Ein höherer Wert an Religiosität wird demzufolge mit höherem psychischem Wohlbefinden assoziiert. Diese Ergebnisse fügen sich nahtlos in den bestehenden Forschungsstand ein und bestätigen die bisherigen Befunde zur positiven Beziehung zwischen Religiosität und Wohlbefinden. Die Studien von Dar und Iqbal (2019), Koenig und Al Shohaib (2024) und Van Cappellen et al. (2016) belegen durchweg eine positive Assoziation zwischen verschiedenen Dimensionen der Religiosität und Aspekten des Wohlbefindens, einschließlich Lebenszufriedenheit, Glück und Optimismus. Die vorliegende Arbeit unterstützt diese Befunde und erweitert sie, indem sie einen signifikanten direkten Effekt von Religiosität auf das Wohlbefinden nachweist. Besonders hervorzuheben ist, dass die Ergebnisse dieser Studie im Einklang mit den Befunden von Jokela (2022) stehen, die eine moderate positive Korrelation zwischen psychischem Wohlbefinden und religiöser Teilnahme sowie allgemeiner Religiosität fanden. Auch der negative Zusammenhang zwischen religiöser Teilnahme und psychischem Stress wird durch die vorliegenden Ergebnisse bestätigt. Diese Studie trägt somit dazu bei, die Bedeutung der religiösen Teilnahme und des allgemeinen religiösen Engagements für das psychische Wohlbefinden weiter zu untermauern. Des Weiteren korrespondieren die Ergebnisse mit den Befunden von Fernández und Rosell (2022), die eine negative Assoziation von organisierter und intrinsischer Religiosität mit depressiver und ängstlicher Symptomatik aufzeigten. Diese Studie erweitert diese Erkenntnisse, indem sie den direkten Einfluss von Religiosität auf das allgemeine Wohlbefinden bestätigt und somit die Relevanz von Religiosität als Ressource für die psychische Gesundheit unterstreicht.

Die vorliegende Moderationsanalyse testete, ob kulturelle Orientierung die Beziehung zwischen Religiosität und Wohlbefinden moderiert. Die Analyse zeigte einen nicht signifikanten Moderationseffekt der Kultur auf die Beziehung zwischen Religiosität und Wohlbefinden. Dies deutet darauf hin, dass die kulturelle Orientierung keinen moderierenden Einfluss auf die Beziehung zwischen Religiosität und Wohlbefinden hat. Nach der Entfernung des Interaktionsterms aus dem Modell zeigte das neue Modell mit Haupteffekten, dass sowohl Religiosität als auch Kultur signifikant mit dem Wohlbefinden zusammenhängen, wenn auch mit kleinen Effektgrößen. Die vorliegenden Ergebnisse

liefern wichtige Erkenntnisse zur Beziehung zwischen Religiosität, Kultur und Wohlbefinden. Während die kulturelle Orientierung nicht als Moderator dieser Beziehung bestätigt werden konnte, zeigen die signifikanten Haupteffekte, dass sowohl Religiosität als auch Kultur eigenständige positive Einflüsse auf das Wohlbefinden haben. Grund für den fehlenden Moderationseffekt kann die homogene Stichprobe sein, die eher kollektivistisch orientiert war, was die Identifikation von Moderationseffekten erschwert haben konnte. Die Ergebnisse der Haupteffekte stehen jedoch im Einklang mit der Forschung von Graham und Crown (2014) und Tay et al. (2014), die ebenfalls einen positiven Zusammenhang zwischen Wohlbefinden und Religiosität in verschiedenen Kulturen fanden. Zudem unterstützen die Ergebnisse die Annahmen von Hoogeveen et al. (2022) und Fernández und Rosell (2022), dass kulturelle Normen und individuelle religiöse Praktiken eine Rolle für das Wohlbefinden spielen. Allerdings konnten die spezifischen moderierenden Effekte von Kultur auf diese Beziehung in der vorliegenden Studie nicht bestätigt werden. Die signifikanten Haupteffekte der Kultur auf das psychische Wohlbefinden sind klein, aber praktisch relevant. Sie deuten darauf hin, dass kulturelle Orientierung, zusätzlich zur Religiosität, ein wichtiger Faktor für das Wohlbefinden ist.

Die Moderationsanalyse der H3 prüfte, ob das biologische Geschlechts die Beziehung zwischen Religiosität und psychischem Wohlbefinden moderiert. Ein signifikanter Moderationseffekt des Geschlechts auf die Beziehung zwischen Religiosität und Wohlbefinden wurde gefunden. Der kleine Effekt weist auf einen geringen Einfluss des Geschlechts auf die Beziehung zwischen Religiosität und Wohlbefinden. Die Ergebnisse sind konsistent mit den Befunden von Koenig und Al Shohaib (2024), die eine signifikante Interaktion zwischen Geschlecht und Religiosität in Bezug auf Lebenszufriedenheit fanden. Ebenso stimmen sie mit den Ergebnissen von Dar und Iqbal (2019) überein, die zeigten, dass das Gefühl von Bedeutung eine vermittelnde Rolle zwischen religiöser Verpflichtung und Wohlbefinden spielt, besonders bei Frauen. Die Studie von Lazar und Bjorck (2016) liefert weitere Unterstützung, indem sie aufzeigt, dass geschlechtsspezifische Unterschiede in der Unterstützung durch die religiöse Gemeinschaft und religiöse Führer bestehen. Diese Unterschiede spiegeln sich in den Ergebnissen wider, die nahelegen, dass Frauen mehr von der Unterstützung durch religiöse Gemeinschaften profitieren (Dar & Iqbal, 2019), während Männer stärker von der intrinsischen Religiosität beeinflusst werden (Koenig & Al Shohaib, 2024). Es gibt mehrere mögliche Erklärungen für die gefundenen geschlechtsspezifischen Unterschiede. Frauen könnten stärker von der sozialen und emotionalen Unterstützung profitieren, die durch religiöse Gemeinschaften und Praktiken

bereitgestellt wird. Sie sind möglicherweise stärker in religiöse Aktivitäten eingebunden und ziehen somit größere Vorteile für ihr Wohlbefinden daraus. Kulturelle Normen und Erwartungen bezüglich Geschlecht und Religion können ebenfalls eine Rolle spielen und die Art und Weise beeinflussen, wie Religiosität das Wohlbefinden von Frauen und Männern beeinflusst.

Die erste Post-hoc Analyse zeigte einen statistisch signifikanten Unterschied in der Religiosität zwischen Personen mit Migrationshintergrund verglichen mit Personen ohne Migrationshintergrund in den letzten drei Generationen auf. Erklärungen für diesen Fund kann sein, dass Migranten sich stärker an religiöse Gemeinschaften wenden, um soziale Unterstützung und ein Gefühl der Zugehörigkeit zu finden, insbesondere in einem fremden Land. Die Beibehaltung und Praktizierung der Religion kann eine wichtige Rolle bei der Aufrechterhaltung der kulturellen Identität und Traditionen spielen. Religiosität kann auch als Bewältigungsmechanismus dienen, um mit den Herausforderungen und Stressoren der Migration umzugehen, wie z.B. der Anpassung an eine neue Kultur und dem Verlust des sozialen Netzwerks im Heimatland. Diese Erkenntnisse haben wichtige Implikationen für die soziale und psychologische Unterstützung von Migranten. Die Unterstützung und Integration religiöser Gemeinschaften kann eine effektive Strategie sein, um das Wohlbefinden und die soziale Integration zu fördern. Programme zur Unterstützung der Integration sollten kulturelle und religiöse Aspekte berücksichtigen, um ihre Effektivität zu erhöhen.

Eine weitere explorative Analyse zeigte Unterschiede in der kulturellen Orientierung zwischen den unterschiedlichen Religionen auf. Die signifikant höheren kollektivistischen Werte der Katholiken verglichen mit den Protestanten und nicht religiösen Personen könnte auf die starke Betonung der Gemeinschaft, Nächstenliebe und der sozialen Unterstützung innerhalb der katholischen Kirche zurückführbar sein. Auch der hohe kollektivistische Wert unter den Hindus könnte durch die tief verwurzelten sozialen Strukturen, Gemeinschaftsorientierungen und der Vorstellung von Karma im Hinduismus erklärt werden, die oft durch familiäre und gemeinschaftliche Bindungen geprägt sind.

5.3 Bewertung der Methode

Dieses Unterkapitel betrachtet die verwendete Methode genauer und geht auf ihre Stärken und Schwächen ein.

Durch die erreichte Stichprobe von $N = 429$ konnte die zuvor berechnete

Mindeststichprobe von 395 Probanden erreicht werden. Dies ist ein Argument für eine valide Erhebung einer quantitativen Querschnittsstudie. Die Stichprobe wurde nichtrandomisiert erhoben, die sich durch den Schneeballeffekt vergrößerte.

Für die vorliegende Studie wurden der WHO-5, die COS, der DUREL und die deutsche Version der Religious Commitment Scale verwendet. Bis auf die COS sind die Fragebögen mit jeweils nur fünf Items relativ kurz. Diese zeitliche Effizienz minimierte die Belastung der Teilnehmenden, was die Wahrscheinlichkeit erhöhte, dass alle Fragen vollständig und aufmerksam beantwortet wurden. Die geringere kognitive Belastung kann die Qualität der erhobenen Daten positiv beeinflusst haben, da sie weniger anfällig für Ermüdungseffekte und ungenaue Bearbeitung war. Der COS war der längste der verwendeten Fragebögen, fand jedoch aufgrund seiner umfassenden Abdeckung der kulturellen Orientierung Verwendung und verlängerte die Gesamtbearbeitungsdauer nicht unnötig.

Die verwendeten Fragebögen zur Erhebung von Religiosität, die Deutsche Version der Religious Commitment Scale und der DUREL, zeigten beide eine hohe Reliabilität und Validität auf (Klumparendt & Drenckhan, 2014; Koenig & Büssing, 2010). Durch die Verwendung beider Fragebögen sollten sowohl die persönliche Einstellung zur Religiosität wie auch das eigene religiöse Handeln erfragt werden. Eine explorative Faktoranalyse zeigte jedoch, dass die Skalen auf einen gemeinsamen Faktor laden, der Religiosität allgemein betrachtet. Um potenziell unterschiedliche Auswirkungen der Einstellung wie auch des Verhaltens untersuchen zu können, sollten diese durch andere Mittel erfolgen. Dennoch eigneten sich die Fragebögen gut für die Erhebung der Religiosität, da die Hypothesen keine spezifischen Eigenschaften von Religiosität betrachteten. Die Platzierung der Religiositätsfragebögen zu Beginn der Befragung habe möglicherweise dazu geführt, dass einige Personen, die kein Interesse in Religion und Glaube haben, die Bearbeitung vorzeitig abgebrochen haben. Dies könnte den geringen Anteil nicht gläubiger und Atheisten im Vergleich zu den Gläubigen und einer Religion zugehörigen, erklären, da einige Personen den Fragebogen abbrachen sobald sie zu den Religiositätsfragebögen kamen.

Ein weiterer Aspekt der Methodik betrifft die Untersuchung von Kulturunterschieden. Der COS wurde verwendet, um die kulturelle Orientierung der Teilnehmenden zu bestimmen und mögliche Kulturunterschiede zu untersuchen. Die Stichprobe setzt sich zu etwa 50% aus in Spanien lebenden Personen, zu fast einem Drittel aus in Deutschland lebenden Personen und zu einem kleineren Teil aus Personen aus der restlichen Welt (10.49%) zusammen. Diese Vorgehensweise kann weiter optimiert

werden. Eine alternative und möglicherweise bessere Methode wäre, ausschließlich Personen aus Spanien und Deutschland zu erheben. Diese würde wahrscheinlich dazu führen, dass von den Weltreligionen primär das Christentum betrachtet wird, was jedoch sowieso in dieser Studie der Fall war. Die Beschränkung auf nur zwei Länder hätte die Aussagekraft der COS nicht zwangsläufig beeinträchtigt, da auch innerhalb eines Landes unterschiedliche (sub-)kulturelle Orientierungen bestehen können, kann aber präzisere Vergleiche ermöglichen.

Ein weiterer Punkt betrifft die Art und Weise, wie der kulturelle Hintergrund erhoben wurde. Es ist möglich, dass Gläubige durch ihre stärkere Integration in eine religiöse Gruppe ein stärkeres kollektivistisches Gefühl haben. Diese starke Gruppenzugehörigkeit könnte die kulturelle Orientierung beeinflussen und sollte bei zukünftigen Erhebungen berücksichtigt werden. Eine differenzierte Erhebung des kulturellen Hintergrunds könnte daher zu präziseren Ergebnissen führen.

Durch das Onlinemedium konnte kein Einfluss auf Störvariablen erfolgen und überließ den Teilnehmenden die Verantwortung, unter welchen Bedingungen sie an der Studie teilnahmen. Durch einen fehlenden Versuchsleiter entfiel dessen Effekt, wie zum Beispiel, dass sich ein Proband dadurch beobachtet fühlen kann. Dies führte zu objektiveren Datenerhebungen. Dennoch konnte keine aktive Kontrolle der möglichen Störvariablen erfolgen.

Zusammenfassend kann die Erhebung der Daten durch die standardisierten Fragebögen als valide betrachtet werden. Dennoch sollte bei einer erneuten Untersuchung auf eine verbesserte Methodik geachtet werden.

5.4 Ausblick

In diesem abschließenden Kapitel werden die Konsequenzen und Folgen der gewonnenen Erkenntnisse genannt, ebenfalls wird auf einen weiteren Forschungsbedarf hingewiesen.

Die vorliegende Untersuchung liefert wertvolle Einblicke in die Beziehung zwischen Religiosität, Wohlbefinden und kultureller Orientierung. Die Ergebnisse zeigen, dass Religiosität einen signifikant positiven Einfluss auf das Wohlbefinden hat, während die kulturelle Orientierung und das biologische Geschlecht ebenfalls eigenständige, wenn auch geringe Effekte auf das Wohlbefinden ausüben. Diese Befunde unterstreichen die Notwendigkeit, das Verständnis dieser Zusammenhänge zu vertiefen und spezifische Ansätze

zur Förderung des Wohlbefindens zu entwickeln.

Ein bedeutender Befund der Studie ist, dass die kulturelle Orientierung keinen moderierenden Einfluss auf die Beziehung zwischen Religiosität und Wohlbefinden hat. Dies deutet darauf hin, dass der positive Effekt der Religiosität auf das Wohlbefinden weitgehend unabhängig von der kulturellen Orientierung ist. Zugleich wurde jedoch festgestellt, dass sowohl Religiosität als auch Kultur signifikant mit dem Wohlbefinden korrelieren. Diese Ergebnisse heben die Bedeutung von sowohl religiösen als auch kulturellen Aspekten für das psychische Wohlbefinden hervor und weisen auf die Notwendigkeit hin, beide Faktoren in Präventions- und Interventionsprogrammen zu berücksichtigen. Die Ergebnisse der explorativen Analysen zeigen höhere Werte an Religiosität bei Migranten. Auch wenn der Effekt von Religiosität auf das Wohlbefinden nur gering bis mittel ist, können Migranten über ihre entsprechenden Religionen und deren lokalen Gemeinschaften in Kontakt zu Einheimischen treten und so ihr Wohlbefinden stärken. Dieser Effekt ist wahrscheinlich bei Frauen katholischen Glaubens oder Hindus stärker, da Katholiken und Hindus stärker kollektivistisch ausgerichtet sind und bei Frauen der Effekt von Religiosität stärker ausfällt als bei Männern.

Die Generalisierbarkeit der Ergebnisse ist aufgrund der spezifischen Zusammensetzung der Stichprobe und methodischer Einschränkungen begrenzt. Die nicht-randomisierte Stichprobe, die sich durch den Schneeballeffekt vergrößerte, sowie mögliche Verzerrungen durch sozial erwünschte Antworten, stellen methodische Herausforderungen dar. Eine größere und repräsentativere Stichprobe könnte zu differenzierteren Ergebnissen führen und erhöht die Aussagekraft der Ergebnisse.

Zukünftige Studien sollten größere und diversifizierte Stichproben umfassen, um die externe Validität zu erhöhen. Dabei sollten präzisere Messinstrumente verwendet werden, um die potenziellen Moderationseffekte der Kultur auf die Beziehung zwischen Religiosität und Wohlbefinden genauer zu erfassen. Zusätzlich könnten qualitative Ansätze zusätzliche Einblicke in die subjektiven Erfahrungen und Wahrnehmungen von Individuen in verschiedenen kulturellen Kontexten bieten. Eine vertiefende Analyse unter Einbeziehung weiterer Variablen wie individueller Lebensgeschichten oder detaillierterer kultureller Hintergründe könnte ein umfassenderes Verständnis der Zusammenhänge zwischen Religiosität, Kultur und Wohlbefinden liefern. Auch eine Untersuchung des Einflusses der Religiosität auf das Wohlbefinden in Krisenzeiten kann wertvoll sein, da diese Ergebnisse den Effekt der Handlungen der Religionsführern und in solchen Zeiten hervorheben könnte. Auch die Lehren der einzelnen Religionen könnte den Gläubigen

einen stärkeren Halt geben und sie durch die schweren Zeiten tragen. Da vor allem bei Frauen ein stärkerer Effekt der Religiosität auf das Wohlbefinden herrscht, sollten diese in solchen Zeiten stärker in ihrem Glauben unterstützt werden, wenn denn ein solcher Effekt besteht. Auch wenn der Effekt des Geschlechts nur gering ist, stellt sich trotzdem die Frage, ob der Effekt der Religiosität auf das Wohlbefinden bei Frauen sich auch auf deren Familie überträgt.

Zudem sollten zukünftige Forschungsvorhaben darauf abzielen, die zugrunde liegenden Mechanismen geschlechtsspezifischer Unterschiede weiter zu untersuchen und die praktischen Anwendungen dieser Erkenntnisse zu verbessern. Qualitative Studien könnten zusätzliche Einblicke in die subjektiven Erfahrungen von Frauen und Männern in verschiedenen religiösen Kontexten bieten und somit zur Entwicklung differenzierterer Interventionsstrategien beitragen.

Die praktischen Implikationen der Ergebnisse sind vielfältig. Bildungs- und Aufklärungsprogramme für Therapeuten und Berater können entwickelt werden, um das Verständnis für die positive Rolle der Religiosität im psychischen Wohlbefinden zu fördern. Diese Programme könnten religiöse Praktiken in Gesundheits- und Präventionsmaßnahmen integrieren, um das Wohlbefinden v.a. bei Frauen zu steigern. Insbesondere könnten kulturelle Eigenschaften in der psychischen Gesundheitsförderung und Präventionsarbeit berücksichtigt werden, um eine ganzheitliche Unterstützung der Individuen zu gewährleisten. Auch außerhalb des Gesundheitswesens können die Befunde praktisch integriert werden. Vor allem katholische und hinduistische Gemeinden könnten sich um die Integration katholischer bzw. hinduistischer Migrantinnen bemühen, um deren psychisches Wohlbefinden zu fördern.

Die vorliegenden Ergebnisse unterstützen bestehende Theorien über die positive Beziehung zwischen Religiosität und Wohlbefinden und erweitern das Verständnis der sozialen Dynamiken, die diese Beziehung beeinflussen (Dar & Iqbal, 2019; Fernández & Rosell, 2022; Hoogeveen et al., 2022; Jokela, 2022; Koenig & Al Shohaib, 2024; Van Cappellen et al., 2016). Diese Befunde könnten genutzt werden, um bestehende theoretische Modelle zu modifizieren und neue Ansätze zu entwickeln, die die komplexen Interaktionen zwischen Religiosität, Kultur und Wohlbefinden besser erklären.

Eine interdisziplinäre Herangehensweise kann dazu beitragen, ein umfassenderes Bild der Zusammenhänge zwischen Religiosität, Kultur und Wohlbefinden zu zeichnen. Durch Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Fachbereichen, wie beispielsweise der Psychologie, Soziologie und Kulturgeschichte, könnten innovative Lösungen zur Förderung

des Wohlbefindens und zur Verbesserung der Lebensqualität entwickelt werden. Wechselseitig können die Erkenntnisse auch verwendet werden, um bspw. die Akzeptanz und Durchführung von humanitären Projekten und Gesundheitsprogrammen in Regionen zu fördern, deren Kultur und Religion sich von denen der Geberländer und deren Bevölkerung unterscheiden.

Die vorliegende Forschung hebt die bedeutende Rolle der Religiosität für das psychische Wohlbefinden hervor. Diese Erkenntnisse leisten einen wichtigen Beitrag zum Verständnis der positiven Effekte religiöser Praktiken und kultureller Orientierung und bilden eine Grundlage für zukünftige Forschung und Interventionen. Die fortgesetzte Auseinandersetzung mit diesen Themen durch wissenschaftliche Untersuchungen kann zu einer bewussteren Beschäftigung mit dem Thema in der Öffentlichkeit führen.

Literaturverzeichnis

- Allolio-Näcke, L. & Demmrich, S. (2022). Religion und Religiosität. In U. Wolfradt, L. Allolio-Näcke & P. S. Ruppel (Hrsg.), *Kulturpsychologie: Eine Einführung* (S. 377–386). Wiesbaden: Springer.
- Bandura, A. (1997). *Self-efficacy: The exercise of control*. New York, NY: W.H. Freeman und Company.
- Bierbrauer, G., Meyer, H. & Wolfradt, U. (2002). COS. Cultural Orientation Scale [Verfahrensdokumentation und Fragebogen auf Deutsch, Englisch, Russisch und Spanisch]. In Leibniz-Institut für Psychologie (ZPID) (Hrsg.), *Open Test Archive*. Trier: Leibniz-Institut für Psychologie (ZPID).
- Borrell-Carrió, F., Suchman, A. L. & Epstein, R. M. (2004). The biopsychosocial model 25 years later: Principles, practice, and scientific inquiry. *Annals of Family Medicine*, 2(6), 576–582. doi:<https://doi.org/10.1370/afm.245>
- Bowker, J. (2003). *The Concise Oxford Dictionary of World Religions*. Oxford University Press.
- Brähler, E., Mühlan, H., Albani, C. & Schmidt, S. (2007). Teststatistische Prüfung und Normierung der deutschen Versionen des EUROHIS-QOL Lebensqualität-Index und des WHO-5 Wohlbefindens-Index. *Diagnostica*, 53, 83–96. doi:<https://doi.org/10.1026/0012-1924.53.2.83>
- Büssing, A. (2008). Spiritualität – inhaltliche Bestimmung und Messbarkeit. *Prävention*, 31(2), 35–37.
- Carver, C. S. (2010). Resilience and thriving: Issues, models, and linkages. *Journal of Social Issues*, 54(2), 245–266. doi:<https://doi.org/10.1111/j.1540-4560.1998.tb01217.x>
- Cohen, A. B. (2015). Religion's Profound Influences on Psychology: Morality, Intergroup Relations, Self-Construal, and Enculturation. *Current Directions in Psychological Science*, 24(1), 77–82. doi:<https://doi.org/10.1177/0963721414553265>
- Croucher, S. M., Zeng, C., Rahmani, D. & Sommer, M. (2017, Januar). Religion, Culture, and Communication. doi:<https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228613.013.166>
- Dar, K. A. & Iqbal, N. (2019). Religious Commitment and Well-Being in College Students: Examining Conditional Indirect Effects of Meaning in Life. *Journal of Religion and Health*, 58, 2288–2297. doi:<https://doi.org/10.1007/s10943-017-0538-2>

- Das, K. V., Jones-Harrell, C., Fan, Y., Ramaswami, A., Orlove, B. & Botchwey, N. (2020). Understanding subjective well-being: perspectives from psychology and public health. *Public Health Reviews*, 42(25). doi:<https://doi.org/10.1186/s40985-020-00142-5>
- Deci, E. L. & Ryan, R. M. (2000). The “What” and “Why” of goal pursuits. Human needs and the self-determination of behavior. *Psychological Inquiry*, 11(4), 227–268. doi:https://doi.org/10.1207/S15327965PLI1104_01
- Dhanabhakyaam, M. & Sarath, M. (2023). Psychological Wellbeing: A systematic Literature Review. *International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJAR SCT)*, 3(1), 603–607. doi:<https://doi.org/10.48175/IJAR SCT-8345>
- Diener, E., Oishi, S. & Lucas, R. E. (2009). Subjective Well-Being: The Science of Happiness and Life Satisfaction. In S. J. Lopez & C. R. Snyder (Hrsg.), *The Oxford Handbook of Positive Psychology*. doi:<https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780195187243.013.0017>
- Diener, E., Suh, E., Lucas, R. & Smith, H. L. (1999). Subjective Well-Being: Three Decades of Progress. *Psychological Bulletin*, 125(2).
- Durkheim, E. (1915). Definition of Religious Phenomena and of Religion. In *The Elementary Forms of the Religious Life* (S. 47). London: George Allen & Unwin LTD.
- Durkheim, E. (1981). *Die elementare Formen des religiösen Lebens* (L. Schmidts, Übers.). Frankfurt am Main: Verlag der Weltreligionen.
- Engel, G. L. (1977). The need for a new medical model: A challenge for biomedicine. *Science*, 196(4286), 129–136. doi:<https://doi.org/10.1126/science.847460>
- European Union. (2021). 7.2% of people in the EU suffer from chronic depression. Verfügbar unter <https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/edn-20210910-1>
- Fernández, M. B. & Rosell, J. (2022). An Analysis of the Relationship Between Religiosity and Psychological Well-Being in Chilean Older People Using Structural Equation Modeling. *Journal of Religion and Health*, 61, 1585–1604. doi:<https://doi.org/10.1007/s10943-021-01442-z>
- Forschungsgruppe Weltanschauungen in Deutschland. (2021). Religionszugehörigkeiten 2020. Verfügbar unter <https://fowid.de/meldung/religionszugehoerigkeiten-2020>
- Graham, C. & Crown, S. (2014). Religion and wellbeing around the world: Social purpose, social time, or social insurance? *International Journal of Wellbeing*, 4(1), 1–27. doi:<https://doi.org/10.5502/ijw.v4i1.1>
- Griffiths, P. J. (2000). The Very Idea of Religion. *First Things*, (103), 30–35.

- Hardy, S. A., Nelson, J. M., Moore, J. P. & King, P. E. (2019). Processes of Religious and Spiritual Influence in Adolescence: A Systematic Review of 30 Years of Research. *Journal of research on adolescence : the official journal of the Society for Research on Adolescence*, 29(2), 254–275. doi:<https://doi.org/10.1111/jora.12486>
- Hayes, A. F. (2018). *Introduction to Mediation, Moderation, and Conditional Process Analysis, Second Edition: Methodology in the Social Sciences* (2nd ed.). Guildford Press.
- Hemel, U. (2023). Der Einfluss der Religionen auf die Frauengesundheit. In J. Wacker, C. Rothe & M. En-Nosse (Hrsg.), *Globale Frauengesundheit: Gynäkologie und Geburtshilfe unter unterschiedlichen globalen Bedingungen* (S. 71–82). doi:https://doi.org/10.1007/978-3-662-66081-2_6
- Hernandez, M. & Gibb, J. K. (2019). Culture, behavior and health. *Evolution, Medicine, and Public Health*, 2020(1), 12–13. doi:<https://doi.org/10.1093/emph/eoz036>
- Hewlett, B. S. & Hewlett, B. L. (2008). Ourbreak Control. In J. A. Young (Hrsg.), *Ebola, Culture and Politics: The Anthropology of an Emerging Disease* (S. 111–130). CA: Wadsworth Cengage Learning.
- Hoffmann, R. (1984). Erleben von Glück - eine empirische Untersuchung. *Psychologische Beiträge*, 26(3), 516–532.
- Hofstede, G. (2001). Individualism and Collectivism. In *Culture's consequences. Comparing values, behaviors, institutions and organizations across nations* (2. Aufl.). Thousand Oaks: Sage.
- Hofstede, G. (2024). The 6-D model of national culture. Verfügbar unter <https://geerthofstede.com/culture-geert-hofstede-gert-jan-hofstede/6d-model-of-national-culture/>
- Hoogeveen, S., Sarafoglou, A., Aczel, B., Aditya, Y., Alayan, A. J., Allen, P. J., ... Wagenmakers, E.-J. (2022). A many-analysts approach to the relation between religiosity and well-being. *Religion, Brain & Behavior*, 13(3), 237–283. doi:<https://doi.org/10.1080/2153599X.2022.2070255>
- Hornberg, C. (2016). Gesundheit und Wohlbefinden. In U. Gebhard & T. Kistemann (Hrsg.), *Landschaft, Identität und Gesundheit: Zum Konzept der Therapeutischen Landschaften* (S. 63–69). doi:https://doi.org/10.1007/978-3-531-19723-4_5
- Izard, C. E. (1994). Freude: Eine Einführung in die Grundlagen der Emotionspsychologie (B. Murakami, Übers.). In, *Die Emotionen des Menschen* (3. Auflage, S. 271–312). Beltz, Psychologie-Verlags-Union.

- Jakobs, M. (2018). Religion und Gesundheit aus religionspsychologischer Perspektive - und was dies für die Religionspädagogik bedeutet. *Theo-Web. Zeitschrift für Religionspädagogik*, 17(1), 83–100. doi:<https://doi.org/10.23770/tw0048>
- Jokela, M. (2022). Religiosity, Psychological Distress, and Well-Being: Evaluating Familial Confounding With Multicohort Sibling Data. *American Journal of Epidemiology*, 191(4), 584–590. doi:<https://doi.org/10.1093/aje/kwab276>
- Joseph, R. (2011). Evolution of Paleolithic Cosmology and Spiritual Consciousness, and the Temporal and Frontal Lobes. *Journal of Cosmology*, 14, 4400.
- Karasz, A., Gany, F., Escobar, J., Flores, C., Prasad, L., Inman, A., ... Diwan, S. (2019). Mental Health and Stress Among South Asians. *Journal of Immigrant Minority Health*, 21(Suppl 1), 7–14. doi:<https://doi.org/10.1007/s10903-016-0501-4>
- Kiecolt-Glaser, J. K., McGuire, L., Robles, T. F. & Glaser, R. (2002). Emotions, morbidity, and mortality: New perspectives from psychoneuroimmunology. *Annual Review of Psychology*, 53, 83–107. doi:<https://doi.org/10.1146/annurev.psych.53.100901.135217>
- Klumparendt, A. & Drenckhan, I. (2014). *Deutsche Version der Religious Commitment Scale*. Zusammenstellung sozialwissenschaftlicher Items und Skalen (ZIS). doi:<https://doi.org/10.6102/zis217>
- Knecht, J. (2020). Kulturdimensionen nach Hofstede - kurz zusammengefasst. Verfügbar unter https://praxistipps.focus.de/kulturdimensionen-nach-hofstede-kurz-zusammengefasst_124852
- Koenig, H. G. (2010). Spirituality and mental health. *International Journal of Applied Psychoanalytic Studies*, 7, 116–122. doi:<https://doi.org/10.1002/aps.239>
- Koenig, H. G. (2012). Religion, spirituality, and health: The research and clinical implications. *International Scholarly Research Network Psychiatry*, 1–33. doi:<https://doi.org/10.5402/2012/278730>
- Koenig, H. G. & Al Shohaib, S. (2024). Religious involvement and psychological well-being in the Middle East. *The International Journal of Psychiatry in Medicine*, 59(3), 341–359. doi:<https://doi.org/10.1177/00912174231197548>
- Koenig, H. G. & Büssing, A. (2010). The Duke University Religion Index (DUREL): A Five-Item Measure for Use in Epidemiological Studies. *Religion*, 1, 78–85. doi:<https://doi.org/10.3390/rel1010078>
- Koenig, H. G., Parkerson, G. R. & Meador, K. G. (1997). Religion index for psychiatric research. *The American Journal of Psychiatry*, 154(6), 885–886. doi:<https://doi.org/10.1176/ajp.154.6.885b>

- Koenig, H. G., VanderWeele, T. J. & Peteet, J. R. (2024, Januar). 3C1Definitions. In *Handbook of Religion and Health*. Oxford University Press.
- Köhrsen, J. (2024). Religion und Ökologie. In M. Sonnberger, A. Bleicher & M. Groß (Hrsg.), *Handbuch Umweltsoziologie* (S. 477–489). doi:https://doi.org/10.1007/978-3-658-37218-7_48
- Krause, C. (2015). Spirituelle und religiöse Praktiken – Auswirkungen auf Gesundheit und Wohlbefinden. In *Mit dem Glauben Berge versetzen? Psychologische Erkenntnisse zur Spiritualität* (S. 131–144). doi:https://doi.org/10.1007/978-3-662-48457-9_7
- Lazar, A. & Bjorck, L. P. (2016). Religious support and psychological well-being: gender differences among religious Jewish Israelis. *Mental Health, Religion & Culture*, 19(4), 393–407. doi:<https://doi.org/10.1080/13674676.2016.1207160>
- Lazarus, R. S. & Folkman, S. (1987). Transactional theory and research on emotions and coping. *European Journal of Personality*, 1(3), 141–169. doi:<https://doi.org/10.1002/per.2410010304>
- Lucas, R. E. (2016). Subjective Well-Being in Psychology. In M. D. Adler & M. Fleurbaey (Hrsg.), *The Oxford Handbook of Well-Being and Public Policy*. doi:<https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199325818.013.13>
- Maly-Motta, H. (2023). Subjektives Wohlbefinden. In *Gestersste Eltern* (S. 13–15). doi:<https://doi.org/10.1007/978-3-658-41224-1>
- Matsumoto, D. & Juang, L. (2016). *Culture and psychology* (6th). Belmont, CA: Cengage Learning.
- Mayring, P. (1991). Die Erfassung subjektiven Wohlbefindens. In A. Abele & P. Becker (Hrsg.), *Wohlbefinden. Theorie, Empirie, Diagnostik* (S. 51–71). Weinheim: Juventa.
- McGlichey, S., Waters, R. & Scheinpflug, C. (2023). Religion and Culture - Difference and Similarity. In S. McGlinchey (Hrsg.), *International Relations* (S. 9.3.1). E-International Relations.
- Monroe, M. W., Spicer, R., Canlas, G. M., Chilcott, T., Christopher, S., Daniels, M., ... Slingerland, E. (2023). On the Category of Religion: A Taxonomic Analysis of a Large-Scale Database. *Journal of the American Academy of Religion*, 91(2), 257–282. doi:<https://doi.org/10.1093/jaarel/lfad065>
- Nelson, S. K., Kushlev, K. & Lyubomirsky, S. (2014). The pains and pleasures of parenting: When, why, and how is parenthood associated with more or less well-being? *Psychological Bulletin*, 140(3), 846–895. doi:<https://doi.org/10.1037/a0035444>

- Ng, J. Y. Y., Ntoumaniy, N., Thøgersen-Ntoumani, C., Deci, E. L., Ryan, R. M., Duda, J. L. & Williams, G. C. (2012). Self-Determination Theory Applied to Health Contexts: A Meta-Analysis. *Perspectives on Psychological Science*, 7(4), 325–340. doi:<https://doi.org/10.1177/1745691612447309>
- Norenzayan, A. & Shariff, A. F. (2008). The Origin and Evolution of Religious Prosociality. *Science*, 322(5898), 58–62.
- Pargament, K. I. (1997). *The psychology of religion and coping: Theory, research, practice*. New York, NY: Guilford Press.
- Pearlin, L. I. (2010). The Life Course and the Stress Process: Some Conceptual Comparison. *The Journal of Gerontology: Series B: Psychological Sciences and Social Sciences*, 65B(2), 207–215. doi:<https://doi.org/10.1093/geronb/gbp106>
- Pew Research Center. (2019). Religion's Relationship to Happiness, Civic Engagement and Health Around the World: In the U.S. and other countries, participation in a congregation is a key factor. Verfügbar unter <https://www.pewresearch.org/religion/2019/01/31/religions-relationship-to-happiness-civic-engagement-and-health-around-the-world/>
- Pew Research Center. (2022). Key Findings From the Global Religious Futures Project. Verfügbar unter <https://www.pewresearch.org/religion/2022/12/21/key-findings-from-the-global-religious-futures-project/>
- Röhrle, B. (2023). Wohlbefinden / Well-Being. In *Leitbegriffe der Gesundheitsförderung und Prävention. Glossar zu Konzepten, Strategien und Methoden*. doi:<https://doi.org/10.17623/BZGA:Q4-i134-1.0>
- Sapolsky, R. M. (2004). *Why zebras don't get ulcers: The acclaimed guide to stress, stress-related diseases, and coping*. New York, NY: Henry Holt und Company.
- Schmider, E., Ziegler, M., Dana, E. & Beyer, L. (2010). Is it really robust? *Methodology European Journal of Research Methods for the Behavioral and Social Sciences*, 6(4). doi:<https://doi.org/10.1027/1614-2241/a000016>
- Schneider, G. & Toyka-Seid, C. (2024a). Religion. Verfügbar unter <https://www.bpb.de/kurz-knapp/lexika/das-junge-politik-lexikon/321041/religion/>
- Schneider, G. & Toyka-Seid, C. (2024b). Säkularisierung. Verfügbar unter <https://www.hanisauland.de/wissen/lexikon/grosses-lexikon/s/saekularisierung.html>
- Seybold, K. S. & Hill, P. C. (2001). The Role of Religion and Spirituality in Mental and Physical Health. *Current Directions in Psychological Science*, 10(1), 21–24. doi:<https://doi.org/10.1111/1467-8721.00106>

- Sischka, P. E., Costa, A. P., Steffgen, G. & Schmidt, A. F. (2020). The WHO-5 well-being index – validation based on item response theory and the analysis of measurement invariance across 35 countries. *Journal of Affective Disorders Reports*, 1, 100020. doi:<https://doi.org/10.1016/j.jadr.2020.100020>
- Tay, L., Li, M., Myers, D. & Diener, E. (2014). Religiosity and subjective well-being: An international perspective. In C. Kim-Prieto (Hrsg.), *Religion and Spirituality Across Cultures. Cross-Cultural Advancements in Positive Psychology* (S. 163–175). doi:https://doi.org/10.1007/978-94-017-8950-9_9
- The Britannica Dictionary. (2024). religion. Verfügbar unter <https://www.britannica.com/dictionary/religion>
- Triandis, H. C. (1994). *Culture and social behavior*. New York, NY: McGraw-Hill.
- Trojan, A. & Legewie, H. (2001). *Nachhaltige Gesundheit und Entwicklung: Leitbilder, Politik und Praxis der Gestaltung gesundheitsförderlicher Umwelt- und Lebensbedingungen*. Frankfurt: Verlag für Akademische Schriften.
- Uchino, B. N. (2006). Social support and health: A review of physiological processes potentially underlying links to disease outcomes. *Journal of Behavioral Medicine*, 29(4), 377–387. doi:<https://doi.org/10.1007/s10865-006-9056-5>
- Utlar, A. (2020). Kultur, Kulturdimensionen und Kulturstandards. In T. Ringeisen, P. Genkova & F. T. L. Leong (Hrsg.), *Handbuch Stress und Kultur: Interkulturelle und kulturvergleichende Perspektiven* (S. 1–17). doi:https://doi.org/10.1007/978-3-658-27825-0_3-1
- Van Cappellen, P., Toth-Gauthier, M., Saroglou, V. & Fredrickson, B. L. (2016). Religion and Well-Being: The Mediating Role of Positive Emotions. *Journal of Happiness Studies*, 17, 485–505. doi:<https://doi.org/10.1007/s10902-014-9605-5>
- Weltgesundheitsorganisation Regionalbüro für Europa. (2024). Kulturelle Kontexte von Gesundheit und Wohlbefinden. Verfügbar unter <https://who-sandbox.squiz.cloud/de/health-topics/health-determinants/behavioural-and-cultural-insights-for-health/cultural-contexts-of-health-and-well-being>
- Wielga, J. & Knospe, T. (2023). *Kulturelle und soziale Faktoren der Gesundheitskompetenz: Ein erster explorativer Ansatz* (Research Report Nr. 03/2023). Gelsenkirchen: Institut Arbeit und Technik (IAT). doi:<https://doi.org/10.53190/fa/202303%0A>
- Wilczewski, M., Wang, R., Du, R., Söderberg, A., Giuri, P., Mughan, T., ... Jacob, M. J. (2023). Cultural novelty and international students' experience: a five-country study. *Higher Education*, 86, 1107–1128.

World Health Organization. (1948). *Constitution of the World Health Organization*.

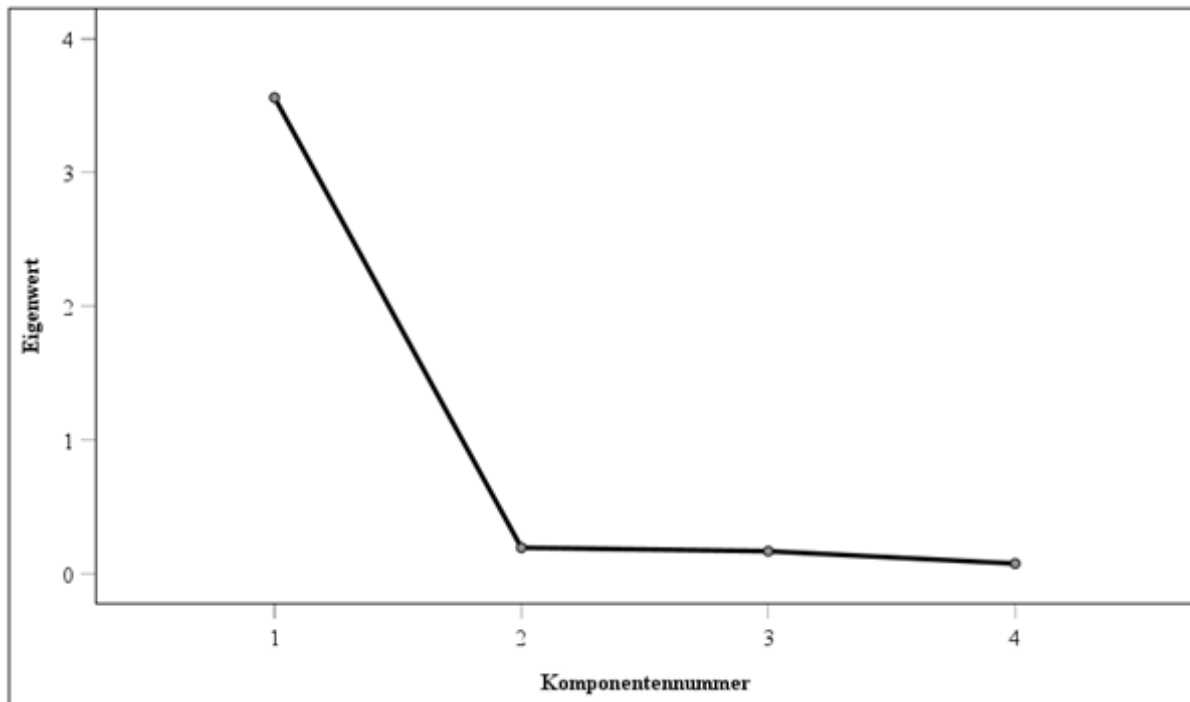
World Health Organization. (1998). WHO (Five) Well-being Index. Verfügbar unter <https://www.psykiatri-regionh.dk/who-5/who-5-questionnaires/Pages/default.aspx>

World Population Review. (2024). Religion by Country 2024. Verfügbar unter <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/religion-by-country>

Zurlo, G. A. (2021). Religions in Europe: A Statistical Summary. In G. Davie & L. N. Leustean (Hrsg.), *The Oxford Handbook of Religion and Europe* (S. 793–798). doi:<https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780198834267.005.0001>

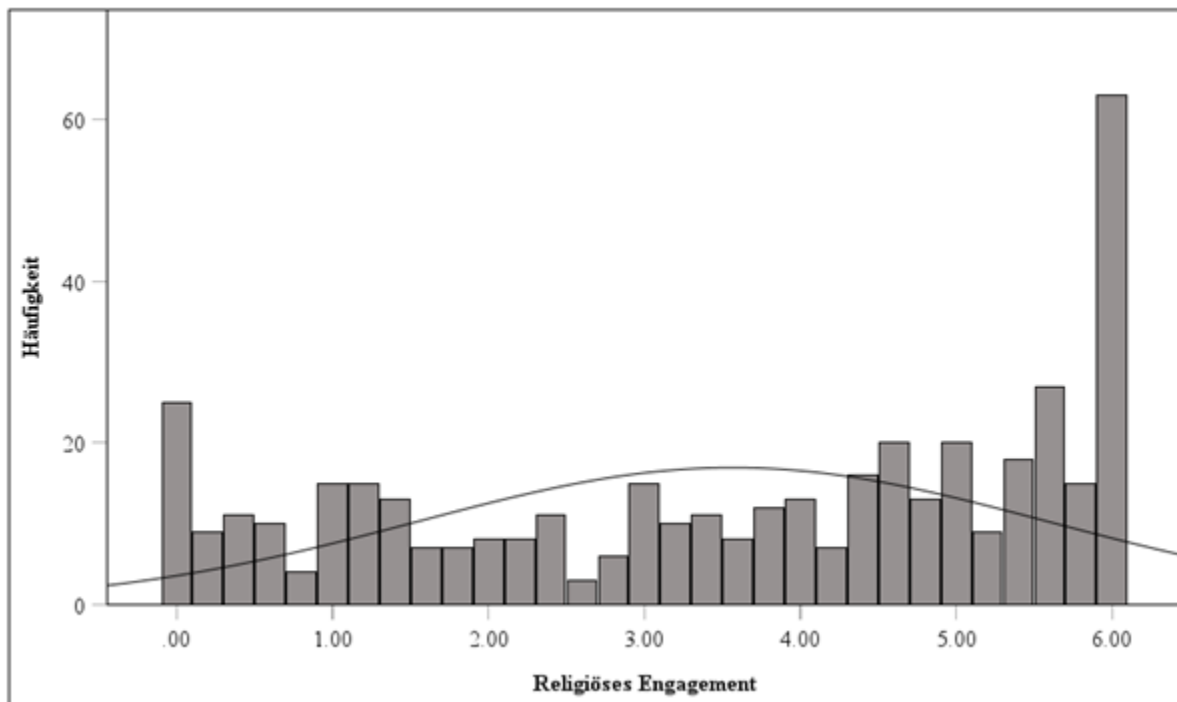
Anhang A

Screeplot zur Bestimmung der Faktorenanzahl



Anhang B

Verteilung des religiösen Engagements



Anhang C

Verteilung der DUREL-Subskalen ORA, NORA und IR

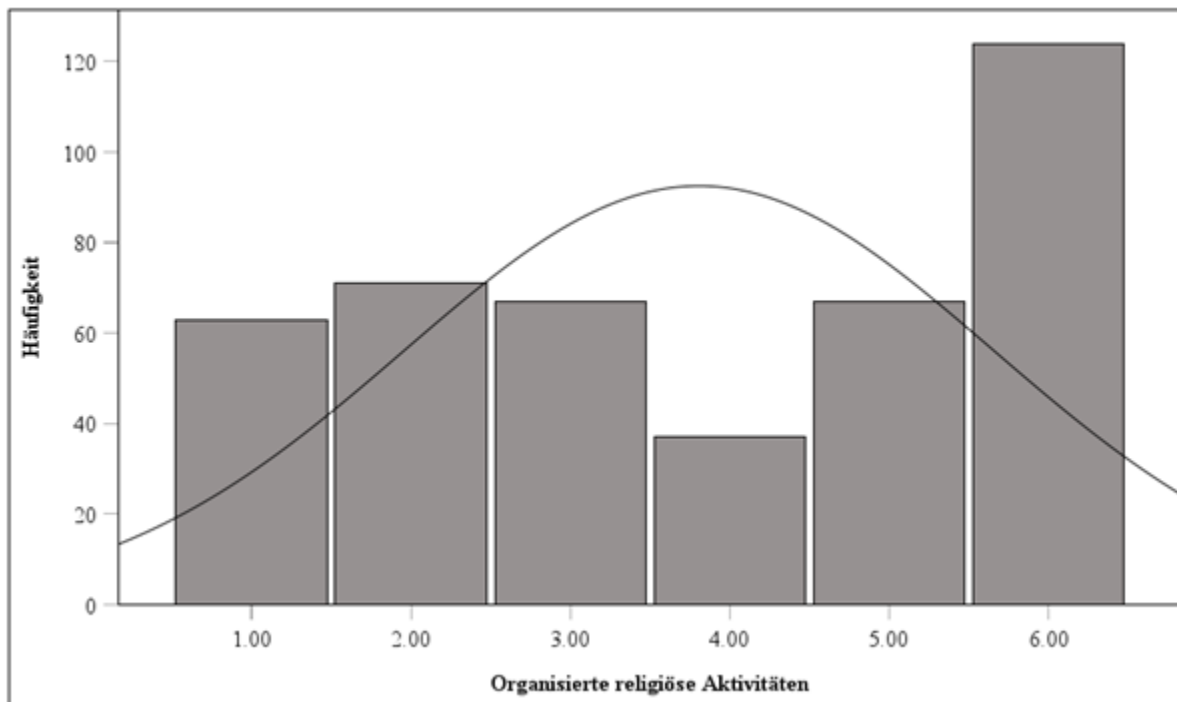


Abbildung 3. Verteilung der DUREL-Subskala Organisierte religiöse Aktivitäten

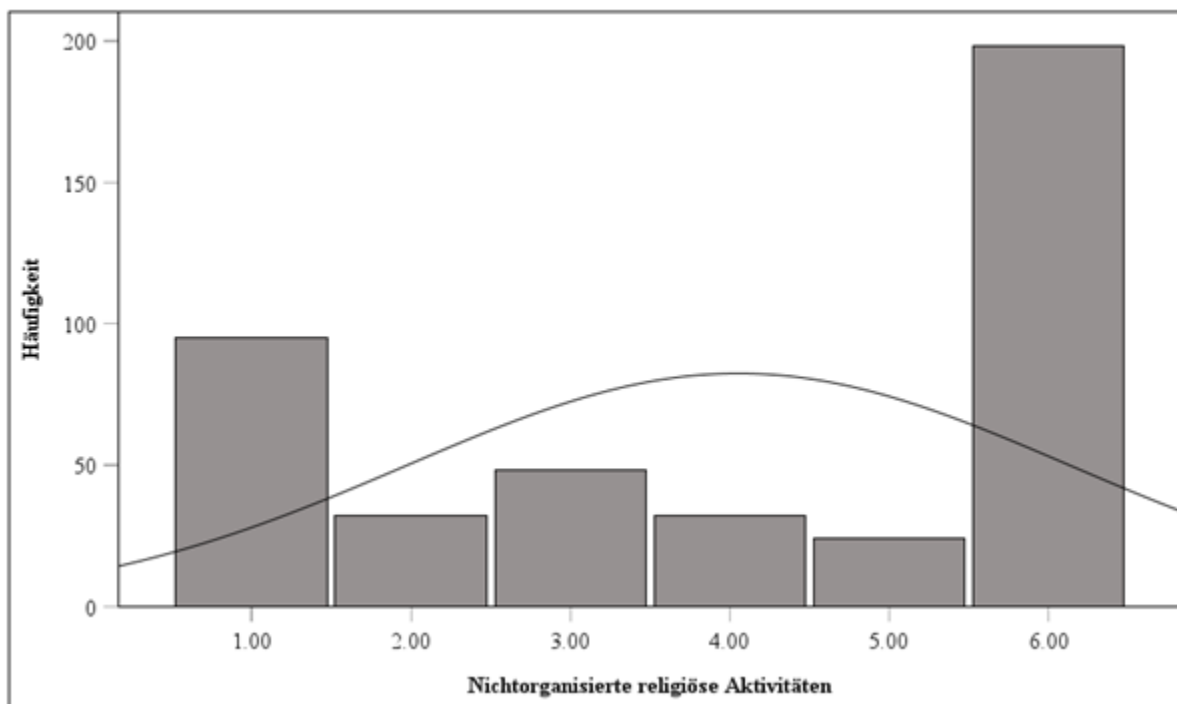


Abbildung 4. Verteilung der DUREL-Subskala Nichtorganisierte religiöse Aktivitäten

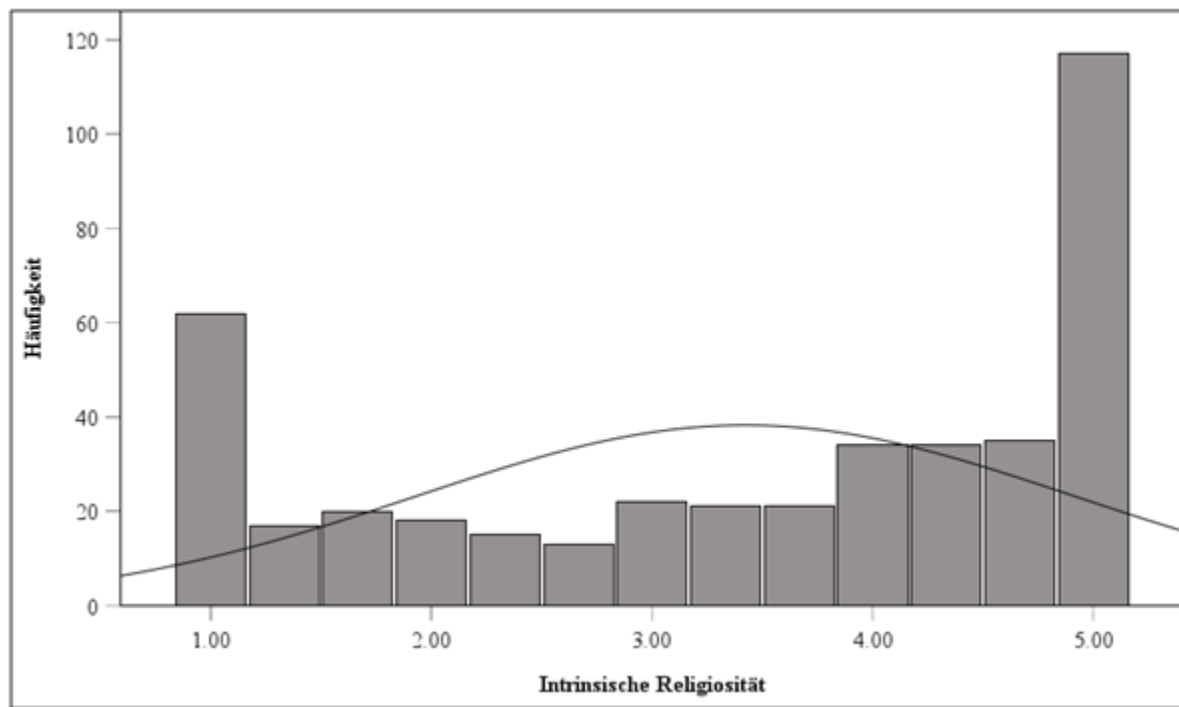


Abbildung 5. Verteilung der DUREL-Subskala Intrinsische Religiosität

Anhang D

Verteilung des WHO-5 und Boxplot zur Erfassung der Ausreißer

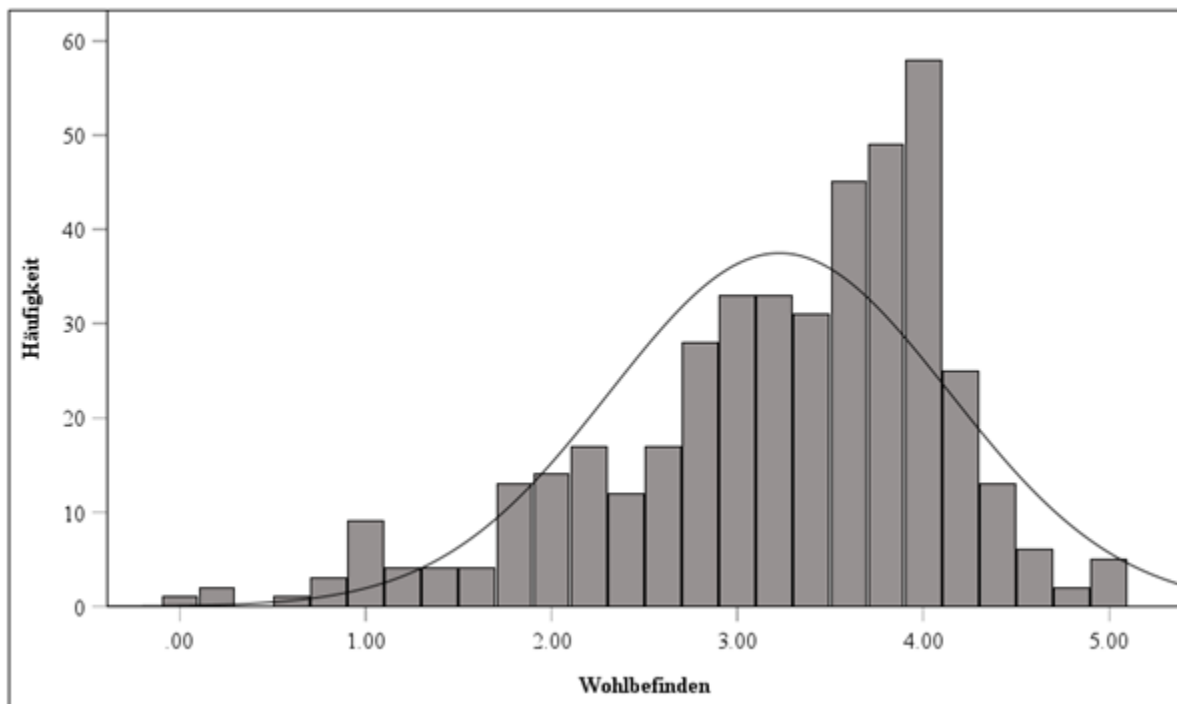


Abbildung 6. Verteilung des WHO-5

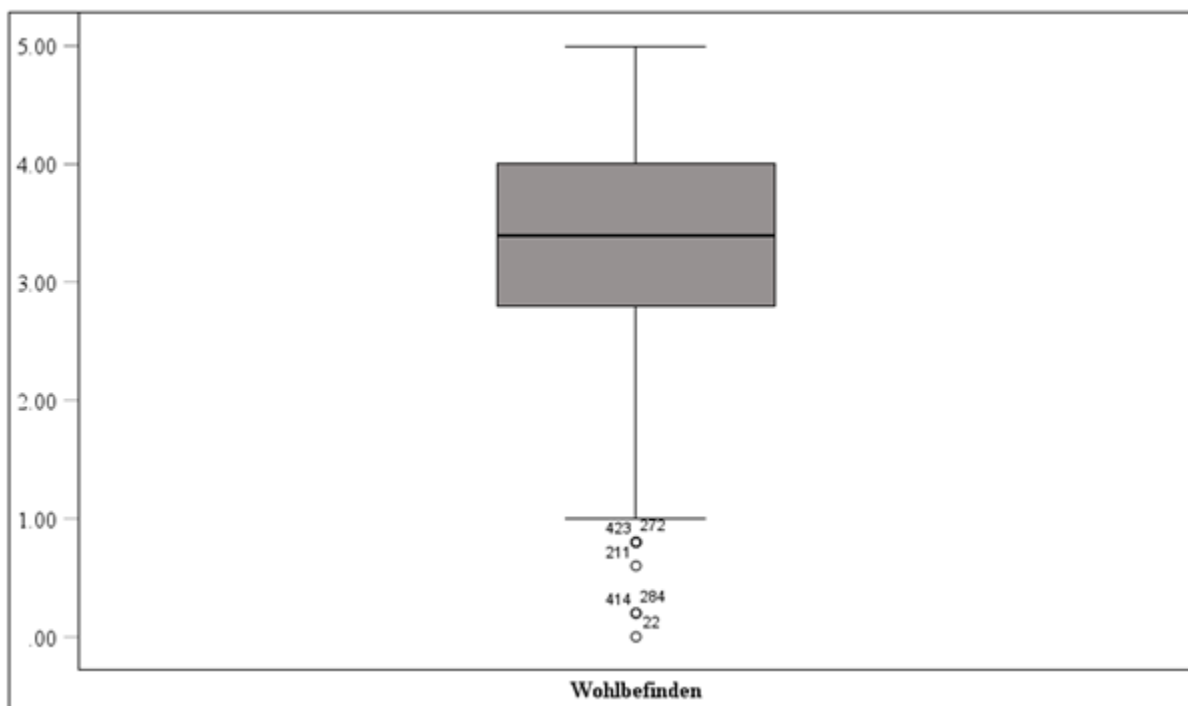


Abbildung 7. Boxplot zur Erfassung der Ausreißer

Anhang E

Verteilung der kulturellen Orientierung und Boxplot zur Erfassung der Ausreißer

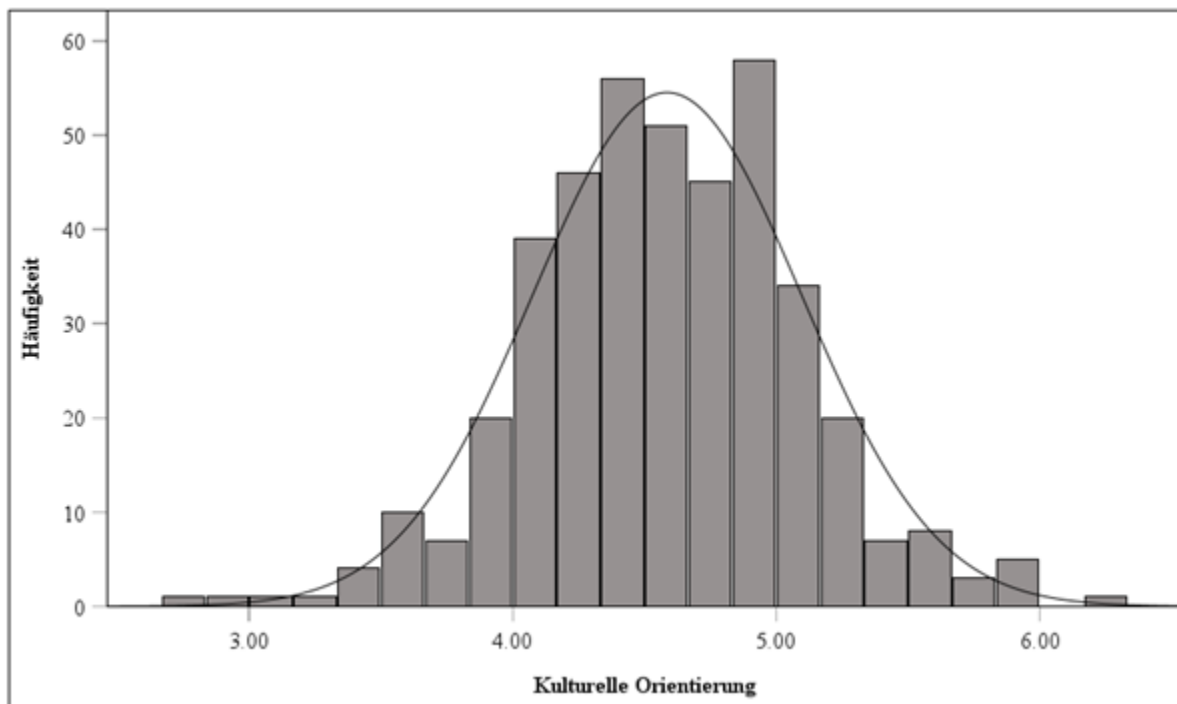


Abbildung 8. Verteilung der kulturellen Orientierung

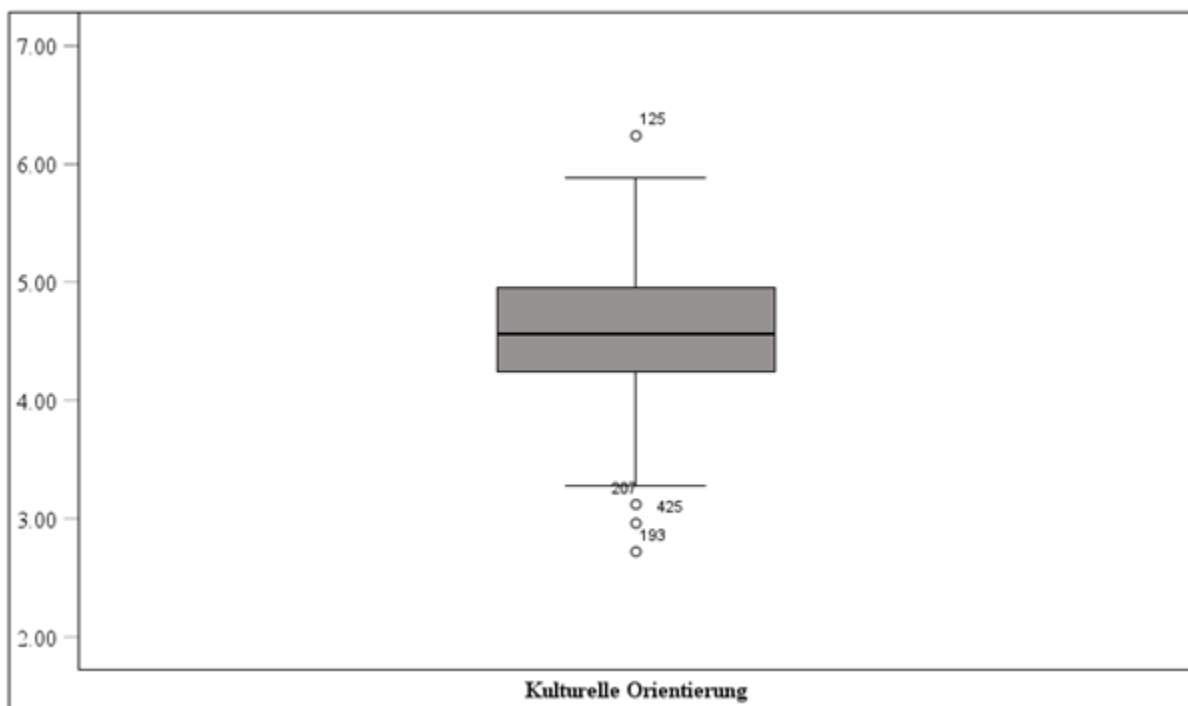


Abbildung 9. Boxplot zur Erfassung der Ausreißer

Anhang F

Voraussetzungen zur Berechnung der einfachen linearen Regression der H1

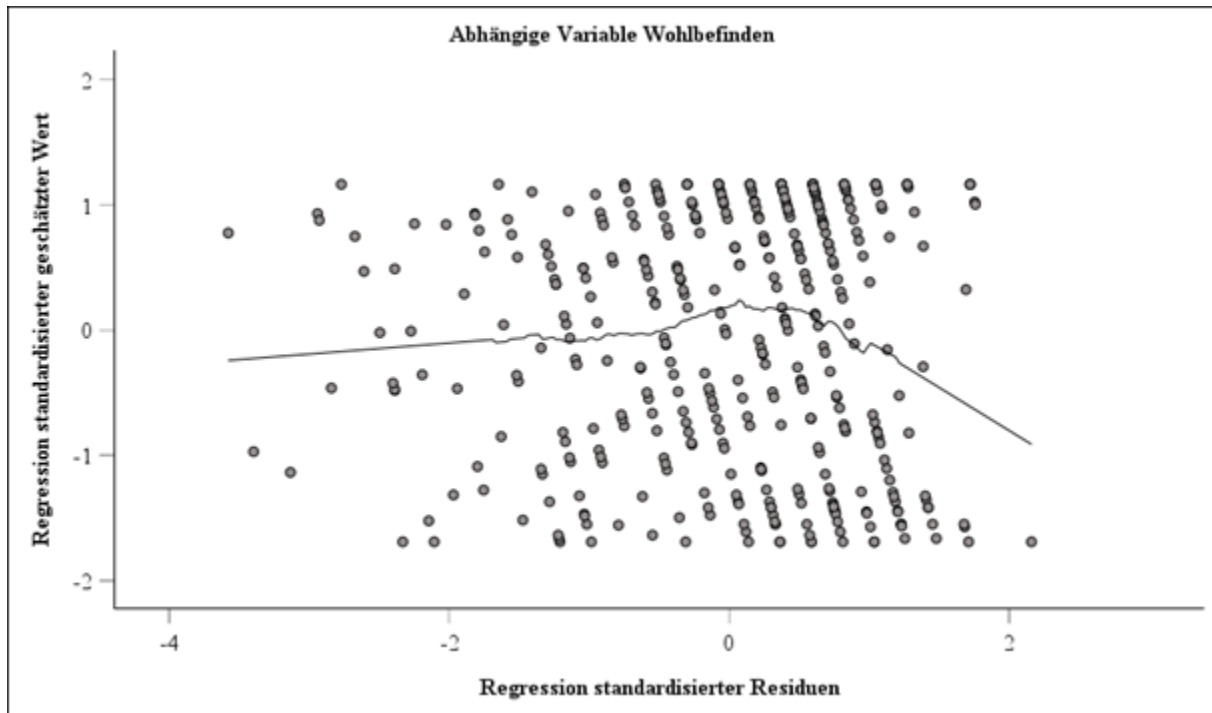


Abbildung 10. Streudiagramm zur Determinierung von Linearität und Homoskedastizität

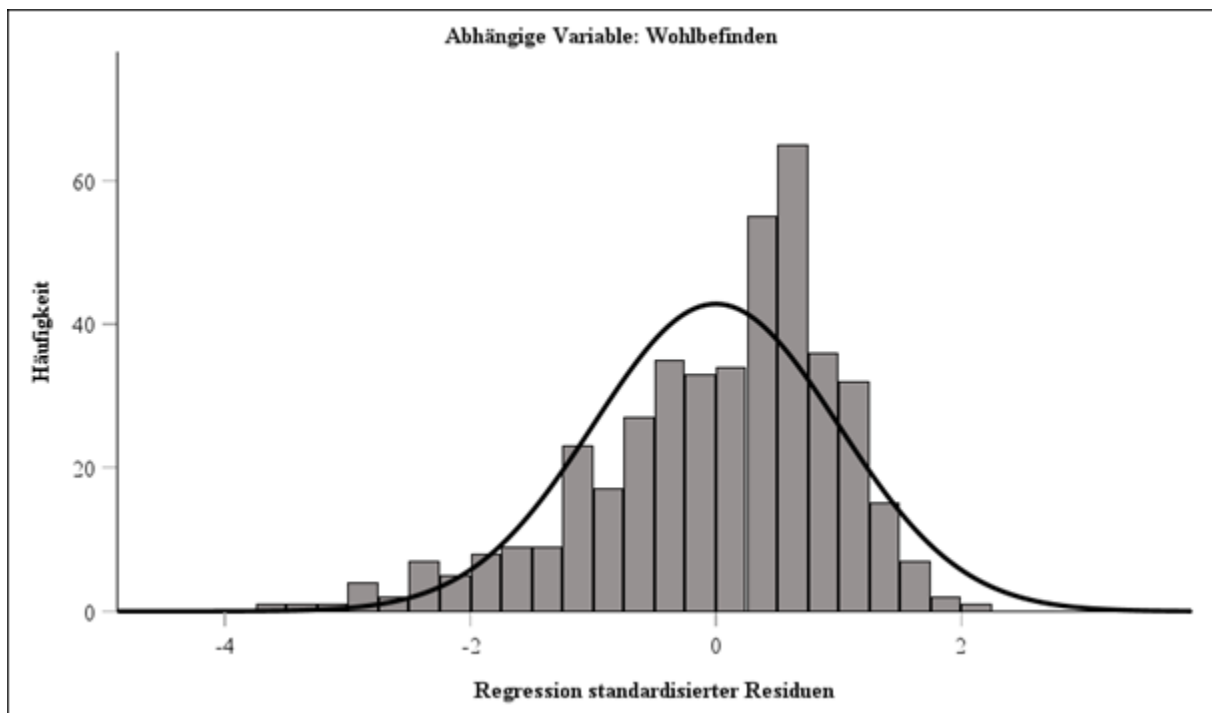


Abbildung 11. Normalverteilung der Residuen

Anhang G

Voraussetzungen zur Berechnung der Moderationsanalyse der H2

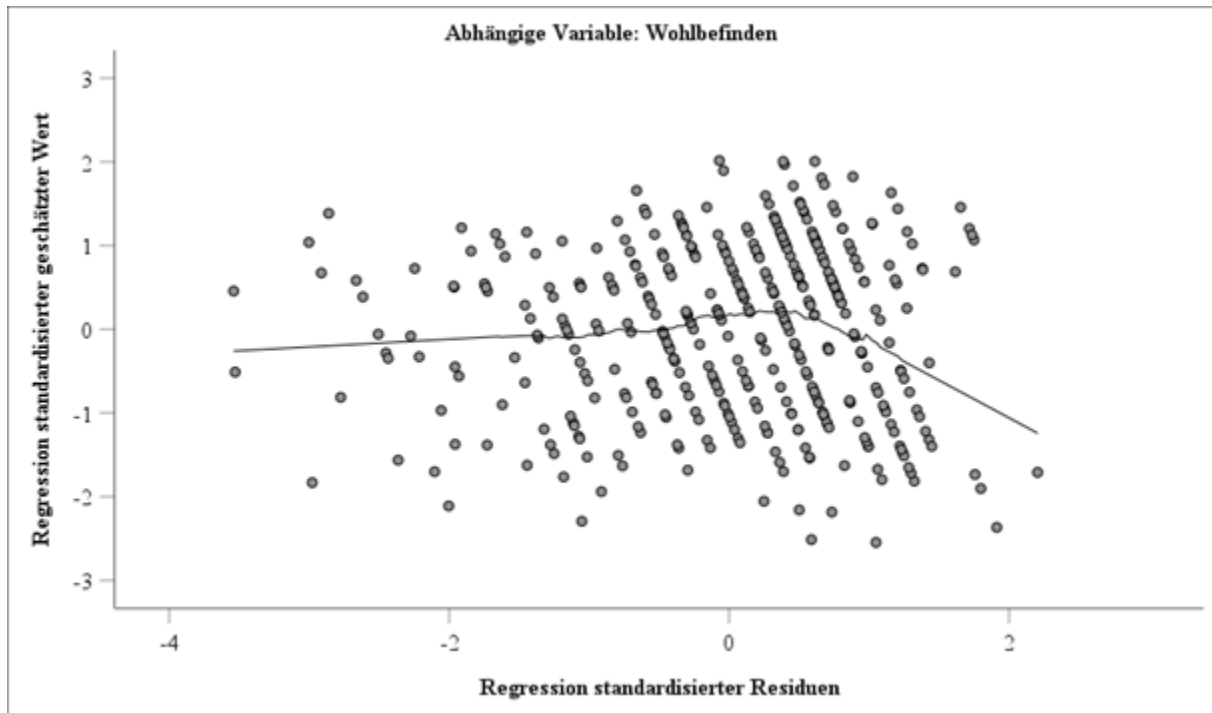


Abbildung 12. Streudiagramm zur Determinierung von Linearität und Homoskedastizität

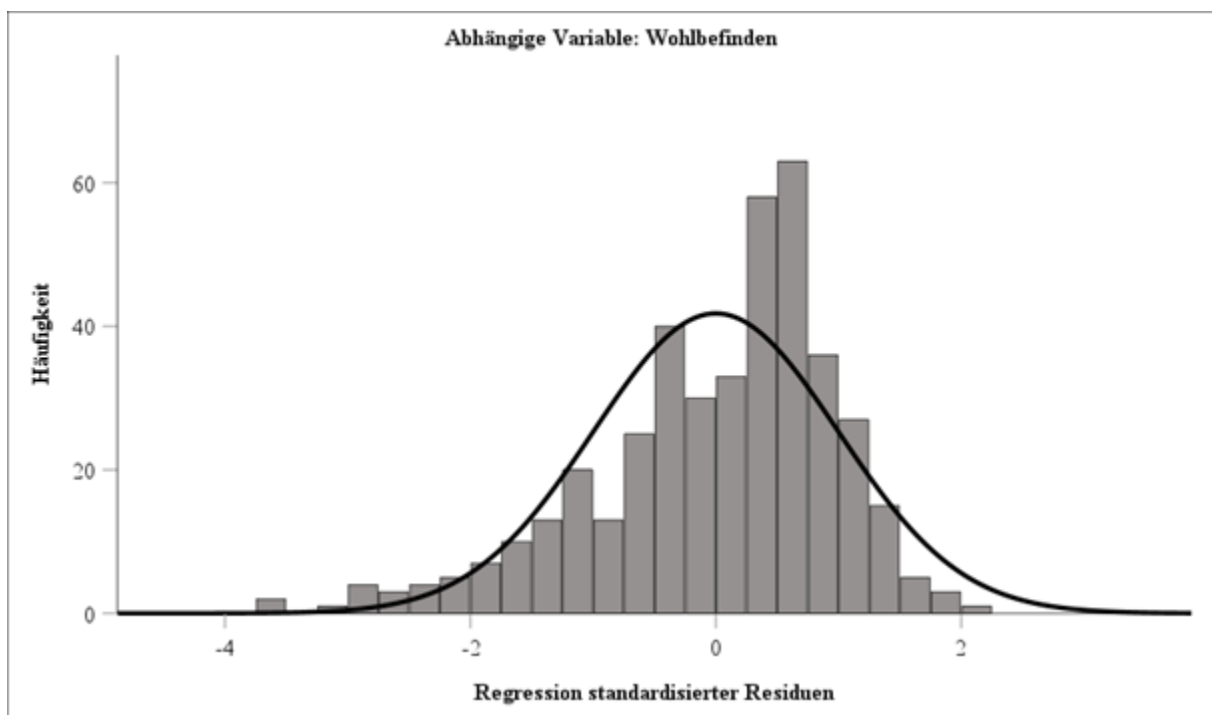


Abbildung 13. Normalverteilung der Residuen

Anhang H

Voraussetzungen zur Berechnung der Moderationsanalyse der H3

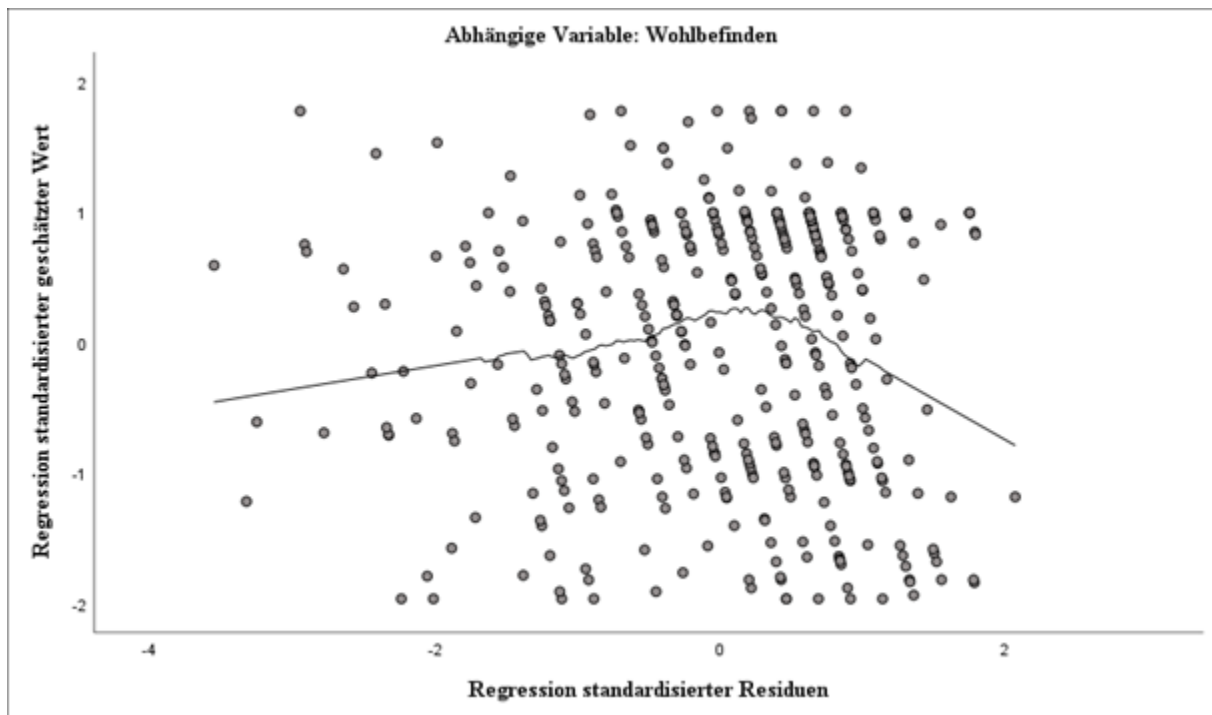


Abbildung 14. Streudiagramm zur Determinierung von Linearität und Homoskedastizität

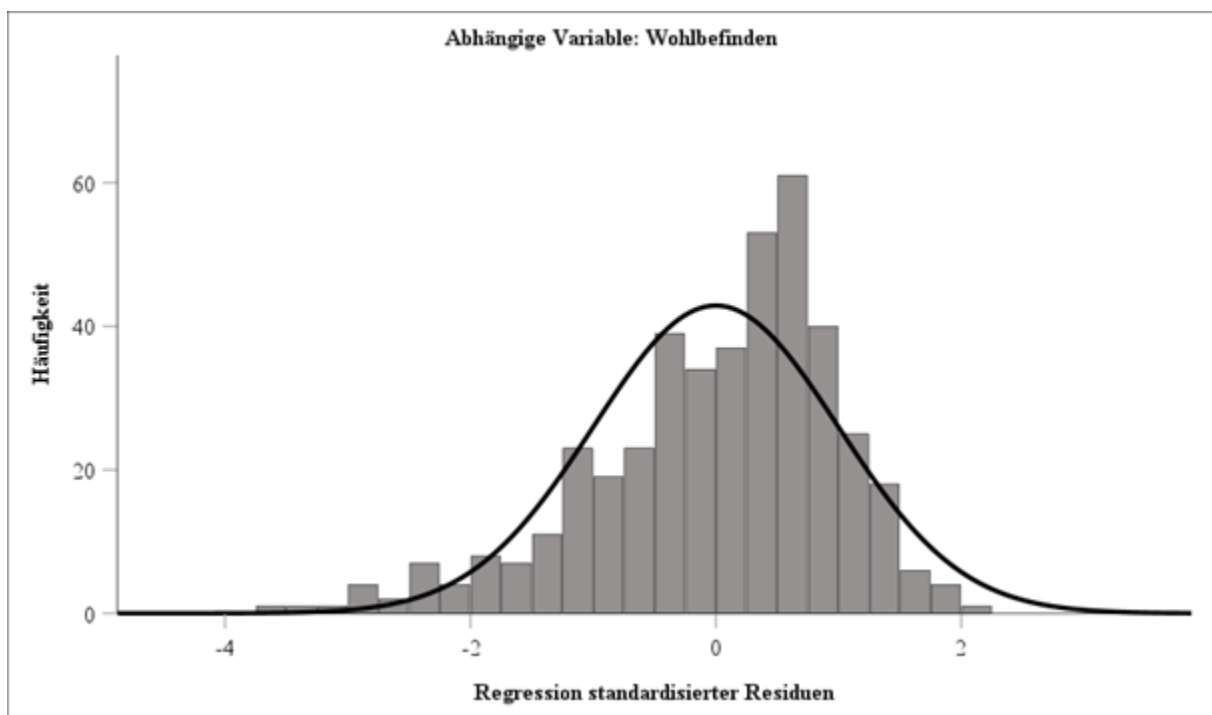


Abbildung 15. Normalverteilung der Residuen

Anhang I

Voraussetzungen zur Berechnung des ungepaarten t-Tests und der einfaktoriellen ANOVA

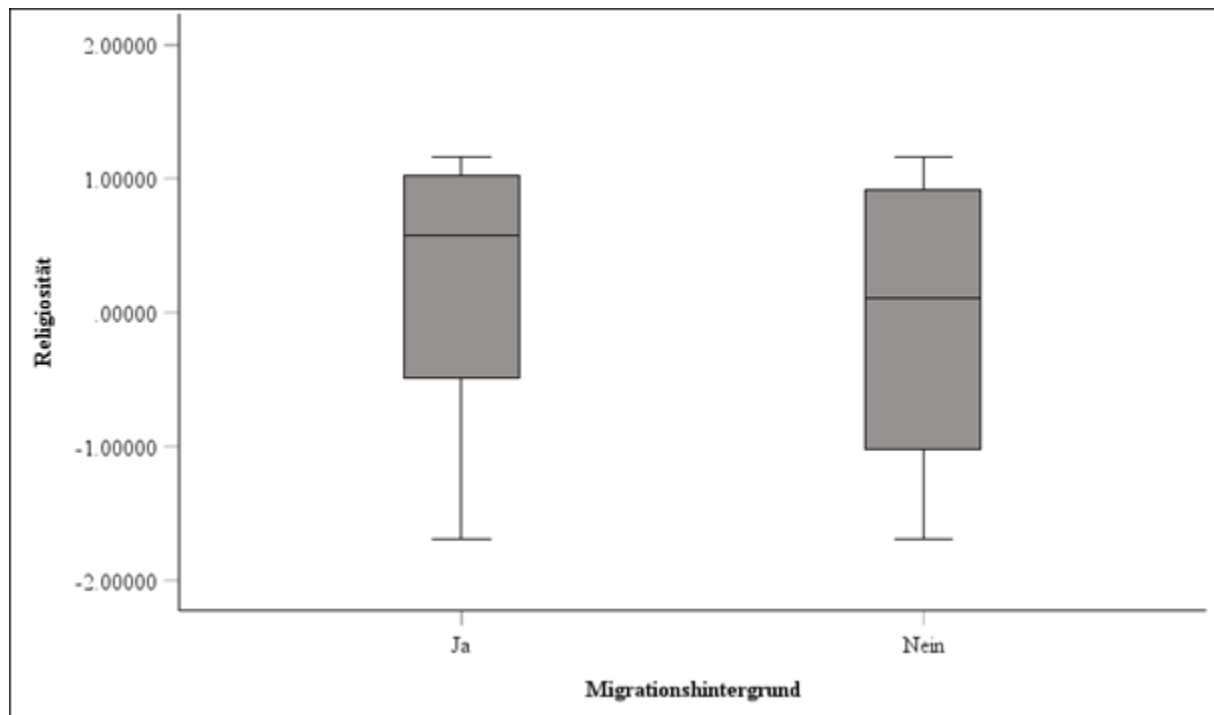


Abbildung 16. Boxplot zur Erfassung der Ausreißer zur Berechnung eines t-Test

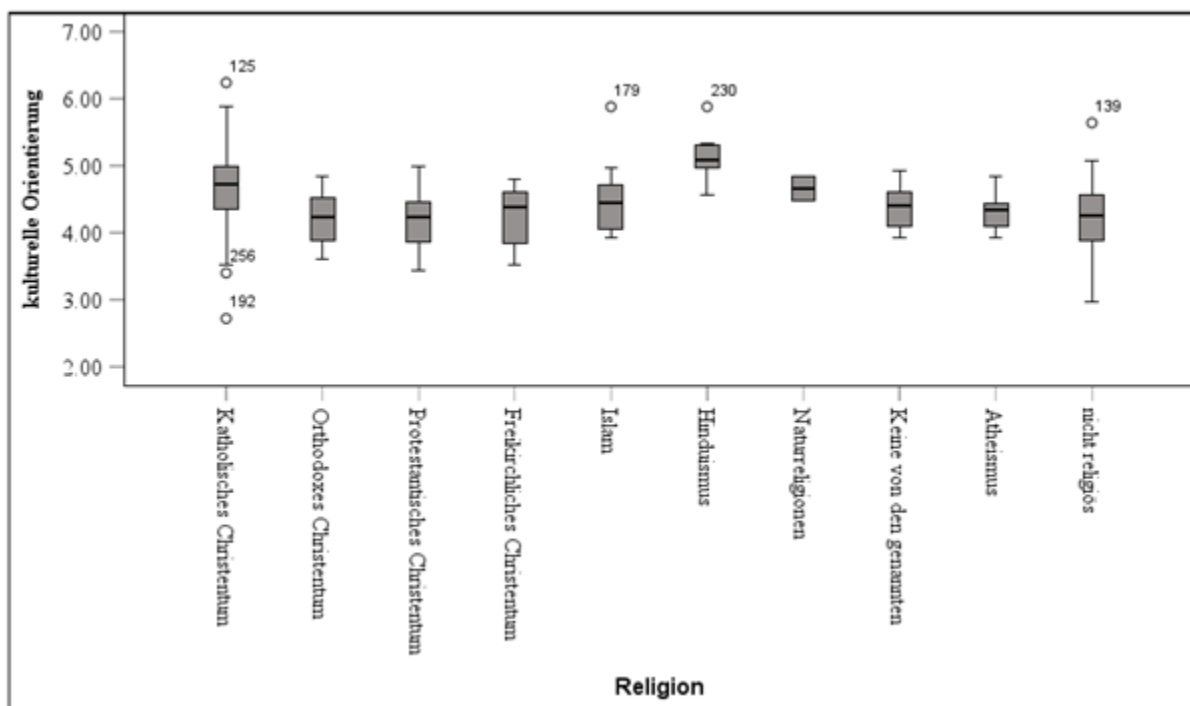


Abbildung 17. Boxplot zur Erfassung der Ausreißer zur Berechnung einer ANOVA

Anhang J

Bildaufnahmen des Online-Fragbogens

soSci
ofb - der onlineFragebogen

6% ausgefüllt

Guten Tag,

vielen Dank für Ihr Interesse an meiner Studie! Die Bearbeitungsdauer beträgt **ca. 10-15 Minuten**.

Inhalt der Studie: Bei dieser Studie handelt es sich um eine Masterthesis. Die Studie beschäftigt sich mit dem Zusammenhang zwischen Religiosität, Wohlbefinden und dem kulturellen Hintergrund. Hierfür werden Ihnen eine Reihe Fragen zu Ihrer Person gestellt. Anhand der gesammelten Daten beantworte ich meine Forschungsfrage. Für die Durchführung sind keinerlei Vorerfahrungen nötig und eine Teilnahme ist uneingeschränkt **ab einem Alter von 12 Jahren** möglich. Auch wenn Sie nicht einer Religionsgruppe angehören, oder nicht religiös sind, bitte ich Sie an der Umfrage teilzunehmen.

Nutzen der Studie: Für Sie hat die Studie unmittelbar keinen persönlichen Nutzen. Sie unterstützen jedoch mich bei meiner Masterthesis im Bereich Psychologie und der wissenschaftlichen Forschung.

Freiwilligkeit: Die Teilnahme an der Umfrage ist freiwillig. Sie können die Umfrage jederzeit durch Schließen des Browserfensters abbrechen, ohne dass Ihnen irgendeine Nachteil entsteht.

Datenschutz: Die im Rahmen dieser Studie erhobenen demografischen Daten sind nicht Personenbezogen. Eine Zuordnung zu einzelnen Personen ist nicht möglich. Nach Beendigung der Befragung können Ihre Daten nicht gelöscht werden, denn es kann nicht mehr nachvollzogen werden, welche Angaben von Ihnen stammen. Auf die erhobenen Daten habe nur ich Zugriff und sie werde ausschließlich für wissenschaftliche Zwecke (Masterthesis) verwendet. Die Daten werden vor unbefugtem Zugriff geschützt.

Kontakt: Sollten Sie Fragen haben, können Sie sich gerne an mich B.Sc. Teresa Seidl Fernández wenden (Teresa.SeidlFernandez@stud.hochschule-heidelberg.de)

Zuletzt möchte ich Sie darum bitten, den Link mit weiteren Personen zu teilen, um eine große Reichweite zu erreichen.

Vielen Dank für Ihre Teilnahme!

PS: Nutzer der Forschungsplattform SurveyCircle.com erhalten für ihre Teilnahme SurveyCircle-Punkte.

Weiter

Abbildung 18. Seite 1 des Online-Fragebogens

soSci
of b - der onlinefragebogen

17% ausgefüllt

1. Religiosität
Im Folgenden stelle ich Ihnen einige Fragen zu Ihrer Religiosität. Auch wenn Sie nicht religiös sind, möchte ich Sie bitten, diese Fragen zu beantworten.

	gar nicht	sehr
Wie religiös sind Sie?	☐	☐
Wie ausgeprägt leben Sie nach den Erfordernissen Ihrer Religion oder Ihres Glaubens?	☐	☐
Wie ausgeprägt glauben Sie an die Lehre Ihrer Religion oder Ihres Glaubens?	☐	☐
Wie wichtig schätzen Sie den Teil Ihrer Identität ein, den Ihre Religion oder Ihr Glaube ausmacht?	☐	☐
Wenn jemand Sie als Person verstehen möchte, wie wichtig wäre dabei Ihre Religion oder Ihr Glaube?	☐	☐

Weiter

Abbildung 19. Seite 2 des Online-Fragebogens (Deutsche Version der Religious Commitment Scale (Klumparendt & Drenckhan, 2014))

soSci
of b - der onlinefragebogen

33% ausgefüllt

2. Religiosität
Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen.

	Nie	Einmal im Jahr oder weniger	Einige Male im Jahr	Einige Male im Monat	Einmal pro Woche	Mehr als einmal pro Woche
Wie oft besuchen Sie die Kirche/Synagoge/Moschee oder andere religiöse Treffen?	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Wie oft widmen Sie sich privaten religiösen Aktivitäten wie Gebet, Meditation oder wie oft setzen Sie sich mit den Schriften Ihrer Religion auseinander?	☐	☐	☐	☐	☐	☐

	stimme überhaupt nicht zu	stimme wenig zu	neutral	stimme etwas zu	stimme vollkommen zu
In meinem Leben erfahre ich die Gegenwart des Göttlichen.	☐	☐	☐	☐	☐
Meine religiösen Überzeugungen sind das, was wirklich hinter meinem gesamten Lebensansatz steht.	☐	☐	☐	☐	☐
Ich bemühe mich sehr, meine Religion auch auf andere Lebensbereiche zu übertragen.	☐	☐	☐	☐	☐

Weiter

Abbildung 20. Seite 3 des Online-Fragebogens (DUREL (Koenig, Parkerson & Meador, 1997))



58% ausgefüllt

3. Wohlbefinden

Die folgenden Aussagen betreffen Ihr Wohlbefinden in den letzten zwei Wochen. Bitte markieren Sie bei jeder Aussage die Rubrik, die Ihrer Meinung nach am besten beschreibt, wie Sie sich in den letzten zwei Wochen gefühlt haben.

In den letzten zwei Wochen ...

	Die ganze Zeit	Meistens	Etwas mehr als die Hälfte der Zeit	Etwas weniger als die Hälfte der Zeit	Ab und zu	Zu keinem Zeitpunkt
... war ich froh und guter Laune	☐	☐	☐	☐	☐	☐
... habe ich mich ruhig und entspannt gefühlt	☐	☐	☐	☐	☐	☐
... habe ich mich energisch und aktiv gefühlt	☐	☐	☐	☐	☐	☐
... habe ich mich beim Aufwachen frisch und ausgeruht gefühlt	☐	☐	☐	☐	☐	☐
... war mein Alltag voller Dinge, die mich interessieren	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Weiter

Abbildung 21. Seite 4 des Online-Fragebogens (WHO-5 (WHO, 1998))



soSci
oFb - der onlinefragebogen

67% ausgefüllt

4. Sitten und Bräuche

Im Folgenden stelle ich Ihnen Fragen zu den Sitten und Gebräuchen in Deutschland. Ich möchte gerne Ihre Meinung wissen, wie üblich bzw. verbreitet bestimmte soziale Verhaltensweisen in Deutschland sind. Bitte antworten Sie möglichst spontan. Es gibt keine richtigen oder falschen Antworten, wichtig ist allein Ihre persönliche Meinung.

Bitte lesen Sie jede der folgenden Fragen gründlich durch und schätzen Sie die Häufigkeit ein, mit der das beschriebene Verhalten in Deutschland vorkommt.

	Überhaupt nicht	Sehr selten	Selten	Manchmal	Häufig	Sehr häufig	Immer
Wie häufig richten sich Jugendliche in Deutschland bei der Wahl ihres Freundes oder ihrer Freundin nach den Ratschlägen ihrer Eltern?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Wie häufig sprechen Jugendliche in Deutschland mit ihren Eltern über ihre Gedanken und neuen Ideen?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Wie häufig richten sich Jugendliche in Deutschland bei der Berufswahl nach dem Rat ihrer Eltern oder nahen Verwandten?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Wie häufig unterhält man sich in Deutschland mit seinen Nachbarn über die Politik?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Wie häufig sucht man in Deutschland bei Geldangelegenheiten den Rat von Freunden?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Wie häufig macht man in Deutschland im Beisein von Freunden oder Kollegen das, was man will, unabhängig davon, was die anderen davon halten könnten?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Wie häufig kommt es in Deutschland vor, dass man im Elternhaus wohnen bleibt, bis man heiratet?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Abbildung 22. Erster Teil von Seite 5 des Online-Fragebogens (COS (Bierbrauer, Meyer & Wolfradt, 2002))

Fühlt man sich in Deutschland gestört, wenn jemand unangemeldet zu Besuch kommt?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Kümmert man sich in Deutschland eher um einen kranken Familienangehörigen anstatt zur Arbeit zu gehen?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Wie häufig bespricht man sich in Deutschland erst mit seiner Familie, bevor man eine wichtige Entscheidung trifft?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Wie häufig bespricht man in Deutschland Probleme, die man mit seinem Beruf bzw. Studium hat, mit seinen Eltern?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Fühlen sich Menschen in Deutschland einsam, wenn sie nicht mit ihren Geschwistern oder Angehörigen zusammen sind?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Fühlen sich Menschen in Deutschland selbst beleidigt, wenn die eigenen Geschwister beleidigt wurden?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5. Soziale Verhaltensweisen							
Im folgenden Fragebogenteil möchte ich gerne Ihre Meinung hören, wie Sie bestimmte soziale Verhaltensweisen bewerten. Diese Fragen sind ähnlich, aber nicht identisch mit den Fragen des ersten Teils. Bitte antworten Sie wieder möglichst spontan. Es gibt keine richtigen oder falschen Antworten, wichtig ist allein Ihre persönliche Meinung.							
Bitte lesen Sie sich jede Frage gründlich durch und machen Sie jeweils den Grad Ihrer Zustimmung oder Ablehnung zu den einzelnen Aussagen deutlich.							
	Sehr schlecht	Schlecht	Eher schlecht	Weder gut noch schlecht	Eher gut	Gut	Sehr gut
Was halten Sie persönlich davon, wenn sich Jugendliche bei der Wahl ihres Freundes oder ihrer Freundin nach den Ratschlägen ihrer Eltern richten?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Was halten Sie davon, wenn Jugendliche mit ihren Eltern über ihre Gedanken und neuen Ideen sprechen?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Was halten Sie davon, wenn sich Jugendliche bei der Berufswahl nach dem Rat ihrer Eltern oder nahen Verwandten richten?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Abbildung 23. Zweiter Teil von Seite 5 des Online-Fragebogens (COS (Bierbrauer, Meyer & Wolfradt, 2002))

Was halten Sie davon, wenn man sich mit seinen Nachbarn über Politik unterhält?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Was halten Sie davon, wenn man in Geldangelegenheiten den Rat von Freunden sucht?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Was halten Sie davon, wenn man im Beisein von Freunden oder Kollegen das macht, was man will, unabhängig davon, was die anderen davon halten könnten?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Was halten Sie davon, wenn man solange im Elternhaus wohnen bleibt, bis man heiratet?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Was halten Sie davon, wenn man sich gestört fühlt, weil jemand unangemeldet zu Besuch kommt?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Was halten Sie davon, wenn man sich eher um einen kranken Familienangehörigen kümmert, anstatt zur Arbeit zu gehen?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Was halten Sie davon, wenn man sich erst mit seiner Familie bespricht, bevor man eine wichtige Entscheidung trifft?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Was halten Sie davon, wenn man Probleme, die man mit seinem Beruf bzw. Studium hat, mit seinen Eltern bespricht?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Was halten Sie davon, wenn sich Menschen einsam fühlen, wenn sie nicht mit ihren Geschwistern oder Angehörigen zusammen sind?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Was halten Sie davon, wenn man sich selbst beleidigt fühlt, weil die eigenen Geschwister beleidigt wurden?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Weiter							

Abbildung 24. Dritter Teil von Seite 5 des Online-Fragebogens (COS (Bierbrauer, Meyer & Wolfradt, 2002))

soSci
ofb - der onlinefragebogen

83% ausgefüllt

6.
Wie alt sind Sie?

Jahre

Bitte wählen Sie das Geschlecht aus, dass am ehesten zu Ihnen passt.

☐ männlich
☐ weiblich
☐ divers

Was ist Ihre aktuelle Tätigkeit?

☐ Schüler/in
☐ Student/in oder Auszubildende/r
☐ Berufstätig (angestellt)
☐ Berufstätig (selbstständig)
☐ Arbeitslos
☐ Rentner/in
☐ Hausfrau/-mann
☐ Sonstiges

Abbildung 25. Erster Teil von Seite 6 des Online-Fragebogens

Was ist Ihr höchster Bildungsabschluss?

☐ Grundschule
☐ Haupt-/Realschule
☐ Abitur
☐ Berufsausbildung
☐ Bachelor-Abschluss
☐ Master-Abschluss
☐ Doktorgrad (Ph.D.)

Wo wohnen Sie?

☐ In der Stadt
☐ Auf dem Land

Was ist Ihr aktueller Beziehungsstatus?

☐ Single
☐ In einer Beziehung
☐ Verlobt/verheiratet
☐ Geschieden
☐ Andere
☐ Ohne Angabe

Abbildung 26. Zweiter Teil von Seite 6 des Online-Fragebogens

Welcher Religion gehören Sie an?

- ☐ Katholisches Christentum
- ☐ Orthodoxes Christentum
- ☐ Protestantisches Christentum
- ☐ Freikirchliches Christentum
- ☐ Islam
- ☐ Hinduismus
- ☐ Judentum
- ☐ Buddhismus
- ☐ Naturreligionen
- ☐ Keine von den genannten
- ☐ Atheismus
- ☐ nicht religiös

7.
In welchem Land leben Sie?

Sind Sie oder einer Ihrer Eltern oder Großeltern ausländischer Herkunft?

- ☐ Ja
- ☐ Nein

Abbildung 27. Dritter Teil von Seite 6 des Online-Fragebogens

8.
Wenn Sie oder einer Ihrer Eltern oder Großeltern ausländischer Herkunft sind: was sind die Herkunftsländer?

Wenn eine ausländische Herkunft vorliegt, welchem Land fühlen sie sich eher zugehörig?

keine Angabe  aktueller Wohnsitz _____ Herkunftsland

Weiter

Abbildung 28. Vierter Teil von Seite 6 des Online-Fragebogens



soSci
cfb - der onlinefragebogen

Vielen Dank für Ihre Teilnahme!

Ich möchte mich ganz herzlich für Ihre Mithilfe bedanken.
Ihre Antworten wurden gespeichert, Sie können das Browser-Fenster nun schließen.
Survey Code mit einem Klick einlösen: <https://www.surveycircle.com/EFZJ-SYHH-ZDYC-3CYD/>

Möchten Sie in Zukunft an interessanten und spannenden Online-Befragungen teilnehmen?

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie Ihre E-Mail-Adresse für das SoSci Panel anmelden und damit wissenschaftliche Forschungsprojekte unterstützen.

E-Mail:

Am Panel teilnehmen

Die Teilnahme am SoSci Panel ist freiwillig, unverbindlich und kann jederzeit widerrufen werden.
Das SoSci Panel speichert Ihre E-Mail-Adresse nicht ohne Ihr Einverständnis, sendet Ihnen keine Werbung und gibt Ihre E-Mail-Adresse nicht an Dritte weiter.
Sie können das Browserfenster selbstverständlich auch schließen, ohne am SoSci Panel teilzunehmen.

Abbildung 29. Seite 7 des Online-Fragebogens

Ehrenwörtliche Erklärung

Ich erkläre hiermit ehrenwörtlich, dass ich meine Thesis mit dem Thema „Einfluss der Religiosität auf das psychische Wohlbefinden unter Berücksichtigung des kulturellen Hintergrundes“ selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel – insbesondere keine im Quellenverzeichnis nicht benannten Quellen – genutzt habe.

Wörtlich oder dem Sinn nach aus anderen Werken entnommene Stellen sind unter Angabe der Quellen kenntlich gemacht. Dies betrifft in gleichem Umfang die von Künstlicher Intelligenz (KI) zur Texterstellung genutzten Quellen. Ich versichere, dass im Fall der Verwendung von KI-Zitaten eine eigenständige, nachprüfbare Quell- bzw. Antwortsicherung erfolgt ist, welche die wortwörtliche Aufgaben-/Fragestellung und Antwort enthält.

Ich versichere hiermit, dass die vorliegende Arbeit zuvor nicht in einem anderen Prüfungsverfahren eingereicht wurde und die eingereichte schriftliche Fassung vollständig der auf dem elektronischen Speichermedium bzw. der hochgeladenen elektronischen Fassung entspricht.

Ich bin mir bewusst, dass eine falsche Erklärung rechtliche Folgen haben wird. Außerdem bin ich damit einverstanden, dass die vorgelegte Arbeit mit Hilfe von Anti-Plagiatsoftware auf etwaige Übereinstimmungen mit fremden Quellen überprüft wird.

Heidelberg, den 9. August 2024

Unterschrift:

[Unterschrift 1]